

? ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ КАШЛЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СОСТАВЛЯЕТ

!+3 месяца в течение 2 лет подряд

!2 месяца в течение 2 лет подряд

!3 месяца в течение 1 года

!1 месяц в течение 1 года

? МОКРОТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КАТАРАЛЬНОМ БРОНХИТЕ БЫВАЕТ

!+слизистой

!«ржавой»

!розовой пенистой

!стекловидной

? ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

!+сухих хрипов

!звонких влажных мелкопузырчатых хрипов

!крепитации

!шума трения плевры

? ДЛИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПОРОКА СЕРДЦА ПРИ СТЕНОЗЕ УСТЬЯ АОРТЫ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЁТ ГИПЕРФУНКЦИИ

!+левого желудочка

!правого желудочка

!левого предсердия

!правого предсердия

? К ГИПЕРТРОФИИ И ДИЛАТАЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИВОДИТ

!+ перегрузка левого желудочка объёмом

!снижение коронарного кровотока

! перегрузка левого желудочка давлением

!уменьшение сердечного выброса

? У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЁЛЫМ АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ ХАРАКТЕРНЫМИЗМЕНЕНИЕМ, ВЫЯВЛЯЕМЫМ ПРИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+высокий градиент давления левый желудочек/аорта

!увеличение ударного объёма

!аортальная регургитация

!зона акинезии в области межжелудочковой перегородки

? «МИТРАЛИЗАЦИЕЙ» АОРТАЛЬНОГО ПОРОКА НАЗЫВАЮТ

!+компенсаторную гиперфункцию левого предсердия при снижении сократительной функции левого желудочка

!сочетание аортального и митрального стенозов

!присоединение митрального стеноза к уже существующему аортальному пороку вследствие повторной ревматической лихорадки

!сочетание стеноза устья аорты и пролапса митрального клапана

? БОЛЬНОМУ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ, ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ПАРОКСИЗМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИСТУПОВ АРИТМИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

!+Амиодарон

!Хинидин

!Дигоксин

!Лаппаконитина гидробромид (Аллапинин)

? ПРИ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕМ ПАРОКСИЗМЕ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ, ДЛЯЩЕМСЯ 2 ЧАСА, ПРАВИЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+активное восстановление синусового ритма в течение первых двух суток (вплоть до электроимпульсной терапии)

!назначение урежающей ритм терапии (бета-блокаторов) и наблюдение за больным при хорошей переносимости аритмии

!отказ от дальнейших попыток купирования приступа при неэффективности в/в введения Новокаинамида

!купирование пароксизма методом ЧПЭСС

? ТРЕТЬЕЙ А СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 3А)

СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1,73 М2)

!+ 45-59

!30-44

!15-29

!10-14

? ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 4) СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1,73 М2)

!+ 15-29

!45-59

! 30-44

!60-89

? ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМОМ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+ кашель

!кровохарканье

! одышка

!свистящее дыхание

? ПРИЗНАКОМ АВ-БЛОКАДЫ I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+ увеличение PQ более 200 мс

!постепенное удлинение PQ с последующим выпадением QRS

!+ независимые сокращения предсердий и желудочков

!выпадение QRS без постепенного удлинения PQ

? К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ III КЛАССА ОТНОСИТСЯ

!+ Амиодарон

!Хинидин

!Лидокаин

!Пропафенон

? СУХИЕ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ФЕНОМЕНОМ

!+ нарушения бронхиальной проходимости

!наличия жидкости в плевральной полости

!повышения воздушности лёгочной ткани

!уплотнения лёгочной ткани

? ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА СРЕДНЕТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

!+ОФВ1 от 60%до 80% от должных величин

!вариабельностью ПСВ< 20%

!ночными приступами удушья реже 1 раза в неделю

!ежедневными ночными приступами удушья

? ПО СПИРОГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ СТАДИИ ХОБЛ

!+4

!3

! 2

!5

? К ОСНОВНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ ХОБЛ ОТНОСЯТ

!+ сухие свистящие хрипы

!крепитацию

!влажные мелкопузырчатые хрипы

!влажные крупнопузырчатые хрипы

? ПОКАЗАТЕЛЕМ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ СТЕПЕНЬ НАРУШЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ПРИ ХОБЛ, ВЫСТУПАЕТ

!+ ОФВ1

!ФЖЕЛ

! ЖЕЛ

!ОФВ1/ФЖЕЛ

? ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

!+пиковой скорости выдоха

!дыхательного объёма

! жизненной ёмкости лёгких

!остаточного объёма

? ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+бронхогенный

!гематогенный

! лимфогенный

!травматический

? ПРИ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ КРЕПИТАЦИЯ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

!+ лучше в стадиях прилива и разрешения

!лучше в стадии красного опеченения

!лучше в стадии серого опеченения
!хорошо во всех стадиях

? К ОСНОВНОМУ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ КРУПОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

!+ гомогенное затемнение соответственно доле или сегменту
!картину ателектаза
! тяжистый лёгочный рисунок
!очаговые тени

? АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ СЕРДЦА ВКЛЮЧАЕТ

!+ усиление первого тона и диастолический шум
!ослабление первого тона и систолический шум
!неизменные тоны и «мягкий, дующий» систолический шум
!ослабление второго тона и диастолический шум

? ШУМ ПРИ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

!+ проводится в левую подмышечную область
!проводится на сонные артерии
!никуда не проводится
!проводится в яремную ямку

? В ОТНОШЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА

!+антибактериальная терапия должна проводиться парентерально
!кортикостероиды должны обязательно назначаться с первых дней лечения
!длительность антибактериальной терапии составляет 2 недели
!развитие миокардита является показанием к оперативному лечению

? ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ С ПОРАЖЕНИЕМ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА ВСТРЕЧАЕТСЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ В АРТЕРИЮ

!+ легочную
!селезеночную
!мезентериальную
!почечную

? У ЖЕНЩИНЫ 50 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ И СУХОЙ КАШЕЛЬ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ТЕРАПИИ ОТХАРКИВАЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ И АНТИБИОТИКАМИ, (НЕ КУРИТ, АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ НЕ ОТЯГОЩЕН, НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО). НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ КАШЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ

!+ ингибиторов АПФ
!блокаторов ангиотензиновых рецепторов
! диуретиков
!блокаторов кальциевых каналов

? БОЛЬНОЙ 48 ЛЕТ С УСТОЙЧИВЫМ ПОВЫШЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ АД ДО 160/100 ММ РТ. СТ. БЕЗ КАКИХ-ЛИБО КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ

!+изменение образа жизни и постоянную антигипертензивную терапию
!курсовой приём антигипертензивных препаратов
! приём препаратов короткого действия только при кризах
!изменение образа жизни и контрольное обследование через 6 месяцев

? К ПРЕПАРАТАМ, УЛУЧШАЮЩИМ СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА, ОТНОСЯТ

!+ Добутамин
!Атропин
!Атенолол
!Триметазидин

? К ТИПИЧНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСЯТ

!+ тромбоз коронарной артерии вследствие надрыва атеросклеротической бляшки !увеличение потребности миокарда в кислороде
! нарушение коронарной гемодинамики вследствие падения артериального давления
!врожденные особенности строения коронарных артерий

? ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

!+наркотические анальгетики
!ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа
!анальгетики-антипиретики
!селективные ингибиторы циклооксигеназы 2 типа

? ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИШЕМИИ МИОКАРДА НА ЭКГ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

!+сегмента ST
!зубца Р
! комплекса QRS
!интервала PQ

? К ТИПИЧНЫМ ЖАЛОБАМ ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТ

!+давящие боли за грудиной, возникающие при физической нагрузке
!колющие боли в области левой лопатки
! тупые ноющие боли в правой половине грудной клетки
!иррадиацию боли в правую руку

? ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

!+ гиперхолестеринемия
!нарушение ритма и проводимости сердца
!врожденный порок сердца
!артериальная гипотония

? ДЕЙСТВИЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕНО

!+прямым миолитическим действием на гладкую мускулатуру коронарных артерий
!рефлекторным увеличением частоты сердечных сокращений
! снижением сократимости левого желудочка
!рефлекторным урежением частоты сердечных сокращений

? К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ДИЕТЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

!+ ограничение потребления жидкости
!ограничение потребления сахара
! ограничение потребления белков
!увеличение в рационе поваренной соли

? ЗАСТОЙ ПО МАЛОМУ КРУГУ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИВОДИТ К

!+ отеку легких
!почечной недостаточности
! асцит
!отекам голеней

? К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЖАЛОБАМ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

!+ одышку
!головную боль
! боли в суставах
!ноющие боли в области сердца

? ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ» СТАВИТСЯ ПРИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ (МЕС.)

!+ 6
!1
!3
!9

? ПО КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКИЕ ГЕПАТИТЫ БЫВАЮТ

!+ инфекционные
!травматические
! алиментарные
!системные

? К ПРОЯВЛЕНИЯМ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ ОТНОСЯТ

!+ артралгию
!кольцевидную эритему
! реактивный гастрит
!асцит

? ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВКЛЮЧАЮТ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

!+ гамма-ГТ и щелочной фосфатазы
!АЛТ
!АСТ
!АЛТ и АСТ

? К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЮЩИМ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С, ОТНОСЯТ

!+ гепатоцеллюлярную карциному
!рак желудка
! рак легких
!лимфому

? ГИПЕРСПЛЕНИЗМОМ НАЗЫВАЮТ

!+ интенсификацию элиминации форменных элементов крови
!увеличение размеров селезенки
! расширение диаметра селезеночной вены
!интенсификацию кровоснабжения селезенки

? ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ

!+расширения вен нижней трети пищевода
!расширения подкожных вен нижних конечностей
! гепатомегалии
!спленомегалии

? О РАЗВИТИИ РАКА ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА МОЖНО ПОДОЗРЕВАТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ В КРОВИ

!+ альфа-фетопротеина
!АСТ
!иммуноглобулина А
!холинэстеразы

? ДИАГНОЗ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ» ПОДТВЕРЖДЕН ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ

!+ нарушенного долькового строения
!ступенчатых некрозов гепатоцитов
! стеатоза гепатоцитов
!расширенных портальных трактов

? ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕЧЕНОЧНУЮ ЭНЦЕФАЛОПАТИЮ СЛЕДУЕТ ПРИ

!+ «печеночном» запахе
!нарастании интенсивности желтухи
! лихорадке
!геморрагическом диатезе

? САМЫМ БЫСТРЫМ ТЕМПОМ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

!+ аутоиммунном (люпоидном) гепатите
!хроническом вирусном гепатите В
! хроническом вирусном гепатите С
!алкогольной интоксикации

? К ФАКТОРАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЫЗЫВАЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕ КЛУБОЧКОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ, ОТНОСЯТ

!+ комплемент
!В-лимфоциты
! тучные клетки
!эозинофилы

? ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+острая сердечная недостаточность
!пиелонефрит
!инфаркт миокарда
!тромбоз легочной артерии

? В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК ОТРАЖАЕТ УРОВЕНЬ

!+ креатинина
!мочевины
! остаточного азота
!мочевой кислоты

? СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАССЧИТЫВАЮТ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛЫ

!+Кокрофта - Голта
!Зимницкого
! Каковского - Аддиса
!Сельдингера

? ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕМА ДЛЯ РУК НА ТЫЛЕ КИСТЕЙ ПОЯВИЛИСЬ УЧАСТКИ ПОКРАСНЕНИЯ, ОТЕЧНОСТИ, МЕЛКИЕ ПУЗЫРЬКИ, А ТАКЖЕ ЭРОЗИИ С ОБИЛЬНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ СЕРОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

!+ аллергического дерматита
!микробной экземы
! простого дерматита
!токсидермии

? К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДИСКОИДНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ОТНОСЯТ

!+лицо
!предплечья, голени
! грудь
!волосистая часть головы

? МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ СУБСТРАТАМИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЮТСЯ

!+хроническая эрозия, язва, крипт-абсцессы
!специфические гранулемы
! лимфоцитарные гранулемы
!рубцовые изменения кишечника

? ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА В ФАЗЕ ОБОСТРЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+ изъязвление и гиперемия слизистой оболочки кишки
!сужение просвета кишки
!тотальная атрофия слизистой оболочки
!геморроидальный узел

? ВОСПАЛЕНИЕ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЗАТРАГИВАЕТ

!+слизистую оболочку
!все слои кишки
! подслизистую оболочку
!мышечную оболочку

? В СТАДИИ РЕМИССИИ ПРИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

!+неизменная слизистая оболочка
!слизистая в виде «булыжной мостовой»
! слизистая с эрозиями
!контактная кровоточивость слизистой оболочки

? ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА ПОРАЖАЮТСЯ

!+ все слои кишечника
!слизистый и подслизистый слои
! подслизистый и мышечный слои
!мышечный слой и серозная оболочка

? ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+ вздутие живота и понос при употреблении злаков
!рвота с примесью желчи
!неустойчивый стул при употреблении молочных продуктов
!запор

? ПРИМЕНЕНИЕ ВАГУСНЫХ ПРОБ МОЖЕТ ПРЕРВАТЬ ПРИСТУП

!+ предсердной пароксизмальной тахикардии
!фибрилляции желудочков
!фибрилляции предсердий
!желудочковой пароксизмальной тахикардии

? ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРИ МАЛЕЙШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ДАВЯЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, КУПИРУЮЩЕЙСЯ ПРИЕМОМ НИТРОГЛИЦЕРИНА, СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О СТЕНОКАРДИИ

!+ напряжения функциональный класс IV
!напряжения функциональный класс III
! прогрессирующей
!вариантной

? НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+ выявление бактериурии
!выявление антител к базальной мембране клубочков
! наличие гематурии
!наличие протеинурии

? СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ УМЕНЬШЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА И/ИЛИ КОЛИЧЕСТВА

ЭРИТРОЦИТОВ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- !+ анемией
- !агранулоцитозом
- ! микроцитозом
- !макроцитозом

? ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА (Г/Л)

- !+70-89
- !90-120
- ! менее 70
- !90-130

? РЕАБСОРБЦИЯ ПРОФИЛЬТРОВАВШЕГОСЯ БЕЛКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ В

- !+проксимальном канальце
- !петле Генле
- !дистальном извитом канальце
- !собирающей трубке

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ

- !+ суточной протеинурии более 3,5 г
- !отёков
- !уровня сывороточного альбумина ниже 30 г/л
- !гиперхолестеринемии

? НАИМЕНЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+поликистоз почек
- !гломерулонефрит
- !миеломная болезнь
- !диабетическая нефропатия

? ДЫХАНИЕ СО СТРИДОРОМ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- !+ бронхиальной астме
- !опухоли крупных бронхов
- !опухоли гортани
- !аспирации инородного тела

? ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

- !+ коленные
- !лучезапястные
- ! челюстно-лицевые
- !пястно-фаланговые

? В ДИАГНОСТИКЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

- !+ антитела к цитрулинированному пептиду
- !повышенного уровня мочевой кислоты
- ! диспротеинемии
- !анемии

? В ЭТИОЛОГИИ ПЕРВИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

- !+ генетический фактор
- !реактивный артрит в анамнезе
- ! гиперурикемия
- !травма сустава

? УЗЕЛКИ БУШАРА ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ ОСТЕОАРТРОЗА

- !+ проксимальных межфаланговых суставов кисти
- !дистальных межфаланговых суставов кисти
- ! первого плюснефалангового сустава
- !локтевого сустава

? ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ РЕТИКУЛОЦИТОВ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- !+ хронической кровопотери
- !апластической анемии
- ! хронической свинцовой интоксикации
- !дефицита эритропоэтина

? ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА НАЛИЧИЕ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПЕРТИРЕОЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

- !+ снижение тиреотропного гормона

!повышение тиреотропного гормона
повышение тироксина
!снижение тироксина

? НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+ определение уровня ферритина
!расчет цветового показателя
! определение количества эритроцитов
!определение уровня гемоглобина

? СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

!+ извращением вкуса (pica chlorotica)
!кожным зудом
!прогрессированием онихомикоза
!изменением дистальных фаланг пальцев по типу барабанных палочек

? НА СТАДИИ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЯВЛЯТЬСЯ

!+снижение сывороточного железа
!снижение уровня гемоглобина
! снижение гематокрита
!ретикулоцитоз

? ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

!+ повышение общей железосвязывающей способности
!наличие мишеневидных эритроцитов
! микросфероцитоз
!снижение ОЖСС

? НА НАЛИЧИЕ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ УКАЗЫВАЕТ

!+ снижение пульсового артериального давления
!выраженная гипертрофия миокарда левого желудочка
!грубый систолический шум на основании сердца с резким ослаблением II тона и обширной иррадиацией
!возникновение частых приступов стенокардии напряжения у больного с систолическим шумом над аортой

? ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЗНАЧАЮТ

!+ антикоагулянты
!Ацетилсалициловую кислоту
! Клопидогрел
!Тикагрелор

? НЕ СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМА

!+ отказ от госпитализации
!несоблюдение режима
! несоблюдение предписанного лечения
!несвоевременная явка на прием

? К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА У ПАЦИЕНТА 55 ЛЕТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ III СТАДИИ, ПЕРЕНЕСШЕГО НЕДАВНО ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОТНОСЯТ

!+ Р-адреноблокаторы
!тиазидные диуретики
!антагонисты кальция
!Моксонидин

? ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

!+аспирина
!антагонистов кальция
!сердечных гликозидов
!лидокаина

? МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОКАЗАНО, ЕСЛИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ОСЛОЖНЯЕТСЯ

!+расслаивающей аневризмой аорты
!ишемическим инсультом
! острым коронарным синдромом
!нарушением ритма сердца

? ПРИ ОРВИ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

!+ Парацетамола

!Ампициллина

! Бисептола

!Аспирина

? ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА ВКЛЮЧАЮТ

!+тошноту, рвоту, боли в эпигастрии, понос, запоры

!экстрасистолию, головную боль

!боли в области сердца

!потерю сознания, тахикардию

? МОНОТЕРАПИЯ АНГИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА

!+пациенту с АГ I степени с низким или средним риском сердечно-сосудистых осложнений

!пациенту с АГ I степени с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений

!пациенту с АГ II степени с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений

!всем пациентам с АГ I степени независимо от степени риска сердечно-сосудистых осложнений

? ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

!+ неселективные Р-адреноблокаторы

!антибиотики

! метилксантины

!симпатомиметики

? КУПИРОВАНИЕ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА НАЧИНАЕТСЯ С НАЗНАЧЕНИЯ

!+ нитроглицерина сублингвально

!нитратов внутривенно капельно

! спазмолитиков

!наркотических анальгетиков

? ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

!+ ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента

!антагонистов кальция (фенилалкиламинов)

!ингибиторов фосфодиэстеразы

!ингибиторов карбоангидразы

? ПРИ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕЙ СТЕНОКАРДИИ ТАКТИКА ВРАЧА- ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО ВКЛЮЧАЕТ

!+ снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома, аспирин, госпитализацию

!снятие ЭКГ, купирование болевого синдрома, амбулаторное лечение

!выдачу направления на плановую госпитализацию

!амбулаторное обследование

? ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ

!+ международное нормализованное отношение (МНО)

!время кровотечения

! тромбиновое время

!уровень ретикулоцитов

? ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ ЧЕРЕЗ

!+ 2-3 дня

!12 часов

! 1 сутки

!5 дней

? ПРЕДНАГРУЗКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

!+объёмом циркулирующей крови и тонусом вен

!количеством эритроцитов

! тонусом артериол

!уровнем АД

? ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ СОСТОИТ В

!+ поддержании гемостаза

!переносе антител

! переносе белков

!выработке тромбопоэтина

? ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+преходящее горизонтальное смещение сегмента ST на 1 мм и более
- !формирование отрицательного зубца T
- !появление блокады правой ножки пучка Гиса
- !появление предсердной экстрасистолы

? РАННИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+уменьшение индекса Тиффно
- !уменьшение пиковой скорости выдоха
- !увеличение объема форсированного выдоха за первую секунду
- !уменьшение жизненной ёмкости лёгких

? РАННИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+повышение уровня АЦЦП
- !узурация суставных поверхностей
- !появление ульнарной девиации суставов кисти
- !повышение уровня мочевой кислоты

? О СОСТОЯНИИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- !+относительная плотность мочи
- !гематурия
- !лейкоцитурия
- !протеинурия

? ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНЕВРИЗМЫ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+длительный подъем ST выше изолинии («застывшая» ЭКГ)
- !коронарный зубец T в соответствующих отведениях
- !снижение амплитуды зубца R в соответствующих отведениях
- !появление зубца Q в соответствующих отведениях

? ЭКГ-ДИАГНОСТИКУ ИНФАРКТА МИОКАРДА УСЛОЖНЯЕТ

- !+блокада левой ножки пучка Гиса
- !фибриляция предсердий
- !желудочковая экстрасистолия
- !атриовентрикулярная блокада 1 степени

? ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

- !+Амоксициллина (или защищенного аминопенициллина) или макролидов
- !тетрациклинов
- !цефалоспоринов
- !Гентамицина

? НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+снижение массы тела
- !снижение конечного диастолического давления в правом желудочке
- !снижение частоты сердечных сокращений
- !уменьшение размеров печени

? К НАСЛЕДСТВЕННЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ДИАТЕЗАМ ОТНОСИТСЯ

- !+болезнь Виллебранда
- !ДВС синдром
- !болезнь Вальденстрема
- !болезнь Маркиафавы Микели

? СУБСТРАТОМ ОПУХОЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

- !+гранулоциты
- !миелобласты
- !плазмочиты
- !эритрокарициты

? ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ГЕМОФИЛИИ А ОБУСЛОВЛЕН ДЕФИЦИТОМ

- !+VIII фактора
- !антитромбина III
- !протеина C
- !образования тромбоцитов

? ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ В БИОПТАТЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА

- !+клеток Березовского - Штернберга
- !плазматических клеток
- !моноцитов
- !лимфоцитов

? ДЕСТРУКЦИЯ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ

- !+множественной миеломе
- !талассемии
- !апластической анемии
- !эритремии

? ЛОКАЛИЗАЦИЯ АРТРИТА ПРИ ОБОСТРЕНИИ В ПЕРВОМ ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОМ СУСТАВЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- !+подагры
- !ревматоидного артрита
- !псориаза
- !болезни Рейтера

? СИНДРОМ УТРЕННЕЙ СКОВАННОСТИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- !+ревматоидного артрита
- !деформирующего остеоартроза
- !подагры
- !болезни Рейтера

? АУТОИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПАЛЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- !+ревматоидного артрита
- !подагры
- !остеоартроза
- !болезни Рейтера

? СИНДРОМ ДРЕССЛЕРА РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ

- !+острого инфаркта миокарда
- !внебольничной пневмонии
- !острого миокардита
- !острого гастрита

? РАННЯЯ ПОСТИНФАРКТНАЯ СТЕНОКАРДИЯ ВОЗНИКАЕТ ОТ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА

- !+после 24 ч - 4 недель
- !после 12 недель
- !через полгода
- !через год

? ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ КОРОНАРНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

- !+тромбоз
- !ишемия
- !некроз
- !амилоидоз

? ОСОБЕННОСТЬЮ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+снижение ударного объема и сердечного выброса
- !повышение фракции выброса левого желудочка
- !запаздывание открытия митрального клапана
- !уменьшение диастолического объема левого желудочка

? ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОПАТИИ РАЗВИВАЕТСЯ

- !+относительная коронарная недостаточность
- !неспецифический коронариит
- !спазм коронарных артерий
- !острый тромбоз коронарных артерий

? АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫПОТА В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+резкое ослабление дыхания
- !амфорическое дыхание
- !крепитация
- !шум трения плевры

? ТРЕУГОЛЬНАЯ ИНФИЛЬТРАТИВНАЯ ТЕНЬ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

!+ТЭЛА

!аспирационной пневмонии

!параанкрозной пневмонии

!шокового легкого

? ЗАТЯЖНОЙ НАЗЫВАЮТ ПНЕВМОНИЮ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ БОЛЕЕ

!+четыре недели

!двух недель

!двух месяцев

!шести месяцев

? ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

!+коробочный перкуторный звук

!удлиненный вдох

!влажные хрипы

!бронхиальное дыхание

? ПОТЕМНЕНИЕ МОЧИ, ИКТЕРИЧНОСТЬ КОЖИ И СКЛЕР, УВЕЛИЧЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ АНЕМИИ

!+гемолитической

!В12-дефицитной

!железодефицитной

!апластической

? ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+Helicobacter pylori

!нарушение диеты

!курение

!нарушение моторики желудка

? ДЛЯ СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+диарея

!рвота

!запор

!абдоминальная боль

? УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА НАБЛЮДАЕТСЯ КАК ВНЕКИШЕЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

!+болезни Крона

!дивертикулярной болезни кишечника

!псевдомембранозного колита

!синдрома раздраженного кишечника

? В ДИАГНОСТИКЕ ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЯВЛЯЕТСЯ

!+суточный мониторинг pH в пищеводе и желудке + эзофагогастроскопия

!определение Helicobacter pylori

!анализ кала на скрытую кровь

!рентгеноскопия пищевода и желудка

? ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЛЬПРОТЕКТИНА В КАЛЕ ВЫШЕ 300 МКГ/Г ПОДТВЕРЖДАЕТ ДИАГНОЗ

!+«болезнь Крона»

!«аскаридоз»

! «синдром раздраженного кишечника»

!«глютеновая энтеропатия»

? ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕЛ К ГЛИАДИНУ И ТКАНЕВОЙ ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

!+ глютеновой энтеропатии

!язвенном колите

!болезни Крона

!синдроме раздраженного кишечника

? БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

!+ингаляционные глюкокортикостероиды

!бета-2-агонисты

!метилксантины

!муколитики

? РЕФЛЕКТОРНОЕ КУПИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ВОЗМОЖНО ПРИ

!+суправентрикулярной тахикардии

!полной АВ-блокаде

!желудочковой тахикардии

!частой экстрасистолии

? К ПРЕПАРАТАМ ЗАМЕДЛЕННОГО МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА ОТНОСЯТ

!+хондропротекторы

!глюкокортикостероиды

!нестероидные противовоспалительные препараты

!цитостатики

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ИСПОЛЬЗУЮТ

!+Сульфасалазин

!Амоксициллин

!Тетрациклин

!Панкреатин

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ ИСПОЛЬЗУЮТ

!+Рабепразол

!Дротаверина гидрохлорид

!Лактулозу

!Рифаксимин

? В ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ НПВС ЛЕЖИТ

!+ингибирование активности циклооксигеназы

!ингибирование активности липооксигеназы

!блокада рецепторов простагландинов

!стимуляция циклооксигеназы

? ПРИ НАЛИЧИИ БРАДИКАРДИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+Амлодипин

!Верапамил

!Пропранолол

!Атенолол

? НИЖНИЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ОТВЕДЕНИЯХ

!+II, III, AVF

!I, AVL, V6

!V3-V4

!V1-V6, AVL, I

? К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

!+панцитопению

!гипохромию эритроцитов

!анизо-пойкилоцитоз

!лейкоцитоз и гипохромию эритроцитов

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ У БЕРЕМЕННЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

!+иАПФ и сартанов

!Метилдопы

!бета-адреноблокаторов

!антагонистов кальция

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

!+бета-адреноблокаторов

!ингибиторов АПФ

!антагонистов кальция

!сартанов

? ПРИ РАССЛАБЛЕНИИ АОРТЫ НА ФОНЕ АГ ПОКАЗАНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

!+бета-адреноблокаторы

!диуретики

!антагонисты кальция

!иАПФ и сартаны

? САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА КЛИМАТИЧЕСКИХ КУРОРТАХ ПРОТИВОПОКАЗАНО БОЛЬНЫМ С ДИАГНОЗОМ

!+«гипертоническая болезнь II ст., кризовое течение»
!«гипертоническая болезнь II ст., бескризовое течение»
!«ИБС. Постинфарктный кардиосклероз. СН I (NYHAII). Инфаркт перенесен более 1 года назад.»
!«ИБС. Стенокардия II ФК.»

? В ФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИБС ВХОДИТ

!+лечебная физкультура, дозированная ходьба, специальные физические тренировки
!лечебная физкультура, дозированная ходьба, занятия в фитнес-центрах
!только лечебная физкультура и дозированная ходьба
!только лечебная физкультура и занятия в фитнес-центрах

? ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ В АНАЛИЗАХ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

!+анемия, лейкоцитоз, ускорение СОЭ
!анемия, лейкопения, тромбоцитопения
!эритроцитоз, лейкоцитоз, тромбоцитопения
!лейкопения, лимфоцитоз, ускорение СОЭ

? ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО 66 ЛЕТ НА ПОХОЛОДАНИЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, БОЛИ ПРИ ХОДЬБЕ, СТИХАЮЩИЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ, СООТВЕТСТВУЮТ СИМПТОМАМ

!+атеросклероза бедренных артерий
!тромбофлебита вен нижних конечностей
!плоскостопия
!синдрома Рейно

? ДЛЯ ОСТЕОАРТРОЗА НЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

!+скованности в движениях утром в течение 120 минут
!деформации суставов
!механического типа болей
!ограничения подвижности суставов

? ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ СОКРАЩАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ

!+Холестирокина
!гастрина
!панкреатического сока
!секретина

? КОНЪЮГИРОВАННЫЙ (СВЯЗАННЫЙ) БИЛИРУБИН ОБРАЗУЕТСЯ В КЛЕТКАХ ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ ФЕРМЕНТА

!+глюкуронилтрансферазы
!лейцинаминопептидазы
!нуклеотидазы
!кислой фосфатазы

? ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

!+гемолитической анемии
!лейкоцитоза
!гиперхромной анемии
!абсолютной эозинофилии

? ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ

!+шейного отдела позвоночника
!поясничного отдела позвоночника
!крестцового отдела позвоночника
!крестцово-подвздошных сочленений

? ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

!+проксимальные межфаланговые
!первый и второй пястно-фаланговый
!плечевые
!дистальные межфаланговые

? ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ

!+пиковую скорость выдоха
!остаточный объем
!дыхательный объем
!жизненную емкость легких

? ДИАГНОЗ «ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ» МОЖЕТ БЫТЬ ТОЧНО УСТАНОВЛЕН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

!+более 20% бластных клеток в костном мозге

!более 20% бластных клеток в периферической крови
!при сочетании температуры, анемии и кровоточивости
!при наличии анемии в сочетании с тромбоцитопенией, болями в костях и температурой

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+стрептококк
!микоплазма
!гемофильная палочка
!клебсиелла пневмонии

? УРОВЕНЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ 3 СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК, СООТВЕТСТВУЕТ (МЛ/МИН)

!+30
!60
!20
!15

? ДОСТОВЕРНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПЕРФОРАЦИИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

!+свободный газ в брюшной полости
!высокое стояние диафрагмы
!пневматизация кишечника
!«чаши» Клойбера

? К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ АГРАНУЛОЦИТОЗА ОТНОСЯТ

!+некротическую ангину
!развитие сердечной недостаточности
!геморрагический синдром
!тяжелую анемию

? ПЕРЕХОД ХРОНИЧЕСКОГО ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО ГЕПАТИТА В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

!+варикозное расширение вен пищевода
!желтуха
!гипоальбуминемия
!энцефалопатия

? СИНТЕЗ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ЖЕЛЕЗАХ ЖЕЛУДКА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

!+париетальные клетки
!главные клетки
!нейроэндокринные клетки
!мукоциты

? ВСЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ АНЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ

!+гипохромными
!гиперхромными
!нормохромными
!макроцитарными

? ТРЕХРОСТКОВАЯ ЦИТОПЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

!+дефицита витамина B12
!железодефицитной анемии
!гемолитической анемии
!анемии хронического воспаления

? В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ДВС-СИНДРОМА ЛЕЖИТ

!+генерализованное повреждение эндотелия микрососудов
!повреждение адгезивных свойств тромбоцитов
!истощение и дефицит простациклина
!выработка антител к тромбоцитам

? К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ОТНОСЯТ

!+сердечную недостаточность
!боль в грудной клетке
!артериальную гипертензию
!обмороки

? КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ B12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВИТАМИНА B12 В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ

!+4-5 лет

!5-8 месяцев
!9-12 месяцев
!1 -2 года

? «Д»-ДИМЕР ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ ЛИЗИСА

!+фибрина
!Х фактора
!Тромбоцитов
!тромбина

? ОРГАНАМИ-МИШЕНЯМИ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮЩИМИСЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА - КОНОВАЛОВА, ЯВЛЯЮТСЯ

!+печень и мозг
!почки и лёгкие
!печень и лёгкие
!сердце и почки

? ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+эхокардиография
!электрокардиография
!фонокардиография
!рентгенография

? БОЛЬШОЕ ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ДВОЙНОЙ ТОН ТРАУБЕ, ШУМ ДЮРОЗЬЕ НА СОСУДАХ, БЫСТРЫЙ И ВЫСОКИЙ ПУЛЬС, ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ

!+недостаточности аортального клапана
!врожденных пороков сердца
!митрального стеноза
!трикуспидальной недостаточности

? ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО СУБАОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ

!+эхокардиографии
!ЭКГ с физической нагрузкой
!радионуклидного сканирования сердца
!рентгенографии органов грудной клетки

? ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ СЕРДЦА ВЛЕВО И ВНИЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ДИЛАТАЦИИ

!+левого желудочка
!правого предсердия
!правого желудочка
!левого предсердия

? НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ СТЕНОКАРДИИ НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ С

!+стенозом основного ствола левой коронарной артерии
!проксимальным поражением задней коронарной артерии
!дистальным поражением огибающей артерии
!проксимальным поражением огибающей артерии

? ФЕНОМЕН «ПЛЯСКА КАРОТИД» ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

!+недостаточности аортального клапана
!стенозе митрального клапана
!тетраде Фалло
!болезни Аддисона

? ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+депрессия ST более чем на 2 мм
!подъем сегмента ST более чем на 2 мм
!уменьшение вольтажа всех зубцов
!появление отрицательных зубцов Т

? НАРУШЕНИЕ КАНАЛЫЦЕВОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ МОЧИ В ПРОБЕ ПО ЗИМНИЦКОМУ 1012-1010 СООТВЕТСТВУЕТ

!+изостенурии
!гипостенурии
!нормостенурии
!гиперстенурии

? АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ГЕМОДИАЛИЗУ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+уровень К крови более 6,5 ммоль/л
- !уровень Na крови более 135 ммоль/л
- ! клубочковая фильтрация менее 25 мл/мин
- !суточный диурез менее 50 мл

? ОПИСАНИЮ «FACIES NEPHRITICA» СООТВЕТСТВУЕТ

- !+одутловатое, бледное лицо с отеками под глазами, припухшими веками, узкими глазными щелями
- !одутловатое, цианотичное лицо, с набуханием вен шеи, выраженным цианозом и отеком шеи
- !выраженный цианоз губ, кончика носа, подбородка, ушей
- !мёртвенно-бледное лицо с сероватым оттенком, запавшими глазами, заостренным носом, с каплями холодного профузного пота на лбу

? СИСТЕМНЫЙ КАПИЛЛЯРИТ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АЛЬВЕОЛ ЛЕГКИХ И БАЗАЛЬНЫХ МЕМБРАН ГЛОМЕРУЛЯРНОГО АППАРАТА ПОЧЕК ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ

- !+синдроме Гудпасчера
- !системной красной волчанке
- !болезни Рейно
- !синдроме Шегрена

? ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПЕРВИЧНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ ИМЕЕТ

- !+дефицит α_1 -антитрипсина
- !острое заболевание дыхательной системы
- !хроническая болезнь бронхолегочного аппарата
- !возрастная инволюция эластической ткани легких

? ПРИ СПИРОГРАФИИ ПАЦИЕНТА 58 ЛЕТ ВЫЯВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ЖЕЛ 50% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ОФВ1 40% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ИНДЕКС ТИФФНО 50%) СООТВЕТСТВУЮТ

- !+смешанному нарушению вентиляции
- !рестриктивному типу нарушения
- !бронхиальной обструкции
- !варианту нормы

? ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

- !+ревматоидного фактора
- !HbA-B27
- !антинейтрофильных цитоплазматических антител
- !антител к двуспиральной ДНК

? К ТИПИЧНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ОТНОСИТСЯ

- !+лейкопения
- !железодефицитная анемия
- !лейкоцитоз
- !тромбоцитоз

? ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ

- !эритематозных высыпаний
- !кольцевидной эритемы
- !узловой эритемы
- !папулезно-пустулезной сыпи

? К РАННИМ ПРИЗНАКАМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ОТНОСИТСЯ

- !+артрит
- !диастолический шум над аортой
- !узловатая эритема
- !систолический шум на митральном клапане

? ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+амилоидоз
- !общий атеросклероз сосудов
- !нарушение углеводного обмена
- !порфирия

? МАРКЕРОМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+антинуклеарный фактор
- !ревматоидный фактор
- !С-реактивный белок
- !HLA-B27 антиген

? КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ CREST-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+телеангиэктазия
- !проксимальная миопатия
- !поражение кишечника
- !поражение почек

? ПРИЗНАКОМ ДЕРМАТОМИОЗИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+супраорбитальный отек и гиперемия кожи около глаз
- !«бабочка» на лице
- !остеолиз ногтевых фаланг
- !деформация суставов

? ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ ИМЕЕТ

- !+высокая активность креатинфосфокиназы
- !повышение уровня острофазовых белков
- !умеренный лейкоцитоз
- !наличие гемолитической анемии

? НОСИТЕЛЬСТВО В27-АНТИГЕНОВ HLA СВОЙСТВЕННО

- !+болезни Бехтерева
- !ревматоидному артриту
- !синдрому Шегрена
- !дерматомиозиту

? СОСУДЫ КРУПНОГО КАЛИБРА ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ

- !+артериите Такаясу
- !болезни Бюргера
- !узелковом периартериите
- !геморрагическом васкулите

? ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕ-ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У МУЖЧИНЫ 65 ЛЕТ, КУРЯЩЕГО, НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ

- !+обследования трахеи и гортани
- !цитологического исследования мокроты
- !контрастного исследования пищевода
- !бронхоскопии

? НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ У 24-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ С ЛИХОРАДКОЙ, ОЗНОБОМ, БОЛЬЮ В ПОЯСНИЦЕ, УРОВНЕМ ГЕМОГЛОБИНА 7 Г/Л И ГАПТОГЛОБИНОМ НИЖЕ НОРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+«внутрисосудистый гемолиз»
- !«острая интермиттирующая порфирия»
- !«острая многолобинурия»
- !«внесосудистый гемолиз»

? ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ У МУЖЧИНЫ 68 ЛЕТ С ВЫЯВЛЕННОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ, СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ И ЛЕЙКОЦИТАМИ $84 \times 10^9/\text{л}$ (П/Я 2, С/Я 18, Л 72, М 8) ЯВЛЯЕТСЯ

- !+«хронический лимфолейкоз»
- !«идиопатический миелофиброз»
- !«хронический миелолейкоз»
- !«болезнь Ходжкина»

? ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ У БОЛЬНОЙ 28 ЛЕТ С ЖАЛОБАМИ НА МЫШЕЧНУЮ СЛАБОСТЬ, ЖАЖДУ, СТОЙКУЮ АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ, ГИПОКАЛИЕМИЮ, (РЕНИН ПЛАЗМЫ - 0) ЯВЛЯЕТСЯ

- !+«первичный альдостеронизм»
- !«реноваскулярная гипертензия»
- !«хронический пиелонефрит, вторичный альдостеронизм»
- !«феохромоцитома»

? ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СТЕНОЗА ПРИВАТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+шум плеска через 3-4 часа после приема пищи
- !рвота желчью
- !резонанс под пространством Траубе
- !видимая перистальтика

? ПРИ ПЕНЕТРАЦИИ ЯЗВЫ В ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

- !+амилазы
- !липазы

глюкозы
!щелочной фосфатазы

? ПРИ ГЕМОФИЛИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ
!+АЧТВ
!протеина S
!протеина C
!плазминогена

? ФИБРИЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
!+отсутствием зубцов Р
!частотой желудочковых комплексов более 120 в минуту
!наличием преждевременных комплексов QRS
!укорочением интервалов PQ

? ТЕМНАЯ И ЖЕЛТОВАТАЯ ОКРАСКА КОЖИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЗАВИСИТ ОТ
!+нарушения выделения урохромов
!повышения прямого билирубина
!повышения непрямого билирубина
!нарушения синтеза урохромов

? ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСУМКОВАННЫЙ ПЛЕВРИТ ПЕРЕД ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИЕЙ НУЖНО ПРОВЕСТИ
!+УЗИ
!бронхоскопию
!рентгеноскопию
!микроскопию мокроты

? ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ
!+синдроме Шегрена
!системной красной волчанке
!ревматоидном артрите
!системной склеродермии

? ЭОЗИНОФИЛИЯ ЧАЩЕ СОПУТСТВУЕТ
!+узелковому периартерииту
!ревматоидному артриту
!склеродермии
!подагре

? БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ
!+ингаляционные глюкокортикостероиды
!антихолинэргические препараты
!муколитические препараты
!бета-2-агонисты

? ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ, ПРИМЕНЯЮТ
!+Азитромицин
!Цефтриаксон
!Гентамицин
!Амоксициллин

? ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮТ ОСТРУЮ ПОЧЕЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
!+аминогликозиды
!пенициллины
!цефалоспорины
!макролиды

? ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
!+ограничение хлорида натрия до 1,5 г/сут
!увеличение потребления хлорида натрия
!увеличение количества потребляемой жидкости
!повышение потребления K+-содержащих продуктов

? АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ С НАИМЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТАХИАРИТМИЙ, ВЫЗВАННЫХ ДИГИТАЛИСНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ
!+Лидокаин
!Прокаиамид
!Пропранолол

!Верапамил

? ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ МОРФИНА ЯВЛЯЕТСЯ

!+отек легкого

!неукротимая рвота

!тахикардия

!тромбоэмболия легочной артерии

? МЕТОТРЕКСАТ ВЫЗЫВАЕТ ДЕФИЦИТ

!+фолиевой кислоты

!железа

!аскорбиновой кислоты

!йода

? ПРИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЮТ

!+Фуросемиду

!Маннитолу

!Спиронолактону

!Гидрохлортиазиду

? ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

!+наличие нефротического синдрома без выраженной гематурии и гипертонии

!отёки

!артериальная гипертония

!макрогематурия

? ПРИ ЛОКАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ КРУПНОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+трансклюминальная ангиопластика коронарных артерий

!консервативная терапия коронаролитическими препаратами

!разрушение атероматозной бляшки режущим баллоном

!операция аортокоронарного шунтирования

? ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ НА СРОКЕ 36 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ И НАРАСТАНИЕМ ГЕМОРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВКЛЮЧАЕТ

!+назначение кортикостероидов или иммуноглобулина

!плазмаферез с замещением свежзамороженной плазмой

!назначение винкристина

!терапию криопреципитатом

? В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

!+спазмолитические средства

!H₂-блокаторы гистамина

!сукралфат и его аналоги

!ингибиторы протонной помпы

? В ЛЕЧЕНИИ ГИПОКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

!+холекинетики

!антациды

!спазмолитики

!ингибиторы протонной помпы

? ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ ЦИТОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ФАЗЕ КОНСОЛИДАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ В СТАДИИ

!+ремиссии

!рецидива

!развернутой

!терминальной

? ОСНОВНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА У БОЛЬНЫХ С ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЯЗАН С

!+расширением периферической венозной системы

!расширением периферических артерий

!увеличением коронарного кровотока вследствие увеличения частоты сердечных сокращений

!замедлением ЧСС и снижением потребности миокарда в кислороде

? ЭЛИМИНАЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

!+константа скорости элиминации

!степень протеидизации

!биодоступность

!объем распределения

? СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВЛИЯЮТ НА ГЕМОДИНАМИКУ

!+уменьшая венозное давление

!увеличивая венозное давление

!уменьшая артериальное давление

!увеличивая конечное диастолическое давление

? АКТИВНОСТЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДЕСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ БЛОКИРУЕТ ПЕТЛЕВОЙ ДИУРЕТИК

!+Торасемид

!Фуросемид

!Этакриновая кислота

!Маннитол

? СПИРОНОЛАКТОН ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ (МГ)

!+100-300

!50-100

!25-50

!12,5-25

? ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ К НАЗНАЧЕНИЮ ПРИ

!+двустороннем стенозе почечных артерий

!снижении уровня креатинина

!симптомной гипертензии

!декомпенсации хронической сердечной недостаточности

? ЛИПОФИЛЬНО-ГИДРОФИЛЬНЫМ В1 АДРЕНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+Бисопролол

!Карведилол

!Метопролол

!Атенолол

? ОСНОВНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НИТРАТОВ ОБУСЛОВЛЕН

!+уменьшением венозного возврата к сердцу

!увеличением венозного возврата к сердцу

!увеличением сократительной способности миокарда

!уменьшением сократительной активности миокарда

? НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

!+протеинурия с суточной потерей более 3,5 г

!бактериурия

!лейкоцитурия

!гипоизостенурия

? НА РАННИХ СТАДИЯХ АМИЛОИДОЗА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ БИОПСИЯ

!+слизистой прямой кишки

!печени

!почек

!кожи

? ПОД ПРОБОЙ НЕЧИПОРЕНКО ПОНИМАЮТ

!+подсчет количества форменных элементов в единице объема мочи

!определение концентрационной функции почек

!определение количества форменных элементов в минутном объеме мочи

!определение неорганических веществ в моче

? ОСНОВНЫМ ЦИТОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА

!+миелопероксидазу

!В-глюкуронидазу

!АТФазу

!кислую фосфатазу

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ПРИЗНАКАМИ ДОСТАТОЧНО НАДЕЖЕН ПРОЦЕНТ ЛИМФОЦИТОВ В МИЕЛОГРАММЕ, СОСТАВЛЯЮЩИЙ БОЛЕЕ

!+30

!20
!10
!40

? НАЛИЧИЕ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ХРОМОСОМЫ ХАРАКТЕРНО
ДЛЯ

!+хронического миелолейкоза
!сублейкемического миелоза
!острого эритромиелоза
!острого миеломоноцитарного лейкоза

? МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ПРЕДСТАВЛЕН

!+плазмócитами
!лимфоцитами
!макрофагами
!эозинофилами

? К ИЗМЕНЕНИЯМ В КОСТНОМ МОЗГЕ ПРИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

!+снижение клеточности костного мозга, преобладание жировой ткани
!преобладание кроветворного костного мозга над жировым
!очаговую пролиферацию лимфоцитов
!сужение красного ростка

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ
ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД

!+коронарографии
!электрокардиографии
!велоэргометрии
!чрезпищеводной стимуляции левого предсердия

? НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦМЕТАЛА МЕТОД

!+холтеровского мониторирования ЭКГ
!велоэргометрии
!чрезпищеводной стимуляции левого предсердия
!электрокардиографии

? ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ МИОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+повышение миокардиальных ферментов
!лейкоцитоз крови
!ускорение скорости оседания эритроцитов
!повышение иммуноглобулинов

? ЭКГ-ПРИЗНАКОМ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ ПРИ КРУПНООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

!+зубец QS
!подъем интервала ST выше изолинии
!смещение интервала ST ниже изолинии
!отсутствие патологического зубца Q

? ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОКАРДИИ ПРОБА С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ

!+появлении боли или стеснения в груди в сочетании с депрессией сегмента ST более 1 мм
!появлении одышки при достижении субмаксимальной ЧСС
!повышении САД до 180 мм рт.ст и ДАД до 110 мм рт.ст.
!регистрации косовосходящей депрессии сегмента ST до 1 мм

? ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С СИНДРОМОМ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+снижение содержания тромбоцитов до $50 \times 10^9/\text{л}$
!повышение аланинаминотрансферазы
!наличие эозинофилии
!повышение скорости оседания эритроцитов

? РЕЗКО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ И ГАММАГЛУТАМИНТРАНСПЕПТИДАЗЫ ПРИ

!+хроническом гепатите с явлениями холестаза и билиарном циррозе печени
!гематоматозе
!болезни Вильсона - Коновалова
!описторхозе

? ФЕРМЕНТОМ, МЕТАБОЛИЗИРУЮЩИМ АЛКОГОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+алкогольдегидрогеназа

!глюкозо-6-фосфатаза
!алкогольоксидаза
!алкогольсинтетаза

? СТУПЕНЧАТЫЕ И МОСТОВИДНЫЕ НЕКРОЗЫ ПЕЧЕНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

!+хроническом гепатите выраженной степени активности
!гемохроматозе
!желчнокаменной болезни
!жировой дистрофии печени

? СИМПТОМ ИЗЖОГИ ВЫРАЖЕН ПРИ

!+гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
!хроническом холецистите
!хроническом пиелонефрите
!хроническом панкреатите

? К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕКОВ ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ОТНОСЯТСЯ

!+белковые препараты, мочегонные
!антиагреганты, антикоагулянты, антибиотики
!глюкокортикоиды, цитостатики, антиагреганты, антикоагулянты
!глюкокортикоиды, антикоагулянты, антибиотики

? ПОКАЗАНИЯМИ К СРОЧНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ГЕМОДИАЛИЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+повышение уровня калия сыворотки 6,5 ммоль/л и более
!высокая гипертензия
!олигурия
!повышение уровня мочевины более 10 ммоль/л

? ПОКАЗАНИЯМИ К НАЗНАЧЕНИЮ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭРИТРЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ

!+спленомегалия, лейкоцитоз, тромбоцитоз
!лейкопения, тромбоцитопения
!плеторический синдром
!эритромелалгия

? ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ФАКТОРА VIII ИСПОЛЬЗУЮТ

!+Октанат
!Бебулин
!Фактонин
!Агемфил В

? К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРИАНТНОЙ СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТ

!+антагонисты кальция
!Никорандил
!бета-адреноблокаторы
!ингибиторы АПФ

? ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИЁМУ БЕТА- АДРЕНОБЛОКАТОРОВ БОЛЬНЫМ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕН

!+Ивабрадина гидрохлорид
!Гидрохлоротиазид
!Эналаприл
!Нифедипин

? ХАРАКТЕР ЭКСТРЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ТРОМБОЛИЗИС) ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

!+положением сегмента ST относительно изоэлектрической линии на электрокардиограмме
!наличием зубца Q на электрокардиограмме
!наличием (-) зубца Т на электрокардиограмме
!появлением экстрасистолы на электрокардиограмме

? АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТСЯ

!+Преднизолоном
!Панкреатином
!Рибавирином
!Интерфероном

? В ТЕРАПИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВКЛЮЧАЮТСЯ

!+ферменты (панкреатин)
!кортикостероиды

!сосудистые препараты
!ингибиторы АПФ

? ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
!+тяжелая дисплазия слизистой оболочки толстой кишки

!прием глюкокортикоидов
!развитие склерозирующего холангита
!развитие псевдополипоза

? ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ, ЯВЛЯЕТСЯ
!+желудочковая тахикардия
!стенокардия напряжения
!развитие сердечной недостаточности
!полная блокада левой ножки пучка Гиса

? НЕПРЯМЫЕ ОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
!+кардиоэмболических осложнений
!развития сердечной недостаточности
!возникновения пароксизмов фибрилляции предсердий
!прогрессирования стенокардии напряжения

? ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ (ММОЛЬ/Л)
!+ХС ЛНП < 2,0
!общего холестерина < 5,0
!ХС ЛВП < 1,0
!ХС ЛВП > 1,0

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕОБХОДИМА ДИЕТА
!+фруктово-овощная
!с исключением животных жиров
!углеводно-жировая
!с повышенным содержанием белка

? ПРИ МЕЛКООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАЗНАЧАЕТСЯ ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ (АСПИРИН ПЛЮС КЛОПИДОГРЕЛЬ)
!+на 12 месяцев всем больным, независимо от вида лечения в остром периоде
!на 3 месяца больным после установления металлического стента
!на 1 месяц больным, которым не проводилась перфузия коронарных артерий
!на 6 месяцев больным после установки стента с лекарственным покрытием

? ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ БОЛЬНЫМ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ И ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
!+имплантация кардиовертера-дефибриллятора
!ограничение физической нагрузки
!длительный прием статинов
!имплантация электрокардиостимулятора

? ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦМЕТАЛА БОЛЬНОМУ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧАТЬ
!+антагонисты кальция
!пролонгированные нитраты
!бета-адреноблокаторы
!Фибринолизин

? ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В СОЧЕТАНИИ С СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ
!+Р-адреноблокаторам
!дигидропиридиновым блокаторам кальциевых каналов
!петлевым диуретикам
!а-адреноблокаторам

? А1-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С
!+аденомой предстательной железы
!стенокардией напряжения
!инфарктом миокарда в анамнезе
!нарушениями ритма сердца

? НАИБОЛЬШЕЙ ОТОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

!+аминогликозиды
!макролиды
!нитрофураны
!Р-лактамы

? НАИБОЛЬШЕЙ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

!+Парацетамол
!Ацетилсалициловая кислота
!Ибупрофен
!Кеторолак

? ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИНФАРКТМ МИОКАРДА В АНАМНЕЗЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

!+Р-адреноблокаторы
!диуретики
!блокаторы кальциевых каналов
!агонисты имидазолиновых рецепторов

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ КОМБИНАЦИЯ В-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ И

!+Резерпина
!диуретиков
!ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
!агонистов имидазолиновых рецепторов

? ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СТАТИНОВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ БЫВАЕТ

!+гепатотоксичность
!ототоксичность
!нефротоксичность
!нейротоксичность

? ПРИ БОЛИ В ЖИВОТЕ, ТОШНОТЕ, ИЗЖОГЕ, ОТРЫЖКЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

!+эзофагогастродуоденоскопию
!клинический анализ крови
!ультразвуковое исследование органов брюшной полости
!компьютерную томографию органов брюшной полости

? ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ С ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕР СТУЛА

!+обильный, кашицеобразный, блестящий
!скудный, фрагментированный
!водянистый с хлопьями
!жидкий, с примесью алой крови

? К ИЗМЕНЕНИЯМ ЭКГ, ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ТЭЛА, ОТНОСЯТ

!+глубокий зубец S в I отведении, глубокий зубец Q в III отведении
!глубокий зубец Q в I отведении, глубокий зубец S в III отведении
!подъем сегмента ST и глубокий зубец Q в I отведении
!полную блокаду левой ножки пучка Гиса

? АСЦИТ ПОЯВЛЯЕТСЯ РАНЬШЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТЕКОВ ПРИ

!+циррозе печени
!митральных пороках сердца
!декомпенсированном хроническом легочном сердце
!дилатационной кардиомиопатии

? АСЦИТ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТЕКОВ ПРИ

!+прогрессировании сердечной недостаточности
!циррозе печени
!туберкулезе брюшины
!канцероматозе брюшины

? ВАРИАНТОМ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ПРАВИЛЬНОМ РИТМЕ НА ЭКГ С ЧСС 170 УДАРОВ В МИНУТУ (КОМПЛЕКСЫ QRS НЕ ИЗМЕНЕНЫ) ЯВЛЯЕТСЯ

!пароксизмальная наджелудочковая тахикардия
!пароксизмальная желудочковая тахикардия
!синусовая тахикардия
!ускоренный эктопический ритм

? ВЫЯВЛЕНИЕ НА ЭКГ УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА P-Q, РАВНОГО 0,26 СЕК., СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО БЛОКАДЫ

!+атриовентрикулярного проведения 1 степени

!атриовентрикулярного проведения 2 степени

!атриовентрикулярного проведения 3 степени

!синоатриального проведения

? ВЫСЛУШИВАНИЕ СУХИХ СВИСТЯЩИХ ХРИПОВ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИНДРОМА

!+нарушения бронхиальной проходимости

!повышения воздушности легочной ткани

!уплотнения легочной ткани

!полости в легком

? ЭКВИВАЛЕНТОМ ПРИСТУПА УДУШЬЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ВЫСТУПАЕТ

!+пароксизмальный непродуктивный кашель

!постоянный непродуктивный кашель

!кашель с отделением обильной слизистой мокроты

!постоянная одышка

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ

!+отношение ОФВ1/ФЖЕЛ

!отношение ФЖЕЛ/ОФВ1

!ФЖЕЛ

!ОФВ1

? ДЛЯ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫ ДАННЫЕ

!+эхокардиографии

!электрокардиографии

!физикального исследования

!сцинтиграфии

? «ШТАМПОВАННЫЕ» ДЕФЕКТЫ В ЭПИФИЗАХ КОСТЕЙ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ СУСТАВА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

!+подагры

!остеоартроза

!ревматоидного артрита

!анкилозирующего спондилита

? ДЛЯ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНЫ УМЕРЕННЫЕ

!+лейкопения и тромбоцитопения

!лейкопения и тромбоцитоз

!лейкоцитоз и тромбоцитопения

!лейкоцитоз и тромбоцитоз

? ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА

!+интенсивная гомогенная долевая инфильтрация

!инфильтрация в форме треугольника с верхушкой, направленной к корню

!инфильтрация с ранним формированием полостей распада

!прикорневая инфильтрация с полициклическим контуром

? СОЧЕТАНИЕ ПРОТЕИНУРИИ, ЭРИТРОЦИТУРИИ, ГИПОПРОТЕИНЕМИИ, ОТЕКОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

!+острого гломерулонефрита

!мочекаменной болезни

!пиелонефрита

!амилоидоза почек

? ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+колоноскопия с исследованием гистологического материала

!виртуальная колоноскопия

!ректороманоскопия

!ирригоскопия

? ГИПЕРСПЛЕНИЗМ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ СОЧЕТАНИИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ И

!+лейкопении, анемии, тромбоцитопении

!лейкоцитоза, эритроцитоза, тромбоцитоза

лейкоцитоза, анемии, тромбоцитопении

!лейкопении, анемии, тромбоцитоза

? ПРИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА У ЛИЦ С ДИСКИНЕЗИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- !+незначительная болезненность в правом подреберье
- !положительный симптом Ортнера
- !мышечная защита правого подреберья
- !френикус-симптом

? ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+снижение уровня сывороточного железа
- !снижение общей железосвязывающей способности сыворотки
- !повышение содержания ферритина в сыворотке
- !анизоцитоз и анизохромия

? БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ !+антисекреторные препараты

- !спазмолитики
- !прокинетики
- !ферменты

? ЛЕЧЕБНЫЙ ПАРАЦЕНТЕЗ БОЛЬНОМУ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С АСЦИТОМ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ

- !+напряженном или рефрактерном к терапии асците
- !болях в животе
- !нарастании желтухи
- !отсутствии артериальной гипотонии

? ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИУРЕТИКОВ У БОЛЬНЫХ С ОТЕЧНО-АСЦИТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОЦЕНКА

- !+суточного диуреза
- !окружности живота
- !уровней креатинина и мочевины в сыворотке крови
- !уровней калия и натрия в сыворотке крови

? ПРИ СОЧЕТАНИИ АСЦИТА И ОТЕКОВ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА СОСТАВЛЯЕТ (МЛ/СУТ)

- !+500-1000
- !1100-1500
- !300-500
- !100-300

? АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ПРИ

- !+выделении гнойной мокроты
- !появлении кровохарканья
- !нарастании слабости
- !упорном кашле

? ТЕРАПИЮ БРОНХОДИЛАТОРАМИ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ХОБЛ ПРОВОДЯТ ДЛЯ

- !+улучшения переносимости физической нагрузки
- !подавления хронического воспаления
- !улучшения эластической тяги легких
- !предупреждения дальнейшего снижения функции легких

? ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ПОКАЗАНА БОЛЬНЫМ ХОБЛ ПРИ

- !+тяжелом течении частых обострениях
- !крайне тяжелом течении
- !легком течении
- !любой степени тяжести

? КОЛХИЦИН ПРИ ПОДАГРЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ

- !+купирования острого артрита
- !снижения гиперурикемии
- !профилактики и лечения нефропатии
- !рассасывания подкожных тофусов

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА, ВЫЗВАННОГО СТРЕПТОКОККАМИ, ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ

- !+пенициллины и аминогликозиды
- !фторхинолоны и аминогликозиды
- !макролиды и аминогликозиды
- !макролиды и фторхинолоны

? ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

!+нефротический синдром

!гематурия

!почечная недостаточность

!артериальная гипертензия

? ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ У БОЛЬНОГО ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ДИЕТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КАСАЮТСЯ

!+белков

!жиров

!углеводов

!поваренной соли

? ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+Преднизолон

!Интерферон альфа

!Рибавирин

!Урсодезоксихолевая кислота

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОКАЗАНЫ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

!+высокодозные микрогранулированные

!высокодозные таблетированные

!низкодозные микрогранулированные

!низкодозные таблетированные

? ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ВНУТРЬ СЛЕДУЕТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ УЧИТЫВАТЬ СОДЕРЖАНИЕ В НИХ

!+двухвалентного железа

!трехвалентного железа

!компонентов, усиливающих всасывание железа

!компонентов, ускоряющих высвобождение железа

? ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА КРАСНОЙ КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА РАНЬШЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ

!+количества ретикулоцитов

!количества эритроцитов

!уровня гемоглобина

!цветового показателя

? БОЛЬ В ОБЛАСТИ ВЕРХУШКИ СЕРДЦА, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

!+атипичной стенокардией

!типичной стенокардией

!кардиалгией

!ангинозным статусом

? ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

!+типичной стенокардией

!атипичной стенокардией

!кардиалгией

!ангинозным статусом

? ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ БЫСТРОЙ ХОДЬБЕ ИЛИ ПОДЪЕМЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН ПРОЛЕТ, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ_____ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ

!+II

!I

!III

!IV

? ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ СПОКОЙНОЙ ХОДЬБЕ НА РАССТОЯНИЕ 100-200 МЕТРОВ ИЛИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ПО

ЛЕСТНИЦЕ НА ОДИН ПРОЛЕТ, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ

!+III

!I

!II
!IV

? ОБЫЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕ ВЫЗЫВАЕТ
УСТАЛОСТИ, СЕРДЦЕБИЕНИЯ И ОДЫШКИ У БОЛЬНЫХ С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАССОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

!+I
!II
!III
!IV

? СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТМЕЧАЮТСЯ В ПОКОЕ И РЕЗКО ВОЗРАСТАЮТ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАССОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

!+ IV
!I
!II
!III

? ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО ЗАСТОЯ ТОЛЬКО В МАЛОМ КРУГЕ
КРОВОООБРАЩЕНИЯ МОГУТ ОТМЕЧАТЬСЯ ПРИ СТАДИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

!+IIA
!I
!IIВ
!III

? ТЯЖЕЛАЯ ТРАНСМУРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКГ

!+элевацией сегмента ST
!депрессией сегмента ST
!появлением зубца Q
!инверсией зубца T

? ТЯЖЕЛАЯ СУБЭНДОКАРДИАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКГ

!+депрессией сегмента ST
!элевацией сегмента ST
!появлением зубца Q
!инверсией зубца T

? ПРИЧИНОЙ СПОНТАННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА МОЖЕТ СТАТЬ

!+коронарный тромбоз, спровоцированный разрывом бляшки
!тяжелая гиперхолестеринемия
!резкое снижение артериального давления
!эмболия коронарных артерий

? ПРИ ПЕРИКАРДИТЕ ЭЛЕВАЦИЯ СЕГМЕНТА ST МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ

!+депрессией сегмента PQ
!депрессией ST в отведениях от противоположной стенки
!зазубриной на нисходящем колене зубца R
!появлением патологического зубца Q

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

!+рентгенологически подтвержденного легочного инфильтрата
!температуры тела пациента выше 38 °C
!гнойной мокроты
!лейкоцитоза

? ДЛЯ ПЕРВОГО ПОДАГРИЧЕСКОГО ПРИСТУПА ТИПИЧНО ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ

!+плюснефаланговых
!пятьнофаланговых
!голеностопных
!коленных

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
ЯВЛЯЕТСЯ

!+эндоскопическое
!рентгенологическое
!гистологическое

!рН-метрическое

? ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНУЮ РЕФЛЮКСНУЮ БОЛЕЗНЬ В ФОРМЕ

!+гастроэзофагеального рефлюкса с эзофагитом

!кандидозного эзофагита

!синдрома Мэллори-Вейса

!диффузного эзофагоспазма

? ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ H. PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ

!+выявление диагностического титра антител к H. pylori

!быстрый уреазный тест в биоптате

!микробиологический тест

!цитологический тест в мазке-отпечатке

? ДЛЯ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО

!+снижение протромбинового индекса, повышение билирубина, снижение альбумина

!снижение протромбинового индекса, снижение билирубина, повышение трансаминаз

!повышение билирубина, повышение трансаминаз, повышение холестерина

!повышение протромбинового индекса, повышение билирубина, повышение трансаминаз

? КЛИНИЧЕСКИ ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЗВОЛЯЮТ

!+нарастание желтухи, геморрагический синдром

!желтуха, слабость

!геморрагический синдром, похудание

!нарастание слабости, желтуха

? НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕЧЕНОЧНОЙ И ПОДПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ СЛУЖИТ

!+ультразвуковое исследование органов брюшной полости

!эндоскопическое исследование пищевода и желудка

!биохимическое исследование крови на содержание билирубина, щелочной фосфатазы

!биохимическое исследование крови на содержание АЛТ и АСТ

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ЗОЛЛИНГЕРА-ЭЛЛИСОНА ВАЖНО ИССЛЕДОВАНИЕ

!+уровня сывороточного гастрина

!антител H. pylori

!калия и натрия крови

!уровня инсулина и С-пептида

? К РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТ

!+полифекалию

!сахарный диабет

!кахексию

!«панкреатическую холеру»

? САМЫМ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ АСЦИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+спонтанный бактериальный асцит-перитонит

!пупочная грыжа

!одышка

!развитие венозных коллатералей на брюшной стенке

? ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

!+дивертикулит

!рак толстой кишки

!язвенный колит

!запор

? ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО ИССЛЕДОВАНИЕ

!+кала на токсины A и B Cl. difficile

!копрограммы на амилаорею и стеаторею

!обзорной рентгенограммы органов брюшной полости

!клинического анализа крови

? ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДВУСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОРКОВОГО СЛОЯ ПОЧЕК ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

!+отека почек

!хронической почечной недостаточности

!гидронефроза
!мочекаменной болезни

? ДЛЯ НАРУШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ХАРАКТЕРНА

!+гипостенурия
!лейкоцитурия
!протеинурия
!гематурия

? ДЛЯ АСПИРИНОВОЙ ТРИАДЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ АСПИРИНА И

!+бронхиальной астмы, полипов носа
!тугоухости, полипов носа
!конъюнктивита, вазомоторного ринита
!саркоидоза легких, хронического отита

? ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В ЛЕЙКОФОРМУЛЕ МОКРОТЫ ХАРАКТЕРНО ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

!+Эозинофилов
!макрофагов
!лимфоцитов
!нейтрофильных лейкоцитов

? СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

!+Р-адреноблокаторы
!нитраты
!ингибиторы If-каналов синусового узла (Ивабрадин)
!дигидропиридиновые антагонисты кальция

? АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА-АДРЕНОБЛОКТОРОВ СЛУЖИТ

!+бронхиальная астма
!хроническая обструктивная болезнь легких
!атеросклероз сосудов нижних конечностей
!атриовентрикулярная блокада I степени

? СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СЛУЖАТ

!+бензотиазепиновые антагонисты кальция
!нитраты
!ингибиторы If-каналов синусового узла (Ивабрадин)
!дигидропиридиновые антагонисты кальция

? У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ПОКОЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (УД/МИН)

!+60-65
!50-55
!55-60
!65-70

? ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ НАЗНАЧАЮТ В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ (МГ)

!+75-125
!150-200
!250-300
!400-500

? ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТА БЕЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОКРЫТИЯ ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ (МЕС.)

!+12
!3
!6
!1

? ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ (МЕС.)

!+6
!1
!3
!12

? У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (ММОЛЬ/Л)

!+5,0

!4,5

!4,0

!3,5

? У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (ММОЛЬ/Л)

!+4,5

!4,0

!3,5

!3,0

? ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ СТАТИНОВ ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ (МЕС.)

!+1-1,5

!3-4

!2-3

!5-6

? ЛЕЧЕНИЕ СТАТИНАМИ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ, ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ ТРАНСАМИНАЗ ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ В (РАЗ)

!+3

!2,5

!2

!1,5

? НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ СОСТАВЛЯЕТ (МГ)

!+250

!75

!100

!500

? НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА КЛОПИДОГРЕЛА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ СОСТАВЛЯЕТ (МГ)

!+300

!75

!150

!225

? ПРИ ОТСУТСТВИИ НА ФОНЕ ПРИЁМА БЕТА- АДРЕНОБЛОКАТОРОВ НЕОБХОДИМОГО СНИЖЕНИЯ ЧСС У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СИНУСОВЫМ РИТМОМ К ТЕРАПИИ МОЖНО ДОБАВИТЬ

!+Ивабрадин

!Дигоксин

!Верапамил

!Дилтиазем

? ДИУРЕТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАЧИНАЮТ НА СТАДИИ

!+11А

!11Б

!I

!III

? ПОКАЗАНИЕМ К ТРОМБОЛИЗИСУ ИЛИ ЭМБОЛЭКТОМИИ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ СЛУЖАТ

!+шок или артериальная гипотензия

!признаки перегрузки правого желудочка

!положительные результаты Д-димер теста

!положительные результаты тропонинового теста

? ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЦЕЛЕВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ НОРМАЛИЗОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ РАВНО

!+2,0-3,0

!1,5—2,5

!2,5-3,5

!3,0-4,0

? ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА У БОЛЬНЫХ С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ЦЕЛЕВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ НОРМАЛИЗОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ РАВНО

!+2,0-3,0

!1,5-2,0
!2,5-3,5
!3,0-4,0

? КАРДИОВЕРСИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПРИ ПАРОКСИЗМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ (ЧАС)

!+48
!36
!24
!12

? ПРИ СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ БОЛЕЕ 48 ЧАСОВ ДО ПРОВЕДЕНИЯ КАРДИОВЕРСИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ АНТИКОАГУЛЯНТНУЮ ТЕРАПИЮ НЕ МЕНЕЕ (НЕДЕЛЯ)

!+3
!2
!4
!6

? ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ БЕЗ ФАКТОРОВ РИСКА КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ (НЕДЕЛЯ)

!+4
!2
!3
!6

? МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КАРДИОВЕРСИЯ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ОБЫЧНО ЭФФЕКТИВНА, ЕСЛИ ОТ НАЧАЛА ПАРОКСИЗМА ПРОШЛО НЕ БОЛЕЕ (СУТКИ)

!+2
!7
!14
!30

? У БОЛЬНЫХ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

!+Пропафенон
!Ликодаин
!Верапамил
!сердечные гликозиды

? ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

!+Амиодарон
!Верапамил
!Прокаинамид
!сердечные гликозиды

? ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

!+Амиодарон
!бета-адреноблокаторы
!Верапамил
!Прокаинамид

? ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ БЕЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

!+макролиды
!тетрациклины
!цефалоспорины III поколения
!респираторные фторхинолоны

? ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ (СУТКИ)

!+2-3
!4-5
!6-7
!8-10

? САМЫМ ПОЗДНИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ СТАРТОВОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ СЛУЖИТ

!+исчезновение легочного инфильтрата

!нормализация или выраженное снижение температуры тела

!уменьшение степени гнойности мокроты

!нормализация лейкоцитарной формулы

? КРИТЕРИЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТЕРАПИИ АНТИБИОТИКАМИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТОЙКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ТЕЧЕНИЕ (СУТКИ)

!+3-5

!1-2

!6-7

!8-10

? СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СИМТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

!+р2-агонисты короткого действия

!антихолинэргические препараты

!ингаляционные глюкокортикостероиды

!системные глюкокортикостероиды

? ОПТИМАЛЬНЫМ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ В КОМБИНАЦИИ С

!+продолжительными бронхолитиками

!р2-агонистами короткого действия

!антихолинэргическими препаратами

!системными глюкокортикостероидами

? ПОДАГРА СЛУЖИТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ

!+тиазидных диуретиков

!ингибиторов АПФ

!Р-адреноблокаторов

!антагонистов кальция

? В ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗНОГО ЭЗОФАГИТА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ

!+Флуконазол

!Висмута трикалия дицитрат

!Омепразол

!Алгелдрат + Магния гидроксид

? НАИБОЛЬШИЙ АНТИСЕКРЕТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ОКАЗЫВАЕТ

!+Омепразол

!Ранитидин

!Висмута трикалия дицитрат

!Алгелдрат + Магния гидроксид

? В СХЕМУ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЭРАДИКАЦИИ H. PYLORI ВХОДИТ

!+Амоксициллин

!Левифлоксацин

!Тетрациклин

!Ципрофлоксацин

? В ЛЕЧЕНИИ НПВП-ГАСТРОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ

!+ингибиторы протонной помпы

!блокаторы H2-гистаминовых рецепторов

!антациды

!препараты висмута

? ЭРАДИКАЦИЯ H. PYLORI КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НПВП-ГАСТРОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА И БЕЗОПАСНА

!+до начала терапии НПВП

!в пределах полугода от начала терапии НПВП

!при появлении болей в животе или диспепсии

!при эндоскопической верификации НПВП-гастропатии

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

!+тяжелое течение гепатита

!анамнестическое указание на употребление наркотиков

!развитие алкогольного делирия

!выраженная слабость

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПОНТАННОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО АСЦИТА- ПЕРИТОНИТА ОПТИМАЛЬНА КОМБИНАЦИЯ

!+цефалоспоринов и альбумина

!цефалоспоринов и диуретиков

!альбумина и диуретиков

!диуретиков и гепатопротекторов

? СРЕДСТВОМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+Месалазин

!Преднизолон

!Амоксициллин

!Дротаверин

? ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЛЕЧЕНИИ

!+болезни Крона

!дизентерии

!синдрома раздраженного кишечника

!дивертикулярной болезни кишечника

? ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ТЕРАПИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИДАЕТСЯ

!+ингибиторам протонной помпы

!антибиотикам

!спазмолитикам

!антацидам

? К ПРИЧИНАМ ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ ОТНОСЯТ

!+гиперпаратиреоз

!гиперфосфатемию

!жировую эмболию

!рабдомиолиз

? ПРИЧИНОЙ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+гипопаратиреоз

!длительная иммобилизация

!болезнь Педжета

!передозировка витамина D

? НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ И ЗНАЧИМЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+биопсия почек

!анализ мочи по Нечипоренко

!УЗИ почек

!позитронно-эмиссионная томография почек

? НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ

!+уровень сывороточного ферритина

!уровень трансферрина

!общая железосвязывающая способность сыворотки

!уровень сывороточного железа

? ГЕПАТОЛИЕНАЛЬНЫЙ СИНДРОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

!+аденовирусной инфекции

!гриппа

!менингита

!парагриппа

? НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ ГИПОТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 ЯВЛЯЮТСЯ

!+ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

!блокаторы бета-адренорецепторов

!блокаторы ренина

!диуретики

? ПРИ СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРОТИВОПОКАЗАН

!+Атенолол

!Верапамил

!Каптоприл
!Празозин

? НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

!+введение гриппозных вакцин
!закаливание организма
!приём больших доз аскорбиновой кислоты
!приём поливитаминных препаратов

? ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕФРОГЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

!+ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и диуретики
!блокаторы бета-адренорецепторов и блокаторы медленных кальциевых каналов
!блокаторы альфа-адренорецепторов и препараты раувольфия

? К ОСНОВНОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ СИМПТОМУ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ОТНОСЯТ

!+частый жидкий стул с примесью крови
!боли в эпигастрии
!запоры
!рвоту, приносящую облегчение

? МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+колоноскопия с прицельным биопсийным исследованием
!фиброгастроскопия
!дуюденальное зондирование
!ирригоскопия

? К МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ АКТИВНОСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ОТНОСЯТ

!+наличие нейтрофильных лейкоцитов в собственной пластинке слизистой оболочки кишечной стенки
!наличие пролиферативной активности фибробластов
!эозинофильную инфильтрацию слизистой оболочки кишки
!рубцовые изменения слизистой оболочки

? ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+длительное применение антибиотиков
!пищевая токсикоинфекция
!злоупотребление алкоголем
!Helicobacter pylori

? ПРИЧИНОЙ ПИЩЕВОДНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+повышение давления в портальной вене
!снижение гемоглобина крови
!высокая вирусная нагрузка
!желтуха

? ГИПЕРСПЛЕНИЗМ ВСТРЕЧАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ,
СТРАДАЮЩИХ

!+циррозом печени
!желчнокаменной болезнью
!острым лейкозом
!амилоидозом

? СНИЖЕНИЕ АЛЬБУМИНОВ КРОВИ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

!+нарушения синтетической функции гепатоцитов
!нарушения всасывания белков из кишечника
!портальной гипертензии
!диспротеинемии

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫСТУПАЕТ

!+внутрипеченочный блок при циррозе печени
!внепеченочный блок в результате тромбоза селезеночной вены
!синдром Бадда-Киари
!внутрипеченочный блок при жировом гепатозе

? ФЕНОТИП ХОБЛ С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ У ПАЦИЕНТОВ С __ И БОЛЕЕ
ОБОСТРЕНИЕМ/ОБОСТРЕНИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА

!+2
!1
!3

!4

? ХОБЛ ТЯЖЁЛОГО И КРАЙНЕ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ (ПОСТБРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ОФВ1<50% ОТ ДОЛЖНОЙ) С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ И ВЫРАЖЕННЫМИ СИМПТОМАМИ СООТВЕТСТВУЕТ ГРУППЕ

!+D

!A

!B

!C

? ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

!+двухсторонней диссеминацией

!отсутствием диссеминации

!наличием очаговых образований

!наличием полостных образований

? К АЛЬВЕОЛИТАМ ОТНОСИТСЯ

!+токсический альвеолит

!саркоидоз легких

!гемосидероз легких

!диссеминированный туберкулез легких

? ПРИ ДИФФУЗНОМ ПРОЦЕССЕ В ЛЕГКИХ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ БРОНХОСКОПИЮ И СДЕЛАТЬ

!+щипцовую биопсию

!соскабливание

!пункцию лимфоузлов

!смыв бронхоальвеолярной жидкости

? ОБРАТИМАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

!+бронхиальной астмы

!тромбоэмболии легочной артерии

!обструктивной эмфиземы легких

!хронической обструктивной болезни легких

? АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА 2 СТЕПЕНИ ТИПА МОБИТЦ 1 ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

!+постепенным удлинением PQ с периодическим выпадением QRS

!редким правильным ритмом

!периодическим выпадением P и QRS

!постоянным интервалом PQ с периодическим выпадением QRS

? ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

!+дилатационной кардиомиопатии

!гипертрофической кардиомиопатии

!дефекта межпредсердной перегородки

!перикардита

? АСИММЕТРИЧНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

!+гипертрофической кардиомиопатии

!дилатационной кардиомиопатии

!артериальной гипертензии

!аортальном стенозе

? ДЛЯ КРУПНООЧАГОВОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+подъем сегмента ST

!инверсия зубцов T

!депрессия сегмента ST

!увеличение амплитуды зубца T

? ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ВЫСТУПАЕТ

!+уменьшение сердечного выброса

!снижение сосудистого тонуса

!уменьшение объема циркулирующей крови

!венозный застой

? АБДОМИНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ШУМ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

!+реноваскулярной артериальной гипертензии

!ренопаренхиматозной артериальной гипертензии

!недостаточности аортального клапана

!феохромоцитоме

? ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ПЕЧЕНИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- !+сахарного диабета
- !хронической сердечной недостаточности
- !системной красной волчанки
- !саркоидоза с поражением печени

? О НАЛИЧИИ СИНДРОМА ХОЛЕСТАЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- !+повышение уровня щелочной фосфатазы
- !повышение уровней аминотрансфераз
- !повышение уровня гамма-глобулинов
- !снижение уровня липопротеидов

? ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+Clostridium difficile
- !Escherichia coli
- !неспецифическая кокковая флора
- !неустановленный микроорганизм

? ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+панцитопения
- !гипохромия эритроцитов
- !анизо-пойкилоцитоз
- !макроцитоз эритроцитов

? ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО АНЕМИИ И ТРОМБОЦИТОПЕНИИ, БЛАСТОЗА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О

- !+остром лейкозе
- !апластической анемии
- !В12-дефицитной анемии
- !системной красной волчанке

? В III СТАДИИ ДВС-СИНДРОМА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- !+тромбоцитопения
- !тромбоцитоз
- !нормокоагуляция
- !гиперкоагуляция

? БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНА С ПОМОЩЬЮ

- !+спирографии
- !бронхоскопии
- !исследования газов крови
- !рентгенологического исследования

? ГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

- !+через 48 и более часов после поступления в стационар
- !в момент поступления в стационар и позднее
- !через 12 и более часов после поступления в стационар
- !через 24 и более часов после поступления в стационар

? МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КРАПИВНИЦЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- !+волдырь
- !эксориация
- !пятно
- !лихенификация

? СИМПТОМОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+гипопротеинемия
- !гиперпротеинемия
- !гематурия
- !артериальная гипертензия

? ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО ПРОТЕИНУРИИ 7 Г/СУТКИ, АНЕМИИ, ГИПОАЛЬБУМИНЕМИИ И ПОВЫШЕНИИ СОЭ ДО 68 ММ/ЧАС НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

- !+миеломную болезнь
- !амилоидоз почек
- !хронический гломерулонефрит
- !опухоль почки

? БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ НАЛИЧИИ

!+100000 бактерий/мл мочи и более

!100 бактерий/мл мочи и более

!500 бактерий в утренней порции мочи

!10000 бактерий в суточной моче

? ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

!+снижение продукции эритропоэтина

!дефицит витамина В12

!дефицит железа

!кровопотеря

? НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ТЕСТОМ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЮТСЯ АНТИТЕЛА

!+к двуспиральной дезоксирибонуклеиновой кислоте

!антигладкомышечные

!антинуклеарные

!к цитоплазме нейтрофилов

? ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНОЙ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПРОБУ КУМБСА, СЛУЖИТ

!+гемолиз

!кровотечение

!подавление красного ростка

!дефицит внутреннего фактора Кастла

? БОЛИ В СУСТАВАХ ПРИ НАГРУЗКЕ, ПРОХОДЯЩИЕ В ПОКОЕ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

!+остеоартроза

!подагрического артрита

!ревматоидного артрита

!реактивного артрита

? ИЗМЕНЕНИЕМ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+депрессия сегмента ST

!патологический зубец Q

!полная блокада ножек пучка Гиса

!удлинение интервала PQ

? НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ У БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ НОЧЬЮ ПРИСТУПАМИ ЗАГРУДИННЫХ БОЛЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ПРЕХОДЯЩИЙ ПОДЪЁМ СЕГМЕНТА ST, ЯВЛЯЕТСЯ

!+«вариантная стенокардия»

!«острый миокардит»

!«прогрессирующая стенокардия»

!«острый тромбоэмболический синдром»

? НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ВЫСТУПАЕТ

!+нагрузочный тест

!электрокардиография

!эхокардиография

!рентгенография сердца

? ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ В КРОВИ ТРОПОНИНА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СОСТАВЛЯЕТ

!+до 14 дней

!до 12 часов

!1 день

!1 месяц

? ИЗМЕНЕНИЕМ В АНАЛИЗЕ МОЧИ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ II СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+микроальбуминурия

!снижение удельного веса

!повышение удельного веса

!лейкоцитурия

? НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛЯ МИТРАЛЬНОЙ ЕЮНФИГУРАЦИИ СЕРДЦА, ВЫЯВЛЯЕМЫМ ПРИ ПЕРКУССИИ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ

!+смещение вверх верхней границы и сглаживание «тали» сердца
!смещение вправо правой границы
!треугольная форма сердца
!смещение левой границы влево

? МАКСИМАЛЬНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

!+стенозе устья аорты
!недостаточности митрального клапана
!стенозе митрального клапана
!недостаточности трикуспидального клапана

? ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПОКАЗАНА ПРИ

!+остром коронарном синдроме с подъемом ST
!остром коронарном синдроме без подъема ST
!любом остром коронарном синдроме
!нестабильной стенокардии

? К ТРОМБОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ

!+Тенектеплазу
!Бивалирудин
!Фондапаринукс
!Эноксапарин

? ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНУСОВОГО РИТМА БЕЗ ПОДГОТОВКИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ ВОЗМОЖНО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ МЕНЕЕ

!+48 часов
!7 суток
!30 суток
!12 часов

? ПРИ ДВУСТОРОННЕМ СТЕНОЗЕ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

!+ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
!диуретики
!блокаторы кальциевых каналов
!агонисты имидазолиновых рецепторов

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ АСЦИТА НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ НЕОБХОДИМО

!+соблюдение диеты с содержанием поваренной соли менее 3 г/сут
!применение диеты с ограничением белка
!начинать терапию петлевыми диуретиками в максимальных терапевтических дозах
!доведение суточного диуреза до 2-3 литров

? БОЛЬНЫЕ С ЦЕЛИАКИЕЙ МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬ

!+картофель
!макаронные изделия
!черный хлеб
!колбасные изделия

? ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

!+международного нормализованного отношения
!активированного частичного тромбопластинового времени
!агрегации тромбоцитов
!уровня фибриногена

? ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ

!+непрерывно
!в период обострения заболевания
!в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов
!весной и осенью

? ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

!+Сальбутамол
!Ипратропия бромид
!Флутиказон
!Натрия кромогликат

? ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+Флутиказон

!Гидрокортизон
!Преднизолон
!Дексаметазон

? К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ ВНУТРИКЛУБЧКОВУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ, ОТНОСЯТ

!+ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
!бета-адреноблокаторы
!диуретики
!статины

? ПОКАЗАНИЕМ К СРОЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ БОЛЬНОГО С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ГЕМОДИАЛИЗ ЯВЛЯЕТСЯ

!+высокая гиперкалиемия
!выраженная олигурия
!анасарка
!тяжелая гипертония

? ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

!+Аторвастатин
!Эналаприл
!Торасемид
!Ацетилсалициловая кислота

? К АНТИАГРЕГАНТАМ ОТНОСИТСЯ

!+Клопидогрел
!Изосорбида динитрат
!Бисопролол
!Эналаприл

? ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕПАРИНА ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

!+активированного частичного тромбопластинового времени
!международного нормализованного отношения
!агрегации тромбоцитов
!уровня фибриногена

? ПОБОЧНУЮ РЕАКЦИЮ В ВИДЕ ОТЕКА ЛОДЫЖЕК И СТОП МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ

!+Амлодипин
!Метопролол
!Эналаприл
!Дигоксин

? ТЯЖЕСТЬ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

!+исследования функции внешнего дыхания
!аускультации легких
!перкуссии легких
!бронхографии

? МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

!+спирография
!рентгеноскопия
!ларингоскопия
!электрокардиография

? МОКРОТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ

!+имеет слизистый характер и белесоватый цвет
!имеет гнойный характер и при стоянии расслаивается
!очень скудная и трудно поддается оценке
!белая, пенистая, обильная

? К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОТНОСЯТ

!+сухие базовые хрипы
!влажные средне- или крупнопузырчатые хрипы
!стридорозное дыхание
!амфорическое дыхание

? ПРИ ФИЗИКАЛЬНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНОГО НАЛИЧИЕ ПЛЕВРАЛЬНОГО ВЫПОТА МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ

!+ослаблением голосового дрожания
!усилением бронхофонии

!сухими хрипами
!усилением голосового дрожания

? БОЧКООБРАЗНАЯ ФОРМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ НОГТЕЙ ПАЛЬЦЕВ РУК («ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА») ПРИ НЕАТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О РАЗВИТИИ У БОЛЬНОГО

!+эмфиземы лёгких
!пневмоторакса
!острого респираторного заболевания
!пневмонии

? ЦЕЛЮЮ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

!+уменьшение скорости прогрессирования болезни
!устранение бактериовыделения с мокротой
!обратное развитие эмфиземы
!подготовка пациента к хирургическому лечению

? ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ПУЛЬС ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫЗВАН

!+перерастяжением легкого
!плевральным выпотом
!повышением температуры тела
!бронхоспазмом

? ПОКАЗАНИЕМ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ОБЪЕМЕ 4 СТУПЕНИ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+тяжелая персистирующая бронхиальная астма
!тяжелая интермиттирующая бронхиальная астма
!бронхиальная астма физического усилия
!легкая интермиттирующая бронхиальная астма

? ПРОЯВЛЕНИЕМ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА III СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+гипоксическая кома
!свистящее дыхание
!амфорическое дыхание
!немое легкое

? К ПРИЗНАКАМ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

!+приступы бронхоспазма на определенные аллергены
!возникновение бронхиальной астмы в пожилом возрасте
!приступы удушья при обострении хронического бронхита
!частые ночные приступы бронхоспазма

? К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

!+свистящие хрипы на выдохе
!бронхиальное дыхание
!амфорическое дыхание
!влажные звонкие мелкопузырчатые хрипы

? ТЕРАПИЯ АЛЬФА-1-АНТИТРИПСИНОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

!+эмфиземе легких
!эхинококкозе легких
!абсцессе легких
!приступе бронхиальной астмы

? ЗВУК РАЗЛИПАНИЯ АЛЬВЕОЛ, ВЫСЛУШИВАЕМЫЙ НА ВЫСОТЕ ВДОХА ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ, НАЗЫВАЕТСЯ

!+крепитацией
!флотацией
!бронхофонией
!шумом трения плевры

? ПОД ТЕРМИНОМ «ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» ПРИНЯТО ПОНИМАТЬ НАРУШЕНИЕ

!+вентиляции, транспорта и утилизации кислорода в легких
!газотранспортной функции крови
!тканевого метаболизма кислорода
!бронхиальной проходимости

? ТРЕХСЛОЙНОСТЬ МОКРОТЫ ПОСЛЕ ОТСТАИВАНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

!+абсцесса легкого и бронхоэктазов
!саркоидоза

!экзогенного аллергического альвеолита
!хронический обструктивный бронхит

? ПОД ТЕРМИНОМ «АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ПОНИМАЮТ

!+пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами
!пневмококковую пневмонию верхнедолевой локализации
!вирусную бронхопневмонию
!эозинофильный инфильтрат

? НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПНЕВМОНИЮ, ВОЗНИКШЮЮ

!+позднее 48 часов после госпитализации человека
!у ранее не леченного человека
!у больного, лечившегося в домашних условиях от другого заболевания
!у беременной женщины после 20 недель беременности

? ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ АБСЦЕССА ЛЁГКИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ С

!+кавернозным туберкулёзом лёгких
!хроническим бронхитом
!синдромом Хаммена - Рича
!бронхиальной астмой

? МОКРОТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХОЭКТАЗАМИ

!+имеет гнойный характер и при стоянии расслаивается
!всегда содержит свежую алую кровь
!имеет слизистый характер и белесоватый цвет
!белая, пенистая, обильная

? ДЛИТЕЛЬНОЕ КРОВОХАРКАНИЕ ПРИ СУХОМ КАШЛЕ ЗАСТАВЛЯЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОДОЗРЕВАТЬ

!+рак бронхов
!кавернозную форму туберкулеза легких
!бронхоэктатическую болезнь
!пневмокониоз

? ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

!+Амоксициллин, Кларитромицин
!Ципрофлоксацин, Пефлоксацин, Офлоксацин
!Эритромицин, Азитромицин
!Стрептомицин, Гентамицин

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+одышка
!повышение температуры тела
!похудание
!общая слабость

? ВАРИАНТ ИНФАРКТА МИОКАРДА С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

!+цереброваскулярным
!ангинозным
!аритмическим
!астматическим

? ЭКГ-ПРИЗНАКОМ АВ-БЛОКАДЫ II СТЕПЕНИ ТИПА МОБИТЦ I ЯВЛЯЕТСЯ

!+постепенное удлинение интервала P-Q при каждом сердечном цикле с последующим выпадением комплекса QRS
!выпадение комплекса QRS при нормальной продолжительности интервала P-Q
!отсутствие зубца P перед выпадением комплекса QRS
!выпадение каждого второго комплекса QRS

? ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ДИСФУНКЦИИ СИНУСОВОГО УЗЛА ЯВЛЯЕТСЯ

!+выраженная синусовая брадикардия
!фибрилляция предсердий
!предсердная экстрасистолия
!атриовентрикулярная блокада I степени

? АСИММЕТРИЧНАЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

!+гипертрофией межжелудочковой перегородки
!концентрической гипертрофией левого желудочка
!гипертрофией правого желудочка
!гипертрофией обоих желудочков

? ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+легочная артериальная гипертензия
- !венозный застой в малом круге кровообращения
- !повышение внутригрудного давления
- !снижение сердечного выброса

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ВАЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ

- !+метанефрины в крови или в моче
- !содержание кортизола в плазме
- !активность ренина плазмы
- !суточную экскрецию альдостерона с мочой

? ПРИ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИМЕТ МЕСТО

- !+ортопноэ
- !набухание шейных вен
- !асцит
- !увеличение печени

? АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ УДЛИНЯЕТСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ

- !+Дигоксина
- !Этмозина
- !Хинидина
- !Лидокаина

? РАЗВИТИЕ АСИСТОЛИИ ВОЗМОЖНО ПРИ КОМБИНАЦИИ ПРОПРАНОЛОЛА С

- !+Верапамилом
- !Каптоприлом
- !Фенобарбиталом
- !Фуросемидом

? УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА F (ИЛИ A2) НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- !+талассемии
- !серповидно-клеточной анемии
- !пароксизмальной ночной гемоглобинурии
- !наследственном сфероцитозе

? У БОЛЬНОГО 44 ЛЕТ С ПОСТОЯННЫМИ НОСОВЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ, ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЯМИ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ РУК, ЯЗЫКЕ И ДЕСНАХ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО

- !+болезнь Рандю-Ослера
- !острый лейкоз
- !хронический миелолейкоз
- !апластическая анемия

? ПЛЕТОРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ЭРИТРЕМИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ

- !+гиперемией кожных покровов, головными болями
- !увеличением объема циркулирующей крови
- !полным и напряженным пульсом
- !лейкоцитозом со сдвигом влево

? БЕЛОК БЕНС-ДЖОНСА В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

- !+миеломной болезни
- !хроническом гломерулонефрите
- !нефротическом синдроме
- !макроглобулинемии Вальденстрема

? КЛЕТКИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ

- !+хроническом лимфолейкозе
- !хроническом миелолейкозе
- !миеломной болезни
- !остром миелобластном лейкозе

? ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- !+макролиды
- !цефалоспорины
- !аминогликозиды
- !защищенные аминопенициллины

? ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЕТСЯ КИШКА

- !+прямая
- !ободочная
- !слепая
- !тощая

? У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСОКИХ ЗАОСТРЕННЫХ ЗУБЦОВ Т, БРАДИКАРДИИ ВЕРОЯТНА

- !+гиперкалиемия
- !гипергликемия
- !гипокалиемия
- !гиперкальциемия

? ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КРУПНЫХ БРОНХОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+кашель с мокротой
- !кашель без выделения мокроты
- !одышка инспираторного характера
- !повышение температуры тела

? ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ПРОТЕКАЮЩЕГО С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ МЕЛКИХ БРОНХОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- !+одышка
- !кашель с мокротой
- !повышение температуры тела
- !кашель без выделения мокроты

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОСПАЗМА С ПОМОЩЬЮ СПИРОГРАФИИ, ПНЕВМОТАХОГРАФИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРОБУ С ИНГАЛЯЦИЕЙ

- !+в2-адреностимулятора
- !глюкокортикостероида
- !смеси кислорода и оксида азота
- !а2-адреностимулятора

? ОДНОСТОРОННЯЯ БОЛЬ В ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- !+острого пиелонефрита
- !острого цистита
- !амилоидоза почек
- !острого гломерулонефрита

? ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

- !+кистей
- !коленные
- !крестцово-подвздошные
- !позвоночные

? К ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕМУСЯ ЛАБОРАТОРНОМУ ПРИЗНАКУ ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ ОТНОСЯТ

- !+HLA-B27
- !ревматоидный фактор
- !антинейтрофильные антитела
- !антимитохондриальные антитела

? НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ 52ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ (ЛИЦО СИММЕТРИЧНО, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕФЛЕКСОВ НЕТ, ПУЛЬС 40 В МИНУТУ, АД 160/60 ММ РТ.СТ.) ЯВЛЯЕТСЯ

- !+полная А-V блокада
- !отек мозга
- !ангиоспастическая энцефалопатия
- !гипогликемия

? ВЫСОКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ (1030 И ВЫШЕ) ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- !+сахарного диабета
- !хронического нефрита
- !пиелонефрита
- !несахарного диабета

? ПРАВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА ОБРАЗОВАНА

- !+правым предсердием
- !правым желудочком

!левым желудочком
!ушком левого предсердия и *conus pulmonalis*

? ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРОБЫ ВАЛЬСАЛЬВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

!+уменьшение венозного возврата
!снижение общего периферического сопротивления сосудов
!уменьшение объема циркулирующей крови
!увеличение ударного объема

? ФИЗИКАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+запаздывание каротидной пульсации
!дующий диастолический шум в точке Боткина - Эрба
!громкий аортальный компонент II тона
!высокое систолическое давление

? УСИЛЕНИЕ II ТОНА НА АОРТЕ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

!+эссенциальной гипертензии
!легочной гипертензии
!митральном стенозе
!тромбоэмболии легочной артерии

? ПРИСТУПЫ БРОНХОСПАЗМА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

!+Пропранолол
!Симвастатин
!Каптоприл
!Ацетилсалициловая кислота

? ПРИ ЭКСУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИРОВАННОМ НА ДОМУ, ТАКТИКОЙ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+немедленная госпитализация
!госпитализация в порядке очередности
!амбулаторное лечение плевральными пункциями с введением антибиотиков в плевральную полость
!лечение на дому антибиотиками широкого спектра действия и кортикостероидными гормонами

? ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИТА ПРОВОДИТСЯ

!+вне стационара
!в стационаре
!сначала вне стационара, затем в стационаре
!сначала в стационаре, затем вне стационара

? ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ХОБЛ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ

!+непрерывно
!в период обострения заболевания
!в период обострения заболевания и в виде профилактических курсов весной и осенью
!в виде профилактических курсов весной и осенью

? 41-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ, НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ

!+снизить вес
!ограничить физическую активность
!пить 3 литра воды ежедневно
!ограничить белки в диете

? ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ С МОМЕНТА ДОСТИЖЕНИЯ РЕМИССИИ СОСТАВЛЯЕТ (ГОД)

!+5
!1
!3
!2

? ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+инфекция
!переохлаждение
!курение
!вдыхание раздражающих газов и аэрозолей

? У ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

!+курение

!повторная вирусно-бактериальная инфекция
!воздействие промышленных газов и аэрозолей
!врожденная функциональная недостаточность мукоцилиарного аппарата воздухоносных путей

? БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА (АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛОАРТРИТ) ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ

!+молодых мужчин
!женщин после климакса
!пожилых мужчин
!молодых девушек

? ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У МУЖЧИНЫ 55 ЛЕТ, ПЕРЕНЕСШЕГО 7 ЛЕТ НАЗАД РЕЗЕКЦИЮ ЖЕЛУДКА (В МАЗКЕ КРОВИ МАКРОЦИТОЗ) ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ

!+цианкобаламина
!железа
!эритропоэтина
!пиридоксина

? ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+снижение частоты рецидивов
!уменьшение выраженности болевого синдрома
!ускорение рубцевания язвы
!уменьшение риска прободения язвы

? ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОСТУПЛЕНИЯ С ПИЩЕЙ ВИТАМИНА В12 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА В12 РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ

!+4-5 лет
!3-4 месяца
!5-8 месяцев
!9-12 месяцев

? ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА ПОРАЖАЮТСЯ

!+печень и мозг
!сердце и почки
!почки и легкие
!печень и почки

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

!+гемофильная палочка
!пневмококк
!стафилококк
!микоплазма

? В ДИАГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ РЕШАЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+эластометрия
!ультразвуковое исследование
!рентгенография
!ирригоскопия

? НА НАЛИЧИЕ ХОЛЕСТАЗА УКАЗЫВАЮТ

!+повышение щелочной фосфатазы, билирубина, холестерина
!повышение аспарагиновой и аланиновой трансаминаз, глюкозы
!снижение протромбина, гемоглобина, фибриногена
!повышение амилазы, общего белка, креатинина

? ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХОЛЕСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ

!+кожный зуд
!спленомегалия
!асцит
!гепатомегалия

? ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЁННОЙ КИШКИ ОТМЕЧАЮТСЯ

!+функциональные расстройства
!органические изменения
!наследственные нарушения
!аномалии развития кишечника

? ФАКТОРОМ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОСТИНФЕКЦИОННОГО СИНДРОМА РАЗДРАЖЁННОЙ КИШКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+перенесённая кишечная инфекция
!молоко
!употребление продуктов богатых клетчаткой
!дислипидемия

? ДИАГНОЗ «СИНДРОМ РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА» ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ

!+наличия крови в кале
!стуле чаще 3 раз в неделю
!чувстве неполного опорожнения кишечника
!стуле реже 3 раз в неделю

? УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ I СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ РТ.СТ.)

!+150/95
!160/100
!150/100
!160/95

? УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ II СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ РТ.СТ.)

!+170/100
!180/90
!180/95
!160/110

? УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ РТ.СТ.)

!+170/115
!175/105
!165/95
!170/100

? УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮТ ФАКТОРЫ

!+тканевые
!психосоциальные
!генетические
!интоксикационные

? ГУМОРАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ТОНУС СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+эндотелин
!адреналин
!адренокортикотропнин
!оксид азота

? ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+повышение тонуса артериол
!увеличение сердечного выброса
!снижение эластичности стенки аорты
!увеличение эластичности стенки аорты

? ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО

!+повышение сердечного выброса
!снижение сердечного выброса
!снижение общего периферического сопротивления
!увеличение центрального венозного давления

? УРОВНЕМ ТРИГЛИЦЕРИДОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММОЛЬ/Л)

!+1,7
!1,2
!1,0
!0,7

? КРАТНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОДНОМ ВИЗИТЕ К ВРАЧУ СОСТАВЛЯЕТ

!+2
!1
!3
!4

? ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ КУРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ (ЧАС)

!+0,5

!2,5

!1,5

!2

? К АССОЦИИРОВАННОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСИТСЯ

!+расслаивающая аневризма аорты

!аортальный стеноз

!аортальная недостаточность

!трикуспидальная недостаточность

? ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ ОФИСНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СОСТАВЛЯЕТ (ММ РТ.СТ.)

!+140/90

!130/80

!135/85

!145/90

? ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ НАЛИЧИЕ И ТЯЖЕСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+оценка состояния глазного дна

!суточная экскреция с мочой кортизола

!содержание альдостерона в крови

!суточная экскреция адреналина

? ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ЗУБЕЦ

!+RV5,V6>RV4

!RV4>RV5, V6

!S1>R1

!RП>RІ

? БОЛЬНЫМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ СЧИТАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ СИНДРОМА

!+метаболического

!астено-вегетативного

!диспептического

!постхолестеринемического

? АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ОБУСЛОВЛЕНА

!+повышением секреции катехоламинов

!повышением секреции ренина

!избыточной секрецией минералокортикоидов

!повышением образования ангиотензина

? ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

!+активация ренин-ангиотензиновой системы

!избыточная секреция минералокортикоидов

!повышенная секреция катехоламинов

!повышенное образование ангиотензина

? ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С СИНДРОМОМ ИЦЕНКО-КУШИНГ А НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

!+17-оксикортикостероида

!тиреотропина

!ренина

!креатинина

? ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ТАХИКАРДИЯ, ПОСЛЕ ПРИСТУПА - ПОЛИУРИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

!+феохромоцитомы

!синдрома Кона

!синдрома Иценко-Кушинга

!климактерического синдрома

? ЛЕВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА РАСШИРЕНА ПРИ

!+артериальной гипертонии

!митральном стенозе
!хроническом легочном сердце
!тромбоэмболии легочной артерии

? АКЦЕНТ 2 ТОНА НАД АОРТОЙ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

!+артериальной гипертонии
!митральном стенозе
!хроническом легочном сердце
!тромбоэмболии легочной артерии

? УСИЛЕНИЕ 1 ТОНА НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

!+митральном стенозе
!митральной недостаточности
!хроническом легочном сердце
!тромбоэмболии легочной артерии

? ЛЕВАЯ ГРАНИЦА СЕРДЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА ОБРАЗОВАНА

!+левым желудочком
!левым предсердием
!правым предсердием
!правым желудочком

? ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

!+акцент 2 тона над аортой
!усиление 1 тона у основания мечевидного отростка
!акцент 2 тона над легочной артерией
!ослабление 1 тона на верхушке

? ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНО С ПОВРЕЖДЕНИЕМ БОЛЕЕ %
МАССЫ МИОКАРДА

!+40
!10
!20
!15

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

!+фибрилляция желудочков
!атриовентрикулярная тахикардия
!электромеханическая диссоциация
!тахисистолическая форма мерцательной аритмии

? ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНЫ ХРИПЫ

!+влажные
!сухие экспираторные
!свистящие бифазные
!сухие высокотональные

? ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ПУЛЬСОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+снижение
!повышение
!сначала снижение, потом повышение
!сначала повышение, потом снижение

? КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ГИПОПЕРФУЗИИ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

!+олигурия
!полиурия
!брадикардия
!гиперемия кожных покровов

? К ИСТИННОМУ КАРДИОГЕННОМУ ШОКУ ЧАЩЕ ПРИВОДИТ

!+трансмуральный инфаркт миокарда
!пароксизмальная желудочковая тахикардия
!фибрилляция предсердий
!суправентрикулярная тахикардия

? КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

!+артериальная гипотония

!брадикардия
!полиурия
!артериальная гипертензия

? МОЛНИЕНОСНАЯ ФОРМА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА РАЗВИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (МИН.)

!+10
!20
!30
!15

? ШИРОКИМ СЧИТАЕТСЯ КОМПЛЕКС QRS БОЛЕЕ (СЕК.)

!+0,12
!0,10
!0,9
!0,5

? КОМПЛЕКС QRS ШИРИНОЙ 0,2 СЕК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ИМПУЛЬС БЫЛ ГЕНЕРИРОВАН В

!+желудочках
!предсердиях
!синусовом узле
!атривентрикулярном узле

? КОМПЛЕКС QRS ШИРИНОЙ 0,1 СЕК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ИМПУЛЬС БЫЛ ГЕНЕРИРОВАН В

!+предсердиях
!атривентрикулярном узле
!пучке Гиса
!желудочках

? ДИФФУЗНЫЕ, НЕСИММЕТРИЧНЫЕ, ДВУСТОРОННИЕ ЗАТЕМНЕНИЯ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ (СИМПТОМ «СНЕЖНОЙ БУРИ») ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

!+респираторного дистресс-синдрома взрослых
!кардиогенного отека легких
!пневмонии
!ателектаза

? НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ CO₂ СОСТАВЛЯЕТ (ММ РТ.СТ.)

!+35-45
!45-55
!20-35
!50-60

? ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

!+абсолютная гиповолемия
!относительная гиповолемия
!повышение сосудистого сопротивления
!снижение сократительной способности миокарда

? ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРОВОТОК В СОСУДАХ

!+коронарных
!почечных
!периферических
!легочных

? НАИБОЛЬШУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

!+прокальцитонина
!интерлейкина
!фибриногена
!липосахарида

? ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

!+мутации клетки-предшественницы лимфо-или миелопоэза
!нарушений эндокринной системы
!патологии нервной системы
!изменений обмена веществ

? ИЗ ВСЕХ ВАРИАНТОВ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ЧАЩЕ ВСЕГО РЕГИСТРИРУЕТСЯ

!+менингоэнцефалитический синдром

!поражение периферических нервов
!псевдотуморозный вариант
!поражение черепно-мозговых нервов

? ДЛЯ ДОСТОВЕРНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА УВЕЛИЧЕНИЕ БЛАСТОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)

!+20
!10
!15
!5

? ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ ХАРАКТЕРЕН ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ

!+гематомный
!пятнисто-петехиальный
!васкулитно-пурпурный
!смешанный

? ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИНДРОМА ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА

!+промиелоцитарного
!лимфобластного
!монобластного
!эритробластного

? ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ПОЛНОЙ КЛИНИКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО БЛАСТОВ В СТЕРИЛЬНОМ ПУНКТАТЕ МЕНЕЕ (%)

!+5
!2
!10
!20

? КРИТЕРИЕМ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ В ЛИКВОРЕ ЦИТОЗА ЗА СЧЕТ

!+бластоцита
!эритроцитоза
!нейтрофилёза
!моноцитов

? ДЛЯ ОСТРОГО МОНОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ПО ДАННЫМ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРНА

!+резко положительная реакция на альфа-нафтилацетатэстеразу
!выраженная реакция на гликоген
!положительная реакция на миелопероксидазу и липиды
!отрицательная реакция на альфа-ацетатнафтилацетатэстеразу

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НЕЙРОЛЕЙКЕМИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ

!+лимфобластном
!миелобластном
!промиелоцитарном
!мегакариобластном

? РЕЗИСТЕНТНАЯ ФОРМА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА КОНСТАТИРУЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛНОЙ КЛИНИКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ КУРСОВ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

!+двух
!одного
!трех
!четырёх

? ДЛЯ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦИТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРНА ВЫРАЖЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА В ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТКЕ

!+гликоген в гранулярной форме
!альфа-нафтилацетатэстеразу
!миелопероксидазу
!гликоген в диффузной форме

? ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ СВЯЗАНА С

!+массивной трансфузионной нагрузкой препаратами крови
!глубокой иммуносупрессией на фоне химиотерапии

!токсическим поражением гепатоцитов цитостатиками
!генетической предрасположенностью пациентов

? К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ПРОГНОЗА ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ ОТНОСИТСЯ

!+исходный лейкоцитоз выше $100 \times 10^9/\text{л}$
!мужской пол пациента
!выраженная лимфаденопатия в дебюте заболевания
!отсутствие лейкоцитоза

? ВЫСОКИЙ РИСК СПОНТАННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИМЕЕТСЯ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ТРОМБОЦИТОВ МЕНЕЕ ($\times 10^9/\text{л}$)

!+20
!60
!40
!80

? ПОВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ ХАРАКТЕРНО

ДЛЯ
!+эссенциальной тромбоцитемии
!гепарин-индуцированной тромбоцитопении
!тромботической тромбоцитопенической пурпуры
!апластической анемии

? ИЗ ВСЕГО ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ В ГЕМОГЛОБИН ВКЛЮЧАЕТСЯ (%)

!+ 70-73
!50-53
!40-43
!60-63

? КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ ($\times 10^9/\text{л}$)

!+150 - 400
!150 - 200
!150 - 250
!100 - 150

? ДЛЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ

!+пятнисто-петехиальный
!гематомный
!васкулитно-пурпурный
!ангиоматозный

? ПРИ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ В КОСТНОМ МОЗГЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

!+гиперплазия мегакариоцитарного ростка
!повышенный процент плазматических клеток
!угнетение мегакариоцитарного ростка
!бластоз

? ТЕНЯМИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА НАЗЫВАЮТСЯ

!+разрушенные ядра лимфоцитов
!полуразрушенные ядра моноцитов
!злокачественные клетки
!плохо окрашенные клетки

? УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

!+опухолевой природы
!увеличения эритропоэтина
!снижения эритропоэтина
!системной гипоксии

? ПЛЕТОРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

!+ярко-красным оттенком кожи и слизистых
!желтушным цветом кожи
!бледностью кожи и слизистых
!синюшным оттенком слизистых

? К ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

!+снижение уровня эритроцитов в крови
!повышение свободного гемоглобина в моче
!гипохромию эритроцитов

!повышение уровня непрямого билирубина

? ГЛАВНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ В КОСТНОМ МОЗГЕ ЯВЛЯЮТСЯ

!+более 10% плазматических клеток с чертами атипии

!лимфоидные клетки с чертами атипии

!плазмобласты в большом количестве

!миелобласты

? ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ

!+плоских костей

!длинных трубчатых костей

!крупных суставов

!межфаланговых суставов

? ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ И БОЛЕЕ % ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В КОСТНОМ

!+10

!5

!7

!3

? ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ «АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ», ЯВЛЯЕТСЯ

!+жировой метаморфоз кроветворного костного мозга в трепанобиоптате подвздошной кости

!панцитопения в периферической крови

!малоклеточный костный мозг по данным миелограммы

!повышение билирубина за счет не прямой фракции

? ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ

!+противовоспалительное

!бронходилатационное

!адреномиметическое

!антихолинергическое

? К АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

!+Ипратропия бромид

!Сальбутамол

!Беклометазон

!Фенотерол

? ОСНОВНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

!+глюкокортикоиды

!метилксантины

!ингибиторы фосфодиэстеразы 4

!нестероидные противовоспалительные средства

? БРОНХОСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

!+Пропранолол

!Фенотерол

!Беклометазон

!Сальбутамол

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИСПОЛЗУЮТСЯ

!+ингаляционные глюкокортикостероиды и р2-агонисты

!антибактериальные и муколитические препараты

!системные глюкокортикоиды и метилксантины

!кромоны и антигистаминные препараты

? АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТАМ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ НАЗНАЧАЕТСЯ В СЛУЧАЕ

!+увеличения объема и степени гнойности мокроты

!наличия признаков острой респираторной инфекции

!появления сухих свистящих хрипов

!длительного стажа курения

? В КАЧЕСТВЕ СТАРТОВОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ НЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫБРАН

!+Амоксициллин + Клавулановая кислота
!Ципрофлоксацин
!Гентамицин
!Тетрациклин

? ПРЕПАРАТОМ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫМ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+Гентамицин
!Оксациллин
!Азитромицин
!Карбенициллин

? УРОВЕНЬ КРЕАТИНИНА, ПРИ КОТОРОМ ПРОВОДЯТ ГЕМОДИАЛИЗ, СОСТАВЛЯЕТ (МКМОЛЬ/Л)

!+700
!400
!500
!600

? ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+Метотрексат
!Гидроксихлорохин
!Лефлуномид
!Сульфасалазин

? ЭФФЕКТИВНОЙ СХЕМОЙ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» ЯВЛЯЕТСЯ

!+пегилированный интерферон и Рибавирин
!интерферон и гепатопротекторы
!глюкокортикоиды и цитостатики
!Интерферон и Ламивудин

? ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЁНОЧНОЙ КОМЫ В ДИЕТЕ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ

!+белки
!углеводы
!соль
!жидкость

? ПРИ РАЗВИТИИ ТЯЖЁЛОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПОСТУПЛЕНИЕ БЕЛКА ОГРАНИЧИВАЮТ ДО (Г/СУТКИ)

!+15
!20
!30-40
!40-50

? У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК, ОСНОВНЫМИ В ЛЕЧЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ

!+изменение образа жизни и немедленное начало лекарственной терапии
!отказ от курения и отсрочка начала антигипертензивной терапии
!диетотерапия и эпизодический прием антигипертензивных препаратов
!ограничение физической нагрузки и психоэмоционального напряжения

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

!+Эналаприл
!Верапамил
!Нифедипин
!Бисопролол

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РЕКОМЕНДУЮТСЯ

!+бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
!антагонисты кальция дигидропиридинового ряда, тиазидные диуретики
!антагонисты рецепторов ангиотензина 2, антагонисты кальция
!антагонисты альдостерона, ганглиоблокаторы

? АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

!+беременность
!пожилой возраст
!фибрилляция предсердий

!гипокалиемия

? АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

!+подагра

!фибрилляция предсердий

!атриовентрикулярная блокада

!хроническая сердечная недостаточность

? НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ КАПТОПРИЛА ПРИ СУБЛИНГВАЛЬНОМ ПРИЕМЕ 25-50 МГ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ (МИН.)

!+10

!30

!15

!20

? ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ СЧИТАЕТСЯ ОСЛОЖНЕННЫМ ПРИ НАЛИЧИИ

!+острого нарушения мозгового кровообращения

!гипертрофической кардиомиопатии

!инфаркта легкого

!тромбоэмболии легочной артерии

? ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРВЫЕ 2 ЧАСА ДОЛЖНО СНИЖАТЬСЯ НА (%)

!+25

!15

!10

!35

? КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕРОДУАЛ СОДЕРЖИТ

!+фенотерола гидробромид и ипратропия бромид

!беклометазона дипропионат и ипратропия бромид

!сальбутамол и аминофиллин

!формотерол и ипратропия бромид

? ВВЕДЕНИЕ ЭПИНЕФРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПОКАЗАНО ПРИ

!+сочетании с анафилаксией

!среднетяжелом и тяжелом обострении

!непереносимости ацетилсалициловой кислоты

!острой вирусной инфекции

? ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

!+фибрилляции желудочков

!фибрилляции предсердий

!полной атриовентрикулярной блокаде

!асистолии

? АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ

!+в течение первого часа от постановки диагноза

!через 6 часов от постановки диагноза

!через 3 часа от постановки диагноза

!только после санации очага инфекции

? ПРЕДНИЗОЛОН ПРИ ИММУННЫХ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ АНЕМИЯХ НАЗНАЧАЮТ ВНУТРЬ В ДОЗЕ (МГ/КГ В СУТКИ)

!+1 -2

!3-4

!0,5-1

!5-6

? В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ГЛАВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

!+таблетированных препаратов железа

!мясной диеты

!гемотрансфузий

!парентеральных препаратов железа

? ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ ПРОВОДЯТ ВВЕДЕНИЕМ ХИМИОПРЕПАРАТОВ

!+эндолюмбальным

!внутривенным

!пероральным

!внутримышечным

? ПРИ ПНЕВМОНИЯХ, ВЫЗВАННЫХ ПНЕВМОКОККОМ, МИКОПЛАЗМОЙ И ЛЕГИОНЕЛЛОЙ, ОДИНАКОВО ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВУЕТ

!+Левофлоксацин

!Амоксициллин

!Цефтриаксон

!Ципрофлоксацин

? БОЛЬНОМУ ПНЕВМОНИЕЙ С УКАЗАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ НА АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ НА ПЕНИЦИЛЛИН СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

!+Кларитромицин

!Амоксициллин

!Цефазолин

!Гентамицин

? МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ВКЛЮЧАЕТ ИНГАЛЯЦИЮ

!+холинолитиков или P2 агонистов короткого действия по требованию

!P2 агонистов длительного действия по требованию

!P2 агонистов короткого действия 4 раза в день

!P2 агонистов длительного действия 2 раза в день

? ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ 3 СТЕПЕНИ И ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ С УКАЗАНИЯМИ НА АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ НА ПЕНИЦИЛЛИН ЯВЛЯЕТСЯ

!+Левофлоксацин

!Цефтриаксон

!Ципрофлоксацин

!Гентамицин

? БЕРЕМЕННОЙ, СТРАДАЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, МОЖНО НАЗНАЧИТЬ

!+Допегит

!Эналаприл

!Каптоприл

!Лозартан

? ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ В-12 ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РАЗВИТИЕ НА 7-8 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ

!+ретикулоцитоза

!ретикулоцитопении

!лейкоцитоза

!лейкопении

? РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ ПОКАЗАНА ПРИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

!+любой

!2

!3

!4

? ЧАСТОТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В (ГОД)

!+1

!0,5

!2

!3

? ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+эндоскопия

!рентгеноскопия

!рН - метрия

!УЗИ брюшной полости

? ГИГАНТСКИМИ СЧИТАЮТСЯ ЯЗВЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ (СМ)

!+3

!4

!5

!6

? В МОЧЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КЛЕТКИ ШТЕРНГЕЙМЕРА- МАЛЬБИНА ПРИ

!+пиелонефрите

!гломерулонефрите

!амилоидозе почек

!миеломной болезни

? ГОЛОДНЫЕ И/ИЛИ «НОЧНЫЕ БОЛИ», ВОЗНИКАЮЩИЕ ЧЕРЕЗ 2,5-4 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ПИЩИ, ЗАСТАВЛЯЮТ ДУМАТЬ О ЯЗВЕ

!+12-перстной кишки

!малой кривизны желудка

!фундального отдела желудка

!нижнего отдела пищевода

? ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНЕЗАПНУЮ ОСТАНОВКУ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА

!+врачом собственной безопасности; оценка сознания; оценка дыхания

!пульса и реакции зрачков на свет; оценка ранних трупных признаков

!роговичного (корнеального) рефлекса и симптома «кошачьего зрачка»

!температуры тела; оценка наличия трупных пятен и трупного окоченения

? ПОД ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОНИМАЮТ ГРУППУ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ИЛИ СИМПТОМОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОДОЗРЕВАТЬ

!+инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию

!стабильную стенокардию напряжения или впервые возникшую стенокардию

!постинфарктный кардиосклероз или хроническую аневризму левого желудочка !жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости

? ПОД СИНКОПАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОНИМАЮТ

!+преходящую потерю сознания вследствие общей гипоперфузии мозга

!обратимую потерю сознания вследствие эпилептического припадка или психогенной причины

!преходящую потерю сознания вследствие травматического повреждения головного мозга

!глубокое угнетение функции ЦНС вследствие экзогенной интоксикации

? ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ РАЗВИВАЮТСЯ УЗЕЛКИ БУШАРА НА

!+проксимальных межфаланговых суставах кисти

!1 и 2 дистальных межфаланговых суставах кисти

!всех плюснефаланговых суставах симметрично

!первых плюснефаланговых суставах симметрично

? НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

!+гломерулонефрита

!мочекаменной болезни

!хронического пиелонефрита

!вторичного амилоидоза

? ВЕДУЩИМ (ГЛАВНЫМ) МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦМЕТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

!+коронароспазм

!стенозирующий атеросклероз

!атеротромбоз коронарных сосудов !артериальная гипертензия

? ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

!+снижение фракции выброса левого желудочка

!умеренно выраженная гипертрофия левого желудочка

!аномальный ток крови из левого желудочка в левое предсердие

!увеличение передне-заднего размера левого предсердия

? БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+мозговой натрийуретический пептид

!белок связывающий жирные кислоты

!высокочувствительный тропонин I

!МВ-фракция креатинфосфокиназы

? К СИНКОПАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ОТНОСЯТ

!+обмороки

!комы I и II ст.

!панические атаки

!транзиторные ишемические атаки

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+ишемическая болезнь сердца

!дилатационная кардиомиопатия

!острый вирусный миокардит

!гипертрофическая кардиомиопатия

? КРОВОХАРКАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

!+инфарктной пневмонии

!идиопатического фибризирующего альвеолита

!острого инфаркта миокарда

!обострения хронического бронхита

? БРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ТЕСТ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ИНГАЛЯЦИИ БРОНХОДИЛАТАТОРА КОЭФФИЦИЕНТ БРОНХОДИЛАТАЦИИ (КБД) ДОСТИГАЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ (%)

!+15

!38

!20

!26

? ОСНОВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ УИПЛА ЯВЛЯЮТСЯ

!+антибиотики

!антацидные препараты

!атисекреторные препараты

!глюкокортикоиды

? МЕТОДОМ ВЫБОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ФИБРОКОЛОНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+приём Макрогола

!очистительная клизма

!очистительная клизма в сочетании с приёмом слабительного средства

!трёхдневное голодание

? ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

!+Апротинин

!Полиметилсилоксана полигидрат

!Магния гидроксид+Алгелдрат

!Окспренолол

? БОЛЬНОЙ С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ В СУТКИ СОЛИ (Г)

!+1-3

!5-6

!8-9

!11 -12

? МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СОСТАВЛЯЕТ (МЕС.)

!+6

!5

!2

!1

? ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОМИОЗИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+Преднизолон

!Амтолметина гуацил

!Лерканидипин

!Кальция карбонат + Колекальциферол

? В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА НЕ НАЗНАЧАЮТ

!+Аллопуринол

!Метилпреднизолон

!Ацеклоклофенак

!Канакинумаб

? НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ И СЕРЬЕЗНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ

!+кровотечения

!аллергические реакции

!разрывы миокарда

!инфекционные заболевания

? НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АМИОДАРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

!+дисфункция щитовидной железы

!синдром Стивенса-Джонсона

!остановка синусового узла

!острый инфаркт миокарда

? ПАЦИЕНТАМ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ВЫСОКИМ РИСКОМ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ/ИНСУЛЬТА (2 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ CHA2DS2-VASC ДЛЯ МУЖЧИН, 3 И БОЛЕЕ БАЛЛОВ - ДЛЯ ЖЕНЩИН) ПОКАЗАН ПРИЕМ

!+непрямых антикоагулянтов

!двойной антиагрегантной терапии

!блокаторов медленных кальциевых каналов

!ацетилсалициловой кислоты

? АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+расслаивающая аневризма аорты

!беременность и первая неделя после родов

!прием антагонистов витамина К

!травматическая и длительная сердечно-легочная реанимация

? К НЕРАЦИОНАЛЬНЫМ КОМБИНАЦИЯМ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ СОЧЕТАНИЕ

!+бета-адреноблокатора и недигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов

!дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов и тиазидного диуретика

!ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов

!дигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов и блокатора рецепторов к ангиотензину II

? ПАЦИЕНТУ С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ, РАЗВИВШЕМОУСЯ НА ФОНЕ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ, ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

!+электрокардиоверсии

!в/в введения Нитроглицерина

!в/в введения Метопролола

!постановки временной электрокардиостимуляции

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ НАДЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИКАРДИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-ВАЙТА НАИЛУЧШИМ СРЕДСТВОМ СЧИТАЕТСЯ

!+Амиодарон

!Новокаинамид

!Пропафенон

!Анаприлин

? У БОЛЬНОГО С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ХОБЛ И ПОСТБРОНХОДИЛАТАЦИОННЫМ ОФВ1 < 50% ОТ ДОЛЖНОГО ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

!+продолжительных бронхолитиков + ингаляционных глюкокортикостероидов

!в/в введения теofilлинов (Эуфиллина) + ингаляционных холинолитиков

!антибактериальных препаратов + короткодействующих бронхолитиков !короткодействующих бронхолитиков + в/в введение глюкокортикоидов

? К ПРЕПАРАТАМ ВТОРОЙ СТУПЕНИ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСЯТ

!+ингаляционные глюкокортикоиды

!B2- агонисты короткого действия по потребности

!теofilлин замедленного высвобождения

!B2- агонисты длительного действия

? ИНТЕНСИВНОСТЬ И СРОКИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

!+типом медицинского учреждения

!объемом поражения сердечной мышцы

!видом осложнений инфаркта миокарда

!наличием постинфарктной стенокардии

? ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ (ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА, ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ), ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ (ИШЕМИЧЕСКИЙ ИЛИ ГЕМОМРАГИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ, ТРАНЗИТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ АТАКА) И ПОЧЕЧНЫХ (ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК) ЗАБОЛЕВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+артериальная гипертензия

!малоподвижный образ жизни

!избыточная масса тела (ожирение)
!повышенное потребление в пищу поваренной соли (хлорида натрия)

? ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

!+болезни системы кровообращения
!злокачественные новообразования
!внешние причины, в том числе травмы
!болезни системы органов пищеварения

? К МАЛОВЕРОЯТНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТ

!+отеки
!лихорадку
!боли в поясничной области
!частое мочеиспускание

? НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

!+спирометрия
!бронхоскопия
!пикфлоуметрия
!бронхография

? ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ ОФВ1/ФЖЕЛ <70% И

!+ОФВ1 = 50-80%
!ОФВ1 > 80%
!ОФВ1 = 30-50%
!ОФВ1 < 80%

? ЗНАЧИМЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ПО ДАННЫМ ЭХО-КТ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСТУПАЕТ

!+вегетация на клапанах
!высокое давление наполнения левого желудочка
!наличие диастолической дисфункции
!наличие систолической дисфункции

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА, ЯВЛЯЕТСЯ

!+нарушение ритма
!отек легких
!кардиогенный шок
!острая сердечно-сосудистая недостаточность

? СПЕЦИФИЧЕСКИМ ИММУНОГЛОБУЛИНОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ НАЛИЧИЕ У БОЛЬНОГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+Ig E
!Ig M
!Ig A
!Ig G

? К ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

!+рентгенографическое исследование органов грудной клетки
!спирометрию
!бронхоскопию
!бронхографию

? ПОКАЗАНИЕМ К ПЛАНОВОЙ ФИБРОГАСТРОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+обострение хронического гастрита
!острый холецистит
!дёгтеобразный стул
!желудочное кровотечение

? ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ЗИМНИЦКОГО НЕОБХОДИМО

!+исключить избыточное потребление жидкости
!соблюдать строгую диету с исключением соли
!ограничить физическую активность
!ограничить употребление белковой пищи

? АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОЛОНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+декомпенсированная сердечная недостаточность
!тяжелая форма неспецифического язвенного колита
!острый парапроктит
!кровотоочащий геморрой

? СТАРТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПНЕВМОНИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВКЛЮЧАЕТ

!+макролиды нового поколения
!оральные цефалоспорины II поколения
!фторхинолоны
!аминогликозиды

? БОЛЬНЫМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ БРАДИКАРДИИ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

!+дигидропиридиновых антагонистов кальция
!бета-адреноблокаторов
!верапамила
!дилтиазема

? ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ

!+ингаляционные пролонгированные М-холинолитики
!ингаляционные пролонгированные бета2-агонисты
!пероральные глюкокортикостероиды
!пролонгированный теофиллин

? ДИСПАНСЕРНОМУ БОЛЬНОМУ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ РЕКОМЕНДУЕТ

!+Изосорбида динитрат короткодействующий
!Изосорбида мононитрат
!Верапамил
!Бисопролол

? ДИСПАНСЕРНОМУ БОЛЬНОМУ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА В ДОЗЕ (МГ/СУТ)

!+75-150
!25-50
!325-500
!500-1500

? К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ОТНОСЯТ

!+сухой кашель
!покраснение лица
!сердцебиение
!кожную сыпь

? ДЕПРЕССИЯ СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ ТИПИЧНА ДЛЯ

!+приступа стенокардии напряжения
!приступа вариантной (вазоспастической) стенокардии
!перикардита
!аневризмы левого желудочка

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО МИОКАРДИТА ЯВЛЯЮТСЯ

!+вирусные инфекции
!бактериальные инфекции
!грибковые инфекции
!воздействия токсинов

? ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВРОЖДЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИМЕЕТ СТЕНОЗ

!+лёгочной артерии
!аорты
!левого а-в отверстия
!правого а-в отверстия

? ПРИ РАЗВИТИИ ИФАРКТА МИОКАРДА НОРМАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МВ КФК В КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (СУТКИ)

!+2-3
!1

!5-6

!14

? ПА ТИП ГИПЕРЛИПИДЕМИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

!+липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)

!липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП)

!липопротеидов низкой плотности и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП)

!альфа липопротеидов (ЛП_а)

? ПБ ТИП ГИПЕРЛИПИДЕМИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

!+липопротеидов низкой плотности и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП)

!липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)

!липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП)

!альфа липопротеидов (ЛП_а)

? ХОЛЕСТЕРИН В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

!+синтезируется в печени и поступает с пищей

!синтезируется в печени и надпочечниках

!поступает исключительно с пищей

!синтезируется в печени и почках

? ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФОРМА СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

!+гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выносящего тракта левого желудочка

!дилатационной кардиомиопатии

!постинфарктном кардиосклерозе

!пролабировании митрального клапана с выраженной регургитацией

? К ДЕПРЕССОРНОМУ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ ПРИ РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСИТСЯ АКТИВАЦИЯ

!+мозгового и предсердного натрийуретических пептидов

!симпатоадреналовой системы (САС)

!ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС)

!антидиуретического гормона (АДГ)

? ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ИНФАРКТМ МИОКАРДА В АНАМНЕЗЕ ЦЕЛЕВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ ЛПНП, СОСТАВЛЯЮЩИЙ (ММОЛЬ/Л)

!+1,8

!2,5

!3,0

!3,5

? ДИАГНОЗ «МИОКАРДИТ» ДОСТОВЕРНО МОЖНО ПОСТАВИТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

!+биопсии миокарда

!эхокардиографии

!ЭКГ

!сцинтиграфии миокарда

? САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+атеросклероз коронарных артерий

!«мышечный» мостик

!коронарит

!гипертрофия левого желудочка

? К ПЕРВИЧНЫМ КАРДИОМИОПАТИЯМ ОТНОСИТСЯ

!+гипертрофическая

!алкогольная

!метаболическая

!дисгормональная

? ЦЕЛЕВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ЛПНП ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С СД 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С ИБС ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ МЕНЕЕ (ММОЛЬ/Л)

!+1,8

!2,0

!2,5

!3,0

? СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, КОРОНАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ОДЫШКА ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

!+гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) с обструкцией выносящего тракта левого желудочка (ЛЖ)
!недостаточности аортального клапана
!дилатационной кардиомиопатии (ДКМП)
!постинфарктном кардиосклерозе

? К МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСИТСЯ

!+сахарный диабет 2 типа
!возраст
!отягощенная наследственность
!мужской пол

? В ТАБЛИЦЕ SCORE ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ОТСУТСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ

!+глюкозы крови
!общего холестерина
!систолического АД
!возраста

? КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ НЕКРОЗА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

!+тропонин I
!миоглобин
!ЛДГ
!общая КФК

? ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

!+Колестиполом
!Аторвастатином
!Фенофибратом
!препаратами никотиновой кислоты

? ПРИ ВЫБОРЕ ИНГИБИТОРА АПФ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С ХСН И НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ

!+Фозиноприлу
!Лизиноприлу
!Периндоприлу
!Каптоприлу

? ПРИЕМ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ У БОЛЬНЫХ ХСН ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ

!+а-в блокаде II ст.
!а-в блокаде I ст.
!фибрилляции предсердий
!синусовой тахикардии

? НАИБОЛЬШИЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ ПРИ ПРИЕМЕ

!+Розувастатина
!Симвастатина
!Аторвастатина
!Правастатина

? ПРИЁМ СТАТИНОВ СЛЕДУЕТ ОТМЕНИТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ ТРАНСАМИНАЗ В КРОВИ ВЫШЕ НОРМЫ В (РАЗ)

!+3
!2
!4
!5

? К АНТАГОНИСТАМ МИНЕРАЛКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

!+Эплеренон
!Торасемид
!Триамтерен
!Индапамид

? К КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ

!+Триамтерен
!Индапамид
!Гидрохлортиазид
!Торасемид

? К ПОСТСИНАПТИЧЕСКИМ БЛОКАТОРАМ -АЛЬФА1 - АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

!+Доксазозин
!Моксонидин
!Алискирен
!Фентоламин

? ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ СТЕНКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В НОРМЕ ВЫГЛЯДИТ В ВИДЕ

!+однослойной изохогенной структуры, формирующей контур желчного пузыря
!однослойной криволинейной структуры, состоящей из гипо- и гиперэхогенного слоев
!двуслойной линейной структуры, состоящей из гипо- и гиперэхогенного слоев
!двуслойной гипохогенной структуры, формирующей контур желчного пузыря

? УВЕЛИЧЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО ПРИ

!+гепатоцеллюлярном раке
!карциноме толстой кишки
!раке поджелудочной железы
!карциноме желчного пузыря

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

!+Преднизолон
!Циклоспорин
!Триамцинолон
!Ламивудин

? УХУЖДЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ ВЫЗЫВАЕТ

!+ячмень
!гречиха
!рис
!кукуруза

? ПРИ КВАШИОРКОРЕ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ

!+отёк
!гиперальбуминемия
!гипергликемия
!эйфория

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

!+Метронидазол
!Цефалексин
!Ацикловир
!Омепразол

? ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ НЕ ПОРАЖАЕТСЯ ПРИ

!+псевдомембранозном колите
!инфекции, вызванной *Yersinia Enterocolitica*
!болезни Крона
!туберкулезе

? ДЛЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ХАРАКТЕРНО

!+наличие частых кровотечений
!безрецидивное течение
!сегментарное поражение
!появление трансмуральных язв

? НАЛИЧИЕ ТРИАДЫ СИМПТОМОВ - СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ, ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ ЖКТ, ДИАРЕЯ - УКАЗЫВАЕТ НА

!+синдром Золлингера-Эллисона
!язвенную болезнь с локализацией в желудке
!язвенный колит
!хронический панкреатит

? О СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ ГАСТРИТА СУДЯТ ПО КЛЕТОЧНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

!+лейкоцитами
!эозинофилами
!лимфоцитами
!макрофагами

? ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, ОТДЕЛЯЮЩЕЕСЯ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБЫЧНОМ ПИЩЕВОМ РЕЖИМЕ, СОСТАВЛЯЕТ (Л)

!+1,5-2
!1-1,5
!0,5-1
!2-2,5

? ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕЕ БОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО

!+биохимическое исследование крови
!копрологическое исследование
!исследование желудочной секреции
!рентгенологическое исследование

? РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К D-КСИЛОЗЕ ЗАВИСИТ ОТ

!+всасывающей функции тонкой кишки
!функции поджелудочной железы
!желудочной секреции
!функции печени

? ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВСАСЫВАНИЯ ВИТАМИНА В12 ЯВЛЯЕТСЯ

!+дистальный отдел подвздошной кишки
!проксимальный отдел подвздошной кишки
!проксимальный отдел тощей кишки
!дистальный отдел тощей кишки

? ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ КЛИНИКИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА НАИБОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ АМИЛАЗЫ КРОВИ МОЖНО ЗАФИКСИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ (ЧАС)

!+48-72
!12-18
!18-24
!24-48

? ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ГЕПАТИТЕ ЭХОГЕННОСТЬ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ

!+пониженная
!повышенная
!средней интенсивности
!нормальная

? ТИПИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ НА ЭКГ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИКАРДИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

!+элевация сегмента ST
!депрессия сегмента ST
!инверсия зубцов T
!развитие блокады левой ножки пучка Гиса

? САМЫМ РАННИМ БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ НЕКРОЗА ПРИ РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ

!+миоглобина
!МВ КФК
!тропонина I
!ЛДГ4

? ПРИ РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА УРОВЕНЬ ТРОПОНИНОВ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ПРИСТУПА

!+3-4
!1-2
!6-8
!12-24

? РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ВЕЛИК ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПОВЫШЕНИИ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

!+ЛПОНП
!ЛПВП
!ЛП(а)
!ЛПНП

? В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ В КРОВИ

!+натрийуретических пептидов
!катехоламинов
!альдостерона
!ренина

? К ВТОРИЧНЫМ КАРДИОМИОПАТИЯМ ОТНОСИТСЯ

- !+перипортальная
- !дилатационная
- !гипертрофическая
- !рестриктивная

? ЦЕЛЕВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ЛПНП ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПО ТАБЛИЦЕ SCORE ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ МЕНЕЕ (ММОЛЬ/Л)

- !+2,5
- !1,8
- !3,0
- !3,5

? ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+депрессия сегмента ST более 2 мм в точке J
- !появление отрицательных зубцов Т
- !снижение вольтажа всех зубцов
- !синусовая тахикардия

? ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- !+стенозирующем атеросклерозе периферических артерий
- !гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выносящего тракта левого желудочка
- !дилатационной кардиомиопатии
- !стенозе аортального клапана

? НЕСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+Карведилол
- !Бисопролол
- !Метопролол
- !Атенолол

? ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВАЗОДИЛАТАТОРОВ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- !+митральном стенозе
- !недостаточности митрального клапана
- !дилатационной кардиомиопатии
- !пролабиривании митрального клапана с регургитацией

? АТЕРОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

- !+а-адреноблокаторами
- !Р-адреноблокаторами
- !тиазидовыми диуретиками
- !глюкокортикостероидами

? К АРТЕРИАЛЬНЫМ ВАЗОДИЛАТАТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

- !+дигидропиридины
- !ингибиторы АПФ
- !постсинаптические а-адреноблокаторы
- !блокаторы рецепторов ангиотензина

? ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЛП (А) В ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

- !+фибраты
- !статины
- !секвестранты жирных кислот
- !Эзетимиб

? АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+двусторонний стеноз почечных артерий
- !гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выносящего тракта левого желудочка
- !аортальный стеноз
- !констриктивный перикардит

? ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ КАШЛЯ ПРИ ПРИЁМЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ СВЯЗАН С/СО

- !+увеличением продукции содержания брадикинина
- !увеличением продукции натрийуретических пептидов
- !снижением активности ренина плазмы
- !снижением содержания ангиотензина-II

? ПРИЁМ СТАТИНОВ СЛЕДУЕТ ОТМЕНИТЬ В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ФОНЕ МИАЛГИЙ ПОВЫШЕНИЯ В КРОВИ АКТИВНОСТИ КФК В (РАЗ)

!+5

!4

!3

!2

? К ВЕНОЗНЫМ ВАЗОДИЛАТАТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

!+нитраты

!дигидропиридины

!ингибиторы АПФ

!постсинаптические α -адреноблокаторы

? ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ИАПФ МОЖЕТ СНИЖАТЬСЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИЕМЕ

!нестероидных противовоспалительных средств

!антибиотиков

!антацидов

!секвестрантов желчных кислот

? ДИАГНОЗ «НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ» НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ

!+болях в эпигастральной области до приема пищи

!учащении приступов стенокардии

!появлении ночных приступов стенокардии

!выявлении стенокардии в течение 1 месяца

? ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА СЛЕДУЕТ РАСЦЕНИВАТЬ КАК ПОРОК МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА В СЛУЧАЕ

!+отрыва хордалных сухожилий

!дисфункции папиллярных мышц

!миксоматозной дегенерации одной из створок

!дилатации атриовентрикулярного кольца

? ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЯВЛЯЕТСЯ

!+остро возникшая митральная регургитация

!пролапс обеих створок

!нарушение ритма сердца по типу экстрасистолии

!митральная регургитация, которая занимает половину систолы

? ПРИЗНАКОМ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ О НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ПРОГНОЗЕ ПРИ ТЕСТЕ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+отсутствие подъема систолического АД выше 120 мм рт.ст.

!повышение АД и учащение ЧСС

!учащение ЧСС

!регистрация одиночной наджелудочковой экстрасистолии

? ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ МЕШАЕТ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+полная блокада левой ножки

!артериальная гипертензия

!нарушение ритма сердца

!атриовентрикулярная блокада

? К ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСИТСЯ

!+стеноз митрального клапана

!ишемическая болезнь сердца

!недостаточность аортального клапана

!гипертоническая болезнь

? К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

!+тетрада Фалло

!открытое овальное окно

!аневризма межпредсердной перегородки

!евстахийев клапан

? ЧАЩЕ ВСЕГО ВАЗОРЕНАЛЬНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У МУЖЧИН РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ

!+атеросклероза

!фибромускулярной дисплазии

!опухоли почки

!травмы почки

? СТЕНОЗ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

!+дуплексной доплероультрасонографии почек

!КТ почек

!МРТ почек

!ультразвукового исследования почек

? ПРИЗНАКОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+ретинопатия или нейроретинопатия

!высокий показатель систолического АД выше 220 мм рт.ст.

!снижение скорости клубочковой фильтрации

!протеинурия

? УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТНАГРУЗКИ НА СЕРДЦЕ ВЕДЕТ К

!+компенсаторной гипертрофии миокарда

!дилатации камер сердца

!легочной гипертензии

!снижению сократимости миокарда

? ОСЛАБЛЕНИЕ ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПРИ

!+эмфиземе лёгких

!артериальной гипертензии

!недостаточности митрального клапана

!стенозе аортального клапана

? УСИЛЕНИЕ ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПРИ

!+стенозе устья аорты

!эмфиземе легких

!ожирении

!аневризме аорты

? ТОЧКА БОТКИНА-ЭРБА, РАСПОЛАГАЮЩАЯСЯ В IV МЕЖРЕБЕРЬЕ СЛЕВА ОТ ГРУДИНЫ, СЛУЖИТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫСЛУШИВАНИЯ КЛАПАНА

!+аортального

!митрального

!трикуспидального

!легочной артерии

? ДЕФИЦИТ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ БОЛЬНЫХ С

!+фибрилляцией предсердий

!артериальной гипертензией

!полной блокадой левой ножки пучка Гиса

!недостаточностью аортального клапана

? НЕСООТВЕТСТВИЕ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА МЕТАБОЛИЧЕСКИМ НУЖДАМ МИОКАРДА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

!+ишемической болезни сердца

!гипертонической болезни

!дилатационной кардиомиопатии

!метаболического синдрома

? ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АД У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (ММ РТ.СТ.)

!+130/80

!140/90

!140/80

!120/80

? К СМЕШАННЫМ ВАЗОДИЛАТАТОРАМ ОТНОСЯТ

!+ингибиторы АПФ

!Карведилол

!Моксонидин

!Метилдопу

? «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

!+спирометрия

!бронхоскопия

!компьютерная томография

!пикфлоуметрия

? ПРИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ

- !+эозинофилия
- !тромбоцитоз
- !лимфоцитоз
- !нейтрофилез

? О ДЕСТРУКЦИИ ТКАНИ ЛЕГКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ В МОКРОТЕ

- !+эластических волокон
- !кристаллов Шарко-Лейдена
- !большого числа лейкоцитов
- !большого числа эритроцитов

? БОЛЬНОМУ В СОСТОЯНИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ

- !+глюкокортикостероиды
- !ингаляционные Р2 агонисты
- !периферические вазодилататоры
- !защищенные пенициллины

? КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+нормализация температуры через 48-72 часа
- !полное рассасывание инфильтрата в легочной ткани
- !нормализация всех лабораторных показателей
- !нормализация температуры в утренние и дневные часы

? В ТЕРАПИИ ХОБЛ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ

- !+бронходилататоры
- !ингаляционные глюкокортикостероиды
- !антибактериальные препараты
- !отхаркивающие препараты

? НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+дисфония
- !остеопороз
- !гипергликемия
- !ожирение

? ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ С ОТСУТСТВИЕМ ЭФФЕКТА ОТ ВЫСОКИХ ДОЗ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ И КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОКАЗАНО ДОБАВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ

- !+анти-IgE-антител
- !стабилизаторов мембран тучных клеток
- !антилейкотриенов
- !М-холинолитиков

? ПРИ ХОБЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ВАКЦИНОЙ

- !+противогриппозной
- !противокклюшной
- !противоменингококковой
- !противодифтерийной

? К СИМПТОМАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ КЛОНИДИНОМ (КЛОФЕЛИНОМ), ОТНОСЯТ

- !+гипотонию, брадикардию, сухость во рту, нарушение сознания
- !гипертензию, тахикардию, гиперсаливацию, гиперемию лица
- !тахикардию, профузное потоотделение, психомоторное возбуждение
- !сухость во рту, понос, боли в животе, запах ацетона изо рта

? ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В ВИДЕ

- !+вторичного амилоидоза
- !цитопенического синдрома
- !рефрактерной анемии
- !гемолитического синдрома

? ПЕРИОДОМ ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА (Т1/2) ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ

- !+снижения концентрации в плазме крови на 50%
- !снижения концентрации в моче на 50%
- !достижения органа-мишени 50% введенной дозы

!достижения максимальной концентрации в плазме крови

? ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЙ СХЕМОЙ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ХЕЛИКОБАКТЕРОМ ПИЛОРИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!+ингибитор протонной помпы + Амоксициллин 1000 мг*2 раза в сутки + Кларитромицин 500 мг х 2 раза в сутки

!ингибитор протонной помпы + Амоксициллин 500 мгх2 раза в сутки + Кларитромицин 500 мг х 2 раза в сутки

!блокатор H2-гистаминовых рецепторов + Амоксициллин 1000 мг х 2 раза в сутки + Кларитромицин 500 мг х 2 раза в сутки

!блокатор H2-гистаминовых рецепторов + Амоксициллин 1000 мг х 2 раза в сутки + Кларитромицин 500 мг х 1 раз в сутки

? ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ

!+ингибиторы протонной помпы

!блокаторы H2-рецепторов гистамина

!блокаторы дофаминовых рецепторов

!алюминийсодержащие гастропротекторы

? У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОБКРАДЫВАНИЯ, НЕ РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ

!+Дипиридамол

!Никорандил

!Рабепразол

!Домперидон

? ЖЕЛУДОЧКОВУЮ ТАХИКАРДИЮ ТИПА «ПИРУЭТ» СПОСОБЕН СПРОВОЦИРОВАТЬ

!+Соталол

!Верапамил

!Атенолол

!Дилтиазем

? ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

!+Амиодарон

!Дизопирамид

!Сульпирид

!Метформин

? ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ГИНЕКОМАСТИЮ И ГИРСУТИЗМ СПОСОБЕН ВЫЗВАТЬ ДИУРЕТИК

!+Спиронолактон

!Гидрохлортиазид

!Торасемид

!Фуросемид

? ПРИ РЕЦИДИВЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ НЕ РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЕНИЕ

!+Стрептокиназы

!Проурокиназы

!Алтеплазы

!Тенектеплазы

? КАРДИОТОКСИЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ВПЛОТЬ ДО РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ОБЛАДАЕТ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ

!+Доксорубицин

!Дактиномицин

!Блеомицин

!Сарколизин

? У ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНОЙ ФОРМОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

!+нитратов, дигидропиридинов, ингибиторов АПФ

!Верапамила, Дилтиазема, Атенолола

!Биспролола, Дизопирамида, Амиодарона

!Спиронолактона, Пропранолола, Соталола

? СИНДРОМ ОТМЕНЫ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

!+глюкокортикостероидов

!бисфосфонатов

!Триметазидина

!Ранолазина

? ПОЯВЛЕНИЮ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ СПОСОБСТВУЕТ ПРИЁМ

!+Изосорбида мононитрата

!Метопролола сукцината

!Стронция ранелата
!Алюминия гидроксида

? ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ (ГЕМОДИАЛИЗ, ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ) У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНЫМ ПОЧЕЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ АНТИКОАГУЛЯНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+Гепарин
!Варфарин
!Фондапаринкус
!Дабигатран

? ЭРИТРОПОЭЗСТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ НА БЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

!+эритропоэтины (альфа, бета, дельта, омега)
!ингибиторы пролилгидроксилазы
!ЭПО-миметики
!ингибиторы транскриптазы

? ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ИСПОЛЬЗУЮТ

!+стимуляторы эритропоэза
!стимуляторы лейкопоэза
!аналоги нуклеозидов
!иммунодепрессанты

? ПРИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НЕОБХОДИМО НАЗНАЧАТЬ КОМБИНИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ: СТИМУЛЯТОРЫ ЭРИТРОПОЭЗА С ПРЕПАРАТАМИ

!+железа
!кальция
!калия
!магния

? ПРИ СНИЖЕНИИ СКФ <30 МЛ/МИН/1,73 М2 ГИПЕРКАЛИЕМИЮ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

!+Спиронолактона
!Дабигатрана
!Фебуксостата
!Ивабрадина

? ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БИЛИАРНОГО СЛАДЖА (ПЕРВОЙ СТАДИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ) ЯВЛЯЕТСЯ

!+Урсодезоксихолевая кислота
!Аминометилбензойная кислота
!Аминодигидрофталазиндион натрия
!Протеинсукциниллат железа

? ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ

!+глюкокортикостероиды, цитостатики, антикоагулянты
!диуретики, белковые растворы, антикининовые препараты
!антигистаминные средства, антибиотики, поливитамины
!спиронолактоны, нитровазодилататоры, антагонисты кальция

? НЕ РЕКОМЕНДОВАНО СОВМЕСТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ (ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ АБСОРБЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ) С

!+Кетоконазолом
!Метопрололом
!Амоксициллином
!Аторвастатином

? ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕКИШЕЧНОЙ ФОРМЫ АМЕБИАЗА (АБСЦЕССА ПЕЧЕНИ) ЯВЛЯЮТСЯ

!+Метронидазол, Орнидазол, Тинидазол
!Паромомицин, Ципрофлоксацин, Меропенем
!Тетрациклин, Метациклин, Доксидиклин
!Доксорубицин, Карминомицин, Рубомицин

? К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ III КЛАССА (УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ) ОТНОСЯТ

!+Амиодарон, Соталол, Дронедарон
!Метопролол, Бетаксалол, Бисопролол
!Аллапинин, Пропафенон, Этагизин
!Хинидин, Новокаиномид, Дизопирамид

? У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК РЕКОМЕНДОВАНО ПРИМЕНЯТЬ ПО ПОВОДУ СОПУТСТВУЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

!+Лоратадин, Хифенадин
!Цетиризин, Акривастин
!Дезлоратадин, Левоцетиризин
!Сехифенадин, Фексофенадин

? ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ, ОТЯГОЩЕННОМ МУЧИТЕЛЬНЫМ НЕПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДОЗРЕНИЯ НА КОКЛЮШ), НЕ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

!+антибиотиков
!бронходилататоров
!муколитиков
!паронингаляций

? ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ МУЧИТЕЛЬНЫМ НЕПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРАВДАНЫМ ПРИ

!+подозрении на коклюш
!аллергической реакции
!сердечной недостаточности
!сахарном диабете 2 типа

? ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ НАЕМОНИЛUS INFLUENZAE, ЯВЛЯЮТСЯ

!+аминопенициллины
!оксазолидиноны
!тетрациклины
!сульфаниламиды

? ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШКАЛУ

!+CRB-65
!HAS-BLED
!SOFA
!MRC

? ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ (ЧАС)

!+48-72
!12-24
!72-96
!96-120

? ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АСПЕРГИЛЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

!+Вориконазол
!Каспофунгин
!Амфотерицин В
!Флуконазол

? РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)

!+14-21
!21-30
!7-14
!30-35

? ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕВМАТИЗМА ПРИМЕНЯЮТ

!+Бициллин
!Ампициллин
!Цефтриаксон
!Супрастин

? КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

!+международного нормализованного отношения (МНО)
!активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)
!активированного времени рекальцификации (АВР)
!растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК)

? ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ ВЕРАПАМИЛА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АСИСТОЛИЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОМ

!+Пропранолола
!Фенобарбитала
!Спиринолактона

!Фебуксостата

? НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИГОКСИНА С

!+Амiodароном, Хинидином, Верапамилом

!Аторвастатином, Нифедипином, Клопидогрелом

!Вальсартаном, Фенофибратом, Амлодипином

!Цетиризин, Омепразол, Деносуабом

? ПОДБОР СУТОЧНОЙ ДОЗЫ ДАБИГАТРАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

!+без контроля показателей коагулограммы

!под контролем международного нормализованного отношения

!под контролем всех показателей коагулограммы

!под контролем активированного частичного тромбопластинового времени

? ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПАРАЦЕТАМОЛ НА ФОНЕ

!+приема алкоголя, индукторов цитохромов печени Р-450 (Ш-блокаторов, глюкокортикоидов, фенобарбитала), голодания

!физической или эмоциональной нагрузок, хронической болезни почек, хронической обструктивной болезни легких

!приема ингибиторов абсорбции желчных кислот, омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, Омепразола

!приема миотропных спазмолитиков, м-холиноблокаторов, Циметидина, макролидных антибиотиков, Триметазидина

? ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕТОТРЕКСАТОМ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

!+трансаминазы, клиренс креатинина, клинический анализ крови, состояние легких по данным рентгенографии

!липидный профиль, иммунологический и серологический анализы крови, состояние миокарда по данным эхокардиографии

!гормональный анализ крови, суточную протеинурию, состояние печени и почек по данным ультразвукового исследования

!комплексный иммуногистохимический профиль, трофобластический бета-1 - гликопротеин, фенотипы лимфоцитов (основные субпопуляции)

? ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

!+Нитроглицерина

!Эналаприла

!Метопролола

!Фуросемида

? ШКАЛА GRACE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ

!+остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST

!ишемическом инсульте

!острой левожелудочковой недостаточности

!хронической сердечной недостаточности

? ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ УСПЕШНОЙ РЕПЕРФУЗИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛИЗИСА ЯВЛЯЕТСЯ

!+снижение элевации сегмента ST на 50% и более от исходного

!купирование болевого синдрома

!исчезновение признаков сердечной недостаточности

!восстановление АВ проводимости

? ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА ФОНЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

!+Амiodарон

!Новокаиномид

!Лидокаин

!Метопролол

? РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ОТ ПЕРВОГО КОНТАКТА С МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВотока в ИНФАРКТ-СВЯЗАННОЙ АРТЕРИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЧРЕСКОЖНОМ КОРОНАРНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ СОСТАВЛЯЕТ (МИН.)

!+120

!60

!180

!30

? «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЯВЛЯЕТСЯ

!+проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в течение 90-120 минут от первого контакта с медицинским персоналом

!проведение системной тромболитической терапии на догоспитальном этапе с последующим проведением ЧКВ

!проведение системной тромболитической терапии

!проведение ЧКВ в течение 24 часов после начала симптомов

? ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ ПОВЫШЕНИЕМ МАРКЕРОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА, ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ В ТЕЧЕНИЕ (ЧАС)

!+24

!48

!72

!96

? В СЛУЧАЕ СОХРАНЯЮЩЕГОСЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТМ МИОКАРДА, ПОКАЗАНО

!+проведение электроимпульсной терапии

!проведение инфузии Новокаинамида

!проведение инфузии Амиодарона

!введение наркотических анальгетиков

? ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ПРИЕМ ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ

!+неопределенно долго

!не менее года

!не более полугода

!два года

? АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+геморрагический инсульт в анамнезе

!язвенная болезнь желудка в анамнезе

!геморрагический васкулит

!артериальная гипертония

? НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СОСТАВЛЯЕТ (МГ)

!+250-300

!500

!150

!75

? ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПАРОКСИЗМА УСТОЙЧИВОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ НА ФОНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПОКАЗАНО

!+немедительное проведение электроимпульсной терапии

!проведение инфузии Кордарона

!проведение инфузии Лидокаина

!назначение бета-адреноблокаторов

? НАЗНАЧЕНИЕ ИНФУЗИИ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПОКАЗАНО ПРИ

!+отеке легких

!любой ситуации

!кардиогенном шоке

!сочетании со стенозом устья аорты

? ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

!+беременность

!гипокалиемия

!обструктивное заболевание легких

!гипергликемия

? ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ИАПФ В ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С АГ ЯВЛЯЕТСЯ

!+профилактика ремоделирования сосудов

!снижение частоты сердечных сокращений

!снижение сердечного выброса

!уменьшение объема циркулирующей крови

? У МУЖЧИНЫ 78 ЛЕТ С АДЕНОМОЙ ПРОСТАТЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ АГ С НАЗНАЧЕНИЯ

!+Доксазозина

!Карведилола

!Кандесартана

!Гидрохлортиазид

? БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С

!+ИБС (стенокардией и постинфарктным кардиосклерозом)

!нефропатией

!перенесенным инсультом
!подагрой

? ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ НЕДИГИДРОПИРИДИНОВОГО РЯДА ЯВЛЯЕТСЯ
!+атриовентрикулярная блокада
!блокада левой ножки пучка Гиса
!удлинение интервала QT
!запор

? ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
!+подагра
!сахарный диабет
!ИБС
!инсульт в анамнезе

? ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ САРТАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ
!+беременность
!подагра
!сахарный диабет
!инсульт в анамнезе

? ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА- АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ
!+атриовентрикулярная блокада 2-3 степени
!хроническая обструктивная болезнь легких
!хроническая сердечная недостаточность
!сахарный диабет

? У БОЛЬНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ГРУППЕ ВЫСОКОГО РИСКА, ЦЕЛЕВЫМ ЯВЛЯЕТСЯ АД МЕНЕЕ (ММ РТ.СТ.)
!+140/90
!130/80
!125/80
!130/85

? ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ ДИГИДРОПИРИДИНОВОГО РЯДА ЯВЛЯЕТСЯ
!+кардиогенный шок
!сердечная недостаточность
!беременность
!брадикардия

? ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА КОНА ЯВЛЯЕТСЯ
!+антагонист альдостерона
!антагонист кальция
!антагонист рецепторов 1 типа к ангиотензину II
!бета-адреноблокатор

? НАЗНАЧЕНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ АГ ПОКАЗАНО
!+при выявлении ИБС
!всем мужчинам старше 40 лет
!всем женщинам старше 60 лет
!при выявлении почечной недостаточности

? ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АГ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ
!+сартаны
!тиазидные диуретики
!прямые ингибиторы ренина
!бета-адреноблокаторы

? ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И СМЕРТИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ
!+статины и дезагреганты
!ИАПФ и дезагреганты
!статины и бета-адреноблокаторы
!статины и антагонисты кальция

? ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИСТУПОВ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЮТСЯ
!+бета-адреноблокаторы и антагонисты кальция
!антагонисты кальция и пролонгированные нитраты

!Ивабрадин и антагонисты кальция
!антагонисты кальция и Дигоксин

? ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ КЛОПИДОГРЕЛА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+непереносимость Ацетилсалициловой кислоты
!сопутствующая фибрилляция предсердий
!желудочно-кишечное кровотечение в анамнезе
!сопутствующая ХСН

? ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АПФ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

!+сопутствующая ХСН
!сопутствующая фибрилляция предсердий
!сопутствующий атеросклероз брахиоцефальных артерий
!сопутствующий периферический атеросклероз

? НАРУШЕНИЕ СИНТЕЗА ГЕМОГЛОБИНА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ АНЕМИИ

!+железодефицитной
!В12-дефицитной
!апластической
!гемолитической

? ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО

!+постепенное развитие
!острое начало
!кризовое течение
!выявление наследственности

? ИСТОНЧЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН, СУХОСТЬ И ЛОМКОСТЬ ВОЛОС, СГЛАЖЕННОСТЬ СОСОЧКОВ ЯЗЫКА, НАРУШЕНИЕ ГЛОТАНИЯ СУХОЙ ПИЩИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

!+сидеропенического синдрома
!общеемического синдрома
!фуникулярного миелоза
!гемолитического криза

? ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО

!+снижение ферритина и повышение ОЖСС
!повышение ферритина и снижение ОЖСС
!снижение ферритина и снижение ОЖСС
!повышение ферритина и повышение ОЖСС

? ПОКАЗАТЕЛЕМ, ОТРАЖАЮЩИМ РАЗМЕР ЭРИТРОЦИТА, В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

!+MCV
!MCH
!MCHC
!RDW

? ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОСТНОГО МОЗГА У БОЛЬНОГО СИДЕРОАХРЕСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

!+увеличение содержания сидеробластов
!мегалобластический тип кроветворения
!уменьшение содержания всех форменных элементов
!наличие большого количества миелобластов

? К ГРУППЕ ГИПОХРОМНЫХ АНЕМИЙ ОТНОСИТСЯ АНЕМИЯ

!+сидероахрестическая
!апластическая
!В12-дефицитная
!микросфероцитарная

? ГИПОХРОМИЯ ЭРИТРОЦИТОВ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

!+талассемии
!микросфероцитозе
!дефиците В12
!дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы

? У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЁМЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ НАБЛЮДАЕТСЯ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ АНЕМИИ

!+фолиеводефицитной

!железодефицитной
!В12-дефицитной
!гемолитической

? ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ СКЛОННОСТЬ К

!+панцитопении
!лейкоцитозу
!тромбоцитозу
!появлению миелоцитов

? ФУНИКУЛЯРНЫЙ МИЕЛОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНЕМИИ

!+В12-дефицитной
!апластической
!железодефицитной
!гемолитической

? ПОТЕМНЕНИЕ МОЧИ, ИКТЕРИЧНОСТЬ КОЖИ И СКЛЕР, БОЛИ В ЖИВОТЕ, УМЕРЕННАЯ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АНЕМИИ

!+гемолитической
!фолиеводефицитной
!железодефицитной
!В12-дефицитной

? РЕТИКУЛОЦИТОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНЕМИИ

!+гемолитической
!фолиеводефицитной
!железодефицитной
!В12-дефицитной

? К ГРУППЕ ГЕМОГЛОБИНОПАТИЙ ОТНОСИТСЯ АНЕМИЯ

!+серповидно-клеточная
!микросфероцитарная
!железодефицитная
!В12-дефицитная

? ГЕПАТО- И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИНДРОМА

!+гиперпластического
!геморрагического
!анемического
!инфекционно-токсического

? ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ,

ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

!+полицитемии
!острого лейкоза
!хронического лейкоза
!миелофиброза

? ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ХАРАКТЕРНО УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ БЕЛКА ЗА СЧЕТ

!+парапротеина
!гамма-глобулина
!альбумина
!альфа-глобулина

? ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ В РАЗВИТИИ АУТОИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

!+выработка аутоантитромбоцитарных антител
!образование патологических иммунных комплексов
!дефицит плазменных факторов свертывания
!активация тканевого тромбопластина

? МНОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ, ОБШИРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА, СЕПТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

!+ДВС-синдрома
!геморрагического васкулита
!гемолитической анемии
!болезни Рандю-Ослера

? КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ В ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+повышение уровня ретикулоцитов
- !уменьшение числа микроцитов
- !повышение уровня сывороточного железа
- !нормализация уровня билирубина

? ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКРОСФЕРОЦИТАРНОЙ АНЕМИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- !+спленэктомия
- !Цианкобаламин
- !ферротерапия
- !гормонотерапия

? ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- !+переливание эритроцитарной массы
- !переливание свежзамороженной плазмы
- !введение глюкокортикостероидов
- !проведение плазмафереза

? ВО ВРЕМЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИ АУТОИММУННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- !+назначение стероидов
- !переливание свежзамороженной плазмы
- !проведение плазмафереза
- !назначение антибиотиков

? ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+язвенная болезнь желудка в стадии обострения
- !язвенная болезнь желудка в стадии ремиссии
- !повторная беременность
- !планируемое оперативное лечение миомы матки

? ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗЕКЦИЯ

- !+тонкой кишки
- !толстой кишки
- !поджелудочной железы
- !правого легкого

? ПЕРВЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ТРЕХВАЛЕНТНОЕ) В ДОЗЕ (МГ)

- !+200-300
- !50-100
- !100-150
- !500-1000

? ПРИ СИДЕРОАХРЕСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ПРОТИВОПОКАЗАН

- !+Феррум Лек
- !Витамин В6
- !Десферал
- !Витамин С

? ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРОДОЛЖЕНИИ ФЕРРОТЕРАПИИ ОЦЕНИВАЮТ УРОВЕНЬ

- !+ферритина
- !сывороточного железа
- !общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)
- !трансферина

? ПРЕПАРАТОМ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+Мальтофер
- !Сорбифер
- !Ферретаб
- !Тотема

? ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ ФУМАРАТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+Ферретаб
- !Сорбифер
- !Мальтофер
- !Тотема

? ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ ГЛЮКОНАТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+Тотема
- !Мальтофер
- !Сорбифер
- !Ферретаб

? ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ СУЛЬФАТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- !+Сорбифер
- !Мальтофер
- !Ферретаб
- !Тотема

? ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА ВХОДИТ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА

- !+Матерна
- !Сорбифер
- !Тотема
- !Феррум Лек

? МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (МЕДЬ, МАРГАНЕЦ) ВХОДЯТ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА

- !+Тотема
- !Мальтофер
- !Сорбифер
- !Матерна

? ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЛЕЧЕНИЕ ВИТАМИНОМ В12 НАЧИНАЮТ С ДОЗЫ (МКГ В СУТКИ)

- !+500
- !200
- !100
- !300

? ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

- !+Эритропозтина
- !Преднизолон
- !Витамина В12
- !Фолиевой кислоты

? БЕРЕМЕННЫМ, ПОДРОСТКАМ, ЛИЦАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ДЛИТЕЛЬНО ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИМ АЛКОГОЛЕМ, ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧАТЬ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- !+фолиевую кислоту
- !витамин В12
- !микроэлементы
- !витамин С

? ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРОВОДИТСЯ

- !+ежемесячно по 500 мкг витамина В12
- !ежедневно по 500 мкг витамина В12
- !1000 мкг витамина В12 1 раз в год
- !1000 мкг витамина В12 1 раз в полгода

? ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ХАРАКТЕРНО

- !+преобладание АЛТ над АСТ
- !преобладание АСТ над АЛТ
- !изолированное повышение АЛТ
- !изолированное повышение АСТ

? ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН ПИЩЕВОДА

- !+с увеличением селезенки
- !с уменьшением селезенки
- !с эхонеоднородностью селезенки
- !со снижением эхоплотности селезенки

? ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- !+кальцинатов в головке поджелудочной железы
- !повышенной активности эластазы в кале
- !пониженной активности диастазы мочи
- !большого количества жира в кале

? ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ УРОВЕНЬ

- !+глюкозы и инсулина натощак
- !липазы и амилазы после пробного завтрака
- !холестерола и триглицеридов натощак
- !железа и витамина B12 после пробного завтрака

? ДЛЯ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ АКТИВНОСТЬ

- !+эластазы кала
- !липазы кала
- !эластазы крови
- !липазы крови

? ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭЛАСТАЗЫ КАЛА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЛУЖИТ ДЛЯ

- !+оценки степени внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы
- !дифференциальной диагностики опухолевых заболеваний и хронического панкреатита
- !оценки степени инкреторной недостаточности поджелудочной железы
- !диагностики повреждения островкового аппарата поджелудочной железы

? ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ «СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ» МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ ПОЛНОГО КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И

- !+исключения других заболеваний
- !гистологического подтверждения
- !иммуногистохимического подтверждения
- !ирригоскопического подтверждения

? ПРИ ПОВЫШЕНИИ БИЛИРУБИНА, ТИПИЧНОМ ДЛЯ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА, НАДО ИСКЛЮЧИТЬ

- !+гемолитическую анемию
- !инфекционный мононуклеоз
- !острый вирусный гепатит А
- !хроническую алкогольную интоксикацию
- ? ПРИЧИНОЙ ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ
- !+протеинов С и S
- !иммуноглобулина G
- !витамина К
- !алкогольдегидрогеназы

? ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ КОЛИТЕ ЯЗВЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В КИШКЕ

- !+сигмовидной
- !прямой
- !слепой
- !подвздошной

? ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ПОЧТИ ВСЕГДА ЗАТРАГИВАЕТ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ КИШКИ

- !+прямой
- !поперечной ободочной
- !подвздошной
- !восходящей ободочной

? ДИАГНОЗ «ГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ (ЦЕЛИАКИЯ)» ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕМ

- !+антител к тканевой транслугтаминазе в крови
- !непереваренного глиадина и ретикулина в кале
- !свободных дезаминированных пептидов глютена в моче
- !альфа-амилазы (птиалина) в виде L-изомера в слюне

? ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЛЮТЕНОВУЮ ЭНТЕРОПАТИЮ (ЦЕЛИАКИЮ) ПОКАЗАНО БОЛЬНЫМ

- !+сахарным диабетом 1 типа
- !алиментарным ожирением
- !наследственной гиперхолестеринемией
- !первичным наследственным гемохроматозом

? СТАДИЯ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В БЕЗ БИОПСИИ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА ПРИ ПОМОЩИ

- !+транзиентной эластографии

!компьютерной томографии с контрастированием
!магнитно-резонансной томографии
!дуплексного ультразвукового сканирования

? ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В В КРОВИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

!+анти- HBs и отсутствие анти-HBcor
!анти- HBs и наличие анти-HBcor
!анти-HBcor и отсутствие анти- HBs
!HBs антигена и отсутствие анти-HBe

? К ВНЕКИШЕЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ БОЛЕЗНИ КРОНА ОТНОСЯТ

!+узловатую эритему
!межкишечные свищи
!панкреатогенный сахарный диабет
!генерализованный эрозивный псориаз

? ПРИ ГЕПАТОКАРЦИНОМЕ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

!+альфафетопротеина
!прокальцитонина
!гамма-глобулина
!бетафитостерина

? ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ В КРОВИ ПОВЫШЕНО СОДЕРЖАНИЕ

!+гамма-глобулина и IgG
!бета-глобулина и IgA
!альфа2-глобулина и IgM
!альфа1-глобулина и IgE

? ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА В КРОВИ СНИЖЕНО СОДЕРЖАНИЕ

!+церулоплазмина
!гамма-глобулина
!альфафетопротеина
!альфа1 -антитрипсина

? ЛЕЧЕНИЕ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТРОНИДАЗОЛА

!+внутри
!внутривенно
!внутри и внутривенно
!в свечах и в виде ректальной пены

? ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ

!+миалгию
!кашель
!ишиалгию
!брадикардное

? ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРЕПАРАТОВ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

!+понос
!головная боль
!задержка стула
!сухость во рту

? ПРЕПАРАТЫ ЛАКТУЛОЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ОСНОВАНИИ ИХ
СПОСОБНОСТИ

!+подавлять образование аммиака в кишечнике
!подавлять образование аммиака в мышцах
!усиливать связывание аммиака в печени
!усиливать выведение аммиака почками

? ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДРАЖАЮЩИХ И ОСМОТИЧЕСКИХ СЛАБИТЕЛЬНЫХ МОЖЕТ СТАТЬ

!+лактаивная болезнь
!дивертикулярная болезнь толстой кишки
!синдром раздраженной толстой кишки
!синдром функциональной недостаточности мышц тазового дна

? ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПРЕДНИЗОЛОН НАЗНАЧАЮТ В ДОЗЕ 40 МГ/СУТ

!+перорально

!внутривенно
!внутримышечно
!в микроклизмах

? ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ГЕПАТИТА В КОНТРОЛИРУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В КРОВИ КОЛИЧЕСТВА АНТИТЕЛ К

!+HBs антигену
!HBs_{core} антигену
!HBe антигену класса IgA
!HBe антигену класса IgG

? СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

!+р₁ca chlorotica
!кожным зудом
!прогрессированием онихомикоза
!изменением дистальных фаланг пальцев по типу барабанных палочек

? НА СТАДИИ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЯВЛЯТЬСЯ

!+изменение морфологии эритроцитов
!снижение уровня гемоглобина
!снижение гематокрита
!ретикулоцитоз

? ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

!+повышение ОЖСС
!наличие мишеневидных эритроцитов
!микросфероцитоз
!снижение ОЖСС

? ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДИАГНОЗА «ПОРОК СЕРДЦА» НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+эхокардиография
!ЭКГ
!рентгенография грудной клетки
!исследование крови на титры антистрептококковых антител

? СРОК ФОРМИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНЫХ ПОРОКОВ ПОСЛЕ ЭПИЗОДА ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ СОСТАВЛЯЕТ

!+6-12 месяцев
!1-2 недели
!2-4 месяца
!3-5 лет

? «БОЛЬШИМИ» КРИТЕРИЯМИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЮТСЯ

!+ревмокардит, полиартрит, малая хорея, кольцевидная эритема
!вальвулит, артралгии, гематурия, лихорадка
!миокардит, полиартрит, узловатая эритема, тофусы
!лихорадка, узелки Ослера, острая клапанная регургитация

? ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ХАРАКТЕРНЫ

!+сердцебиение, ослабление I тона на верхушке, систолический шум, проводящийся в левую аксиллярную область
!перебои в работе сердца, трехчленный ритм на верхушке, синкопальные состояния
!кровохарканье, усиленный I тон на верхушке, диастолический шум на верхушке
!сердцебиение, ослабление I тона на верхушке, систолический шум в точке Боткина-Эрба

? К ТИПИЧНЫМ ЖАЛОБАМ БОЛЬНЫХ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ ОТНОСЯТ

!+синкопальные состояния
!тяжесть в правом подреберье
!опоясывающие боли в животе
!боли за грудиной постоянного характера

? ПРИ ФИЗИКАЛЬНОМ ОСМОТРЕ ПАЦИЕНТА С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ МОЖНО ВЫЯВИТЬ

!+громкий I тон
!пульсирующую печень
!ослабление I тона

!уменьшение пульсового давления

? ХАРАКТЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМОМ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЯВЛЯЕТСЯ

!+систолический шум на верхушке
!хлопающий I тон

!мезодиастолический шум
!систолический шум у основания сердца

? УСИЛЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

!+аортальной недостаточности
!аортального стеноза
!трикуспидальной недостаточности
!митральной недостаточности

? У БОЛЬНЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

!+систолическое АД повышается, а диастолическое АД снижается
!систолическое АД снижается, а диастолическое АД повышается
!систолическое АД не изменяется, а диастолическое АД повышается
!систолическое и диастолическое АД не изменяются

? СОЧЕТАНИЕ НА ЭКГ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О

!+митральном стенозе
!дефекте межпредсердной перегородки
!стенозе легочной артерии
!аортальной недостаточности

? ПРИ ОПРОСЕ БОЛЬНОГО С В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ МОЖНО ВЫЯВИТЬ

!+жжение на языке, парестезии
!рвоту «кофейной гущей» и дегтеобразный стул
!отрыжку горьким, боль в правом подреберье
!извращение вкуса и обоняния

?ДЛЯ ПОЛНОЙ АВ-БЛОКАДЫ ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ

!Правильный ритм
!+Учащение ЧСС при физической нагрузке
!Частота сердечных сокращений 36 в минуту
!Повышение систолического артериального давления
!Повышение систолического артериального давления
@MDID{C8824D48-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКАЯ ПРИЧИНА МОЖЕТ ЛЕЖАТЬ В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА МОРГАНЬИ-АДАМСА-СТОКСА ПРИ ПОЛНОЙ АВ БЛОКАДЕ

!Артериальная гипертония
!Сердечная недостаточность
!+Асистолия желудочков
!Атриовентрикулярная диссоциация
!Атриовентрикулярная диссоциация
@MDID{C8824D49-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫЯВЛЕНИЕ НА ЭКГ УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА PQ, РАВНОГО 0,23 СЕК. СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО

!Полной АВ блокады
!АВ блокада II степени Мобитц I
!Синдром WPW (преждевременного возбуждения желудочков)
!+АВ блокады I степени
!АВ блокады I степени
@MDID{C8824D4A-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ЧАСТОТА СОКРАЩЕНИЙ ЖЕЛУДОЧКОВ ЗАВИСИТ

!Скорости проведения импульса по предсердиям
!Состояния синоатриальной проводимости
!+Рефрактерности АВ-соединения
!Скорости проведения импульса по внутрижелудочковой проводящей системе
!Скорости проведения импульса по внутрижелудочковой проводящей системе
@MDID{C8824D4B-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ АВ-ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ ХАРАКТЕРНЫ ЭКГ ПРИЗНАКИ, КРОМЕ

!Неизмененные комплексы QRS
!Отсутствие зубца Р на ЭКГ или наличие его перед или после каждого комплекса QRS

!+Никакой связи с редкими зубцами Р и уширенными комплексами QRS
!Частота сердечных сокращений превышает более 130 ударов в минуту
!Частота сердечных сокращений превышает более 130 ударов в минуту
@MDID{C8824D4C-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?У БОЛЬНОГО ВНЕЗАПНО ВОЗНИК ПАРОКСИЗМ ТАХИКАРДИИ С ЧАСТОТОЙ 170 УДАРОВ В МИНУТУ, КОТОРЫЙ ВРАЧ КУПИРОВАЛ МАССАЖЕМ КАРОТИДНОГО СИНУСА. ПАРОКСИЗМ ТАХИКАРДИИ БЫЛ ОБУСЛОВЛЕН

!Синусовой тахикардией
!Пароксизмом фибрилляции предсердий
!+Суправентрикулярной (наджелудочковой) пароксизмальной тахикардией
!Пароксизмом желудочковой тахикардии
!Пароксизмом желудочковой тахикардии
@MDID{C8824D4D-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНАЯ ТАХИКАРДИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ, КРОМЕ

!Комплекс QRS не уширен
!+Частота сердечных сокращений до 120 ударов в 1 минуту
!Может быть купирован массажем каротидного синуса
!Внезапное начало и прекращение
!Внезапное начало и прекращение
@MDID{C8824D4E-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТМ МИОКАРДА РАЗВИЛСЯ ПРИСТУП СЕРДЦЕБИЕНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ РЕЗКОЙ СЛАБОСТЬЮ, ПАДЕНИЕМ АД. НА ЭКГ ЗУБЕЦ Р ОТСУТСТВУЕТ, QRS УШИРЕН БОЛЕЕ 0,12 СЕК., ДЕФОРМИРОВАН, ЧИСЛО ЖЕЛУДОЧКОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ 160 В/МИН. КАКОЕ НАРУШЕНИЕ РИТМА У БОЛЬНОГО?

!Суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия
!Пароксизм фибрилляции предсердий
!Трепетание предсердий
!+Пароксизм желудочковой тахикардии
!Пароксизм желудочковой тахикардии
@MDID{C8824D4F-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?УКАЖИТЕ ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ КАРДИОГЕННОГО ШОКА И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ

!Полная АВ-диссоциация
!+Частый ритм
!Болевой синдром
!Этиологический фактор
!Этиологический фактор
@MDID{C8824D50-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ СУСТАВЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

!1 плюснефаланговый сустав
!Дистальные межфаланговые суставы
!+Проксимальные межфаланговые суставы
!Суставы поясничного отдела позвоночника
!Суставы поясничного отдела позвоночника
@MDID{C8824D51-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?РЕНГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

!+Остеопороз и эрозии
!Остеофитоз и остеосклероз
!Межпозвоночные оссеификаты
!Односторонний сакроилеит
!Односторонний сакроилеит
@MDID{C8824D52-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ СУСТАВЫ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

!плюснефаланговый сустав
!Дистальные межфаланговые суставы
!+Проксимальные межфаланговые суставы

!Суставы поясничного отдела позвоночника
!Суставы поясничного отдела позвоночника
@MDID{C8824D53-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОТНОСИТСЯ
!+Антитела к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП)
!Антинуклеарный фактор (АНФ)
!Антитела к двуспиральной ДНК
!Антицентромерные антитела (АЦА)
!Антицентромерные антитела (АЦА)
@MDID{C8824D54-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ОСТЕОАРТРОЗА ХАРАКТЕРНЫ ВСЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, КРОМЕ
!Наличие болей механического характера
!Рентгенологически выявляется остеосклероз, остеофиты и сужение суставной щели
!Развитие деформации за счет костных разрастаний
!+Чаще поражается 1 плюснефаланговый сустав
!Чаще поражается 1 плюснефаланговый сустав
@MDID{C8824D55-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО ОСТЕОАРТРОЗОМ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ
!+Узелки Бушара
!Деформация пальцев в виде «шеи лебедя»
!Ульнарная девиация
!Покраснение в области суставов
!Покраснение в области суставов
@MDID{C8824D56-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПЕРЕЧИСЛИТЕ КРИТЕРИИ ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ПОДАГРЫ
!Узелки Бушара и Гебердена
!+Припухание и боль в плюснефаланговом суставе, подозрение на тофусы
!Симметричный артрит 3-х и более суставов
!Двухсторонний сакроилеит
!Двухсторонний сакроилеит
@MDID{C8824D57-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТОФУСЫ?
!Отложение в тканях холестерина
!Остеофиты
!+Отложение в тканях уратов
!Воспаление гранулемы
!Воспаление гранулемы
@MDID{C8824D58-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВАСКУЛИТОВ ОТНОСЯТСЯ К АНЦА (АНТИНЕЙТРОФИЛЬНЫЕ ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ АНТИГЕНЫ)-АССОЦИИРОВАННЫМ?
!+Микроскопический полиангиит
!Артериит Такаясу
!Гигантоклеточный артериит
!Синдром Кавасаки
!Синдром Кавасаки
@MDID{C8824D59-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СИНДРОМЫ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
!Суставно-мышечный
!+Гепатолиенальный
!Кожный
!Почечный
!Почечный
@MDID{C8824D5A-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?СИСТЕМНЫЕ ВАСКУЛИТЫ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ ПРИМЕНЕНИЕМ

!Гипотензивных препаратов
!Цитостатиков
!Глюкокортикоидов
!+Антибиотиков
!Антибиотиков
@MDID{C8824D5B-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ГЕМОФИЛИИ ХАРАКТЕРНО ВСЕ, КРОМЕ
!Возможной остановки кровотечения на фоне переливания СЗП
!+Петехиального типа кровоточивости
!Наследственного характера
!Удлинения АЧТВ
!Удлинения АЧТВ
@MDID{C8824D5C-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?УКАЖИТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ГЕМОФИЛИИ
!Удлинение времени свертывания крови
!+Удлинение времени кровотечения
!Снижение протромбинового показателя
!Нарушение ретракции кровяного сгустка
!Нарушение ретракции кровяного сгустка
@MDID{C8824D5D-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ ХАРАКТЕРНО
!Васкулитно-пурпурный тип кровоточивости
!+Ангиоматозный тип кровоточивости, наличие телеангиэктазий
!Гематомный тип кровоточивости, дефицит фактора VIII
!Смешанный тип кровоточивости, снижение уровня антитромбина III
!Смешанный тип кровоточивости, снижение уровня антитромбина III
@MDID{C8824D5E-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?С КАКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛЕДУЕТ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
!+Геморрагическим васкулитом
!Гемофилией
!Воспалением легких
!Бронхоэктатической болезнью
!Бронхоэктатической болезнью
@MDID{C8824D5F-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?УКАЖИТЕ ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ВАСКУЛИТЕ
!+Васкулитно-пурпурный
!Гематомный
!Ангиоматозный
!Смешанный
!Смешанный
@MDID{C8824D60-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ БОЛЕЗНИ Ослера-Рандю СПРАВЕДЛИВО
!Время кровотечения не изменено
!При тяжелых формах показана спленэктомия
!+Нередки случаи семейного заболевания
!АЧТВ увеличено
!АЧТВ увеличено
@MDID{C8824D61-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ЛЕЧЕНИИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ
!Применяется викамол
!Эффективны глюкокортикоиды
!Спленэктомия неэффективна
!+Цитостатики не применяются
!Цитостатики не применяются
@MDID{C8824D62-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Диагностика Артериальных гипертензий

?СТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
!Давностью АГ

!+Уровнем АД
!Наличием факторов риска
!Степенью поражения «органов мишеней»
!Степенью поражения «органов мишеней»
@MDID{D84046F8-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВОЗНИКНОВЕНИЕ АГ ПОСЛЕ 55 ЛЕТ И ВЫСЛУШИВАНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА В ОКОЛОПУПЧНОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗЫВАЕТ НА ВОЗМОЖНОСТЬ
!Первичного гиперальдостеронизма
!+Реноваскулярной гипертензии
!Феохромоцитомы
!Коарктации аорты
!Коарктации аорты
@MDID{D84046F9-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КРИТЕРИЯМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АГ К ГРУППЕ РИСКА 3 СТЕПЕНИ НУЖНО СЧИТАТЬ
!+1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть поражения «органов- мишеней», нет
сердечно-сосудистых заболеваний
!1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, нет поражения «органов- мишеней», нет сердечно-
сосудистых ассоциированных заболеваний
!1-2 ст. АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть ассоциированные сердечно-сосудистые
заболевания
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
@MDID{D84046FA-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 2 СТАДИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
!Гипокалиемией
!Стойким повышением АД выше 160/100
!Выраженной протеинурией
!+Гипертрофией левого желудочка
!Гипертрофией левого желудочка
@MDID{D84046FB-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВАЗОДИЛАТИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ
!+Оксид азота
!Эндотелин
!Тромбоксан
!Простагландины F2
!Простагландины F2
@MDID{D84046FC-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ АГ У БОЛЬНОГО С ПОЛИУРИЕЙ, МЫШЕЧНОЙ СЛАБОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ
!Феохромоцитомы
!Гипертоническая болезнь
!+Первичный гиперальдостеронизм
!Хронический пиелонефрит
!Хронический пиелонефрит
@MDID{D84046FD-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КРИТЕРИЯМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АГ К ГРУППЕ РИСКА 3 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ
!+1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть поражения «органов-мишеней», нет
сердечно-сосудистых заболеваний
!1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, нет поражения «органов- мишеней», нет сердечно-
сосудистых ассоциированных заболеваний
!1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть ассоциированные сердечно-сосудистые
заболевания
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
@MDID{D84046FE-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К ОРГАНАМ-МИШЕНЯМ ПРИ АГ ОТНОСИТСЯ
!Сердце, сетчатка, скелетная мускулатура, головной мозг
!+Сердце, почки, головной мозг, артерии сетчатки
!Печень, почки, сердце, артерии сетчатки
!Почки, печень, сердце, сетчатка, головной мозг
!Почки, печень, сердце, сетчатка, головной мозг
@MDID{D84046FF-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ ГИПЕРТОНИИ ПРИ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

!Нарушение микроциркуляции в коронарных артериях

!Недостаточность мозгового кровообращения

!Присоединение атеросклероза магистральных артерий

!+Ишемия внутренних органов ниже места сужения

!Ишемия внутренних органов ниже места сужения

@MDID{D8404700-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ХАРАКТЕРНА

!Базофильная аденома надпочечников, продуцирующих АКТГ

!+Опухоль из хромоафинной ткани мозгового слоя надпочечников

!Первичный гиперальдостеронизм

!Гипокалиемия

Диагностика лимфопролиферативных заболеваний

!Гипокалиемия

Диагностика лимфопролиферативных заболеваний

@MDID{D8404701-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ЭРИТРЕМИИ ЛЕЖИТ

!Преимущественная пролиферация эритроидных элементов

!+Пролиферация лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов

!Пролиферация эритроцитов и тромбоцитов

!Пролиферация лейкоцитов и эритроцитов

!Пролиферация лейкоцитов и эритроцитов

@MDID{D8404702-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?РЕШАЮЩИМ ЛАБОРАТОРНЫМ СИМПТОМОМ В ДИАГНОЗЕ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

!Увеличение СОЭ

!Анемия

!+Бластемия

!Выраженный геморрагический синдром

!Выраженный геморрагический синдром

@MDID{D8404703-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСТРЫЙ МИЕЛОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

!Незначительное увеличение селезенки и печени

!Наличие гингивитов и некротической ангины

!Гиперлейкоцитоз, тромбоцитоз

!+Наличием цитопенического синдрома, появления бластов в периферической крови, низким содержанием переходных форм

!Наличием цитопенического синдрома, появления бластов в периферической крови, низким содержанием переходных форм

@MDID{D8404704-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ КАКОГО ВАРИАНТА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ХАРАКТЕРНО РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДВС - СИНДРОМА:

!+Острый промиелоцитарный лейкоз

!Острый миелобластный лейкоз

!Острый монобластный лейкоз

!Острый эритромиелоз

!Острый эритромиелоз

@MDID{D8404705-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА НЕХАРАКТЕРНО

!Неспецифические кожные высыпания

!Кожные лейкемиды

!Гепатоспленомегалия

!+Фуникулярный миелоз

!Фуникулярный миелоз

@MDID{D8404706-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

!Химические

!Лучевые

!+Все перечисленное

!Хромосомные повреждения

!Хромосомные повреждения

@MDID{D8404707-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

!+Клональная миелопролиферация с чрезмерным образованием гранулоцитов в костном мозге и экстрамедуллярно

!Дефект мембраны гранулоцитов

!Злокачественная пролиферация эритроцитов, гранулоцитов и мегакариоцитов

!Злокачественная пролиферация плазматических клеток одного клона

!Злокачественная пролиферация плазматических клеток одного клона

@MID{D8404708-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

ПОНЯТИЕ ОПУХОЛЕВАЯ ПРОГРЕССИЯ ЛЕЙКОЗОВ ОЗНАЧАЕТ

!+Все перечисленное

!Более злокачественное течение

!Прогрессирование процесса

!Появление новых автономных, более патологических клонов клеток

!Появление новых автономных, более патологических клонов клеток

@MID{D8404709-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

У БОЛЬНЫХ С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕКРОЗ МИОКАРДА, МАССОЙ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ:

!50%

!30%

!+40%

!20%

!20%

@MID{D840470A-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

КАКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА?

!Артериальная гипотензия

!+Полиурия

!Олигурия

!Бледность кожных покровов

!Бледность кожных покровов

@MID{D840470B-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

ДЛЯ КЛИНИКИ ОСТРОЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕ ХАРАКТЕРНО:

!Увеличение печени

!+Акцент II тона над аортой

!Набухание шейных вен

!Акцент II тона над легочной аортой

!Акцент II тона над легочной аортой

@MID{D840470C-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

К ПРОЯВЛЕНИЯМ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТСЯ:

!Гепатомегалия

!+Отек легких

!Артериальная гипотензия и снижение кровоснабжения жизненно важных органов

!Периферические отеки

!Периферические отеки

@MID{D840470D-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:

!Разрыва межжелудочковой перегородки

!Разрыва головки папиллярной мышцы

!+Перикардита

!Разрыва левого желудочка

!Разрыва левого желудочка

@MID{D840470E-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСТОЧНИКОМ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

!+Вены нижних конечностей

!Вены верхних конечностей

!Правое сердце

!Вены таза

!Вены таза

@MID{D840470F-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ СОЧЕТАНИЕМ СИМПТОМОВ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ:

!Бронхоспазм, кровохарканье, тахикардия
!+Одышка, цианоз, тахикардия
!Цианоз, бронхоспазм, тахикардия
!Кровохарканье, коллапс, одышка
!Кровохарканье, коллапс, одышка
@MDID{D8404710-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:

!Венозный застой в большом круге кровообращения
!Слабость
!Отеки ног
!+Приступы сердечной астмы
!Приступы сердечной астмы
@MDID{D8404711-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНОЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ МАРКЕР ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:

!Тропонин Т
!Тропонин I
!+Предсердный натрийуретический пептид
!МВ-фракция КФК
!МВ-фракция КФК
@MDID{D8404712-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?СТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

!Давностью АГ
!+Уровнем АД
!Наличием факторов риска
!Степенью поражения «органов мишеней»
!Степенью поражения «органов мишеней»
@MDID{2A42C37B-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВОЗНИКНОВЕНИЕ АГ ПОСЛЕ 55 ЛЕТ И ВЫСЛУШИВАНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА В ОКОЛОПУПЧОНОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗЫВАЕТ НА ВОЗМОЖНОСТЬ

!Первичного гиперальдостеронизма
!+Реноваскулярной гипертензии
!Феохромоцитомы
!Коарктации аорты
!Коарктации аорты
@MDID{2A42C37C-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КРИТЕРИЯМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АГ К ГРУППЕ РИСКА 3 СТЕПЕНИ НУЖНО СЧИТАТЬ

!+1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть поражения «органов-мишеней», нет сердечно-сосудистых заболеваний
!1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, нет поражения «органов-мишеней», нет сердечно-сосудистых ассоциированных заболеваний
!1-2 ст. АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть ассоциированные сердечно-сосудистые заболевания
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
@MDID{2A42C37D-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 2 СТАДИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

!Гипокалиемией
!Стойким повышением АД выше 160/100
!Выраженной протеинурией
!+Гипертрофией левого желудочка
!Гипертрофией левого желудочка
@MDID{2A42C37E-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВАЗОДИЛАТИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

!+Оксид азота
!Эндотелин
!Тромбоксан
!Простагландины F2
!Простагландины F2
@MDID{2A42C37F-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ АГ У БОЛЬНОГО С ПОЛИУРИЕЙ, МЫШЕЧНОЙ СЛАБОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

!Феохромоцитомы
!Гипертоническая болезнь
!+Первичный гиперальдостеронизм
!Хронический пиелонефрит
!Хронический пиелонефрит
@MDID{2A42C380-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КРИТЕРИЯМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ АГ К ГРУППЕ РИСКА 3 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ
!+1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть поражения «органов-мишеней», нет сердечно-сосудистых заболеваний
!1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, нет поражения «органов-мишеней», нет сердечно-сосудистых ассоциированных заболеваний
!1-2 ст АГ, имеется 1 или более факторов риска, есть ассоциированные сердечно-сосудистые заболевания
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
!2-3 ст АГ, нет факторов риска, нет поражения «органов-мишеней»
@MDID{2A42C381-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К ОРГАНАМ-МИШЕНЯМ ПРИ АГ ОТНОСИТСЯ
!Сердце, сетчатка, скелетная мускулатура, головной мозг
!+Сердце, почки, головной мозг, артерии сетчатки
!Печень, почки, сердце, артерии сетчатки
!Почки, печень, сердце, сетчатка, головной мозг
!Почки, печень, сердце, сетчатка, головной мозг
@MDID{2A42C382-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ ГИПЕРТОНИИ ПРИ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ
!Нарушение микроциркуляции в коронарных артериях
!Недостаточность мозгового кровообращения
!Присоединение атеросклероза магистральных артерий
!+Ишемия внутренних органов ниже места сужения
!Ишемия внутренних органов ниже места сужения
@MDID{2A42C383-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ХАРАКТЕРНА
!Базофильная аденома надпочечников, продуцирующих АКТГ
!+Опухоль из хромоафинной ткани мозгового слоя надпочечников
!Первичный гиперальдостеронизм
!Гипокалиемия
Диагностика лимфопролиферативных заболеваний
!Гипокалиемия
Диагностика лимфопролиферативных заболеваний
@MDID{2A42C384-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ЭРИТРЕМИИ ЛЕЖИТ
!Преимущественная пролиферация эритроидных элементов
!+Пролиферация лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов
!Пролиферация эритроцитов и тромбоцитов
!Пролиферация лейкоцитов и эритроцитов
!Пролиферация лейкоцитов и эритроцитов
@MDID{2A42C385-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?РЕШАЮЩИМ ЛАБОРАТОРНЫМ СИМПТОМОМ В ДИАГНОЗЕ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
!Увеличение СОЭ
!Анемия
!+Бластемия
!Выраженный геморрагический синдром
!Выраженный геморрагический синдром
@MDID{2A42C386-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСТРЫЙ МИЕЛОБЛАСТНЫЙ ЛЕЙКОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
!Незначительное увеличение селезенки и печени
!Наличие гингивитов и некротической ангины
!Гиперлейкоцитоз, тромбоцитоз
!+Наличием цитопенического синдрома, появления бластов в периферической крови, низким содержанием переходных форм
!Наличием цитопенического синдрома, появления бластов в периферической крови, низким содержанием переходных форм

@MDID{2A42C387-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ КАКОГО ВАРИАНТА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ХАРАКТЕРНО РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДВС - СИНДРОМА:

!+Острый промиелоцитарный лейкоз

!Острый миелобластный лейкоз

!Острый монобластный лейкоз

!Острый эритромиелоз

!Острый эритромиелоз

@MDID{2A42C388-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА НЕХАРАКТЕРНО

!Неспецифические кожные высыпания

!Кожные лейкемиды

!Гепатоспленомегалия

!+Фуникулярный миелоз

!Фуникулярный миелоз

@MDID{2A42C389-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

!Химические

!Лучевые

!+Все перечисленное

!Хромосомные повреждения

!Хромосомные повреждения

@MDID{2A42C38A-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

!+Клональная миелопролиферация с чрезмерным образованием гранулоцитов в костном мозге и экстрамедуллярно

!Дефект мембраны гранулоцитов

!Злокачественная пролиферация эритроцитов, гранулоцитов и мегакариоцитов

!Злокачественная пролиферация плазматических клеток одного клона

!Злокачественная пролиферация плазматических клеток одного клона

@MDID{2A42C38B-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПОНЯТИЕ ОПУХОЛЕВАЯ ПРОГРЕССИЯ ЛЕЙКОЗОВ ОЗНАЧАЕТ

!+Все перечисленное

!Более злокачественное течение

!Прогрессирование процесса

!Появление новых автономных, более патологических клонов клеток

!Появление новых автономных, более патологических клонов клеток

@MDID{2A42C38C-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?У БОЛЬНЫХ С КАРДИОГЕННЫМ ШОКОМ ОТМЕЧАЕТСЯ НЕКРОЗ МИОКАРДА, МАССОЙ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ:

!50%

!30%

!+40%

!20%

!20%

@MDID{2A42C38D-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА?

!Артериальная гипотензия

!+Полиурия

!Олигурия

!Бледность кожных покровов

!Бледность кожных покровов

@MDID{2A42C38E-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ КЛИНИКИ ОСТРОЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕ ХАРАКТЕРНО:

!Увеличение печени

!+Акцент II тона над аортой

!Набухание шейных вен

!Акцент II тона над легочной аортой

!Акцент II тона над легочной аортой

@MDID{2A42C38F-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К ПРОЯВЛЕНИЯМ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТСЯ:

!Гепатомегалия
!+Отек легких
!Артериальная гипотензия и снижение кровоснабжения жизненно важных органов
!Периферические отеки
!Периферические отеки
@MDID{2A42C390-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ:
!Разрыва межжелудочковой перегородки
!Разрыва головки папиллярной мышцы
!+Перикардита
!Разрыва левого желудочка
!Разрыва левого желудочка
@MDID{2A42C391-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ИСТОЧНИКОМ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ:
!+Вены нижних конечностей
!Вены верхних конечностей
!Правое сердце
!Вены таза
!Вены таза
@MDID{2A42C392-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ СОЧЕТАНИЕМ СИМПТОМОВ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ:
!Бронхоспазм, кровохарканье, тахикардия
!+Одышка, цианоз, тахикардия
!Цианоз, бронхоспазм, тахикардия
!Кровохарканье, коллапс, одышка
!Кровохарканье, коллапс, одышка
@MDID{2A42C393-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ:
!Венозный застой в большом круге кровообращения
!Слабость
!Отеки ног
!+Приступы сердечной астмы
!Приступы сердечной астмы
@MDID{2A42C394-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНОЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ МАРКЕР ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:
!Тропонин Т
!Тропонин I
!+Предсердный натрийуретический пептид
!МВ-фракция КФК
!МВ-фракция КФК
@MDID{2A42C395-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}
NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Диагностика заболеваний ЖКТ

?ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ СТЕНОЗА ПИЩЕВОДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С

!+ахалазией пищевода

!грыжей пищеводного отверстия диафрагмы

!дивертикулом пищевода

!туберкулезом пищевода

!туберкулезом пищевода

@MDID{E88AB1D8-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА КАРДИАЛГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЭЗОФАГИТА И СТЕНОКАРДИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

!Проба с жидкими антацидами

!проба с нитроглицерином

!ЭКГ

!+проба с изменением положения тела

!проба с изменением положения тела

@MDID{E88AB1D9-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!гастроскопия

!+гистологическое исследование

!интрагастральная рН-метрия

!рентгеноскопия желудка

!рентгеноскопия желудка

@MDID{E88AB1DA-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?СИНДРОМ ПРИВОДЯЩЕЙ ПЕТЛИ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

!резекции желудка по Бильрот I

!селективной проксимальной ваготомии (СПВ)

!+резекции желудка по Бильрот II

!СПВ и пилоропластики

!СПВ и пилоропластики

@MDID{E88AB1DB-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ОПУХОЛИ ПИЩЕВОДА ТРЕБУЕТСЯ

!торакокопия

!внутрипищеводная рН-метрия

!рентгеноскопия пищевода

!+эзофагоскопия с биопсией

!эзофагоскопия с биопсией

@MDID{E88AB1DC-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ РАКА ЖЕЛУДКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

!выявление синдрома «малых признаков»

!+гастроскопия

!выявление раковой триады по Мельникову

!рентгенография желудка

!рентгенография желудка

@MDID{E88AB1DD-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И РАКОМ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

!эндоскопическое исследование с биопсией

!рентгенологическое исследование

!исследование кала на скрытую кровь

!исследование желудочной секреции с гистамином

!исследование желудочной секреции с гистамином

@MDID{E88AB1DE-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

ПРИ КОПРОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДТВЕРДИТЬ ДИАГНОЗ МАЛЪАБСОРБЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

!скрытой крови в кале

!+креатореи

!йодофильной флоры

!панкреатической эластазы

!панкреатической эластазы

@MDID{E88AB1DF-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

К ЧИСЛУ СЕРЬЕЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЭРБ ОТНОСИТСЯ

!грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

!недостаточность кардии

!ахалазия пищевода

!+пищевод Барретта

!пищевод Барретта

@MDID{E88AB1E0-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

КАКОЙ МЕТОД НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ?

!ирригография

!исследование ферментов

!+колоноскопия

!ректороманоскопия

!ректороманоскопия

@MDID{E88AB1E1-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!увеличение диаметра кишки

!вид "булыжной мостовой"

!+отсутствие гаустрации

!множественная гаустрация

!множественная гаустрация

@MDID{E88AB1E2-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КИШЕЧНИКА ДЛЯ БОЛЕЗНИ КРОНА НЕ ХАРАКТЕРНО

!картина бульжной мостовой

!неравномерное сужение просвета кишки с четкими границами поражения

!псевдодивертикулы

!+изменение гаустрации, вплоть до ее исчезновения

!изменение гаустрации, вплоть до ее исчезновения

@MDID{E88AB1E3-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТОДИК РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЙ СЧИТАЕТСЯ

!стандартная ирригоскопия

!+метод двойного контрастирования толстой кишки

!прием бариевой взвеси рег ос с последующим рентгенологическим контролем за пассажем контраста
по толстой кишке

!фистулография

!фистулография

@MDID{E88AB1E4-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ И ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫМ МЕТОДОМ

ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЧИТАЕТСЯ

!энтерография

!+ангиография

!рентгеновская компьютерная томография

!ультразвуковое исследование

!ультразвуковое исследование

@MDID{E88AB1E5-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

!отсутствие или расстройство перистальтики на ограниченном участке кишки

!нарушение эвакуаторной функции

!+дефект наполнения или плоская “ ниша” на контуре кишечной стенки

!ригидность кишечной стенки на определенном участке

!ригидность кишечной стенки на определенном участке

@MDID{E88AB1E6-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО, ОБРАТИВШЕГОСЯ К ВРАЧУ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ КИШЕЧНИКА, СЛЕДУЕТ
НАЧИНАТЬ С

!рентгенологического исследования толстого кишечника (ирригоскопии)

!+ректального пальцевого исследования

!ректороманоскопии

!ультразвукового исследования

!ультразвукового исследования

@MDID{E88AB1E7-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ В ЗАБРЮШИННЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ

!ультразвуковое исследование органов брюшной полости

!сканирование лимфоузлов

!ангиография

!+КТ брюшной полости

!КТ брюшной полости

@MDID{E88AB1E8-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» В ДИАГНОСТИКЕ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ (ЦЕЛИАКИИ) ЯВЛЯЕТСЯ

!+гистологическое исследование слизистой тонкой кишки

!повышение уровня антиглиадиновых антител

!наличие синдрома мальабсорбции

!эндоскопические данные

!эндоскопические данные

@MDID{E88AB1E9-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ОТЛИЧАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

!цитолитического синдрома

!холестатического синдрома

!коагулопатического синдрома

!+порто-кавальных и кава-кавальных анастомозов

!порто-кавальных и кава-кавальных анастомозов

@MDID{E88AB1EA-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

!стул в виде малинового желе

!+дегтеобразный стул (мелена)

!примесь алой крови в конце дефекации

!кровавый понос

!кровавый понос

@MDID{E88AB1EB-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

!УЗИ поджелудочной железы

!+ретроградная холангиопанкреатография

!МРТ брюшной полости

!рентгенография кишечника с барием

!рентгенография кишечника с барием

@MDID{E88AB1ED-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЧРЕСКОЖНАЯ ХОЛАНГИОГРАФИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ

!хронический гепатит

!цирроз печени

!внутрипеченочный сосудистый блок

!+непроходимость желчных путей с механической желтухой

!непроходимость желчных путей с механической желтухой

@MDID{E88AB1EE-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ

!+щелочной фосфатазы

!АСТ и АЛТ

!гамма-глобулинов

!липопротеинов

!липопротеинов

@MDID{E88AB1EF-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ БУДЕТ

!ретроградная холангиопанкреатография

!транспеченочная холангиография

!+ультрасонография

!лапароскопия

!лапароскопия

@MDID{E88AB1F0-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩЕГО МАРКЕРА

!АнтиHBs

!+HBsAg

!АнтиHBe

!HBsAg

!HBsAg

@MDID{E88AB1F1-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?РЕШАЮЩИМ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ЛЮБОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

!+гистологическое исследование

!повышения трансфераз

!диспротеинемия

!гипербилирубинемия

!гипербилирубинемия

@MDID{E88AB1F2-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГАММАГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ

!вирусного гепатита В и С

!+алкогольного гепатита

!гемохроматоза

!хронического панкреатита

!хронического панкреатита

@MDID{E88AB1F3-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРАНСАМИНАЗ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

!холестаза

!коагулопатии

!печеночно-клеточной недостаточности

!+цитоллиза

!цитоллиза

@MDID{E88AB1F4-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

!+гепатоцеллюлярной карциноме

!холангиоцеллюлярном раке печени

!раке желудка

!раке поджелудочной

!раке поджелудочной

@MDID{E88AB1F5-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

NEW SUBJECT

ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017

Диагностика заболеваний крови

?ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ, ВЫЗЫВАЮЩИМИ ГИПОПЛАСТИЧЕСКУЮ АНЕМИЮ, МОГУТ БЫТЬ?

!+Ионизирующее излучение
!Сероуглерод
!Электросварочная аэрозоль
!Мышьяк
!Мышьяк
@MIDID{F976FA4B-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА ОТНОСИТСЯ?

!Панцитопения
!Спленомегалия
!+Все перечисленное
!Гиперплазия костного мозга
!Гиперплазия костного мозга
@MIDID{F976FA4C-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ КАКОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНЫ МИШЕНЕВИДНЫЕ ЭРИТРОЦИТЫ?

!Наследственный сфероцитоз
!Серповидноклеточная анемия
!+Талассемия
!Железодефицитная анемия
!Железодефицитная анемия
@MIDID{F976FA4D-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКОЙ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ?

!+Ретикулоцитоз
!Гипертромбоцитоз
!Кровоточивость
!Низкий уровень эритропоэтинов
!Низкий уровень эритропоэтинов
@MIDID{F976FA4E-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСТРАЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, КРОМЕ?

!Тяжелые ожоги
!+Острая кровопотеря
!Септическая стрептококковая или анаэробная инфекция
!Малярия
!Малярия
@MIDID{F976FA4F-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИЧИНОЙ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ МОГУТ БЫТЬ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННОЕ, КРОМЕ?

!+Увеличение тиреоидных гормонов
!Истощение депо железа
!Хронической кровопотери
!Нарушение секреции соляной кислоты
!Нарушение секреции соляной кислоты
@MIDID{F976FA50-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОВРЕЖДАЕТСЯ

!Желудок
!12-перстная кишка
!Толстый кишечник
!+Пищевод
!Пищевод
@MIDID{F976FA51-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НЕТИПИЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

!Интерстициальная пневмония
!Синдром мальабсорбции
!Синдром Рейно
!+Плевральный выпот
!Плевральный выпот
@MIDID{F976FA52-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

!+Панкардита
!Перикардита
!Миокардиофиброза
!Миокардита

!Миокардита
@MDID{F976FA53-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ НЕ ХАРАКТЕРНЫ КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ВИДЕ
!Капилляритов
!+«Маскообразности» лица
!Эритематозного дерматита на лице
!Алопеции
!Алопеции
@MDID{F976FA54-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ОТСУТСТВУЕТ
!Синдром Рейно
!Эндокардит Либмана-Сакса
!Гломерулонефрит
!+Кальциноз мягких тканей
!Кальциноз мягких тканей
@MDID{F976FA55-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ПРИЗНАКОМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ
!Алопеция
!Гипер-γ-глобулинемия
!Анемия
!+Повышенный титр анти-ДНК антител
!Повышенный титр анти-ДНК антител
@MDID{F976FA56-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ИСТИННЫЕ "LE" - КЛЕТКИ ЯВЛЯЮТСЯ
!+Нейтрофильными лейкоцитами, фагоцитировавшими ядра других клеток
!Нейтрофилами, фагоцитировавшими лимфоциты
!Моноцитами, фагоцитировавшими ядра других клеток
!Гематоксилиновыми тельцами
!Гематоксилиновыми тельцами
@MDID{F976FA57-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НЕВЕРНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ
!Развитие изолированного суставного синдрома в дебюте заболевания
!+Назначение глюкокортикостероидов при неэффективности цитостатиков
!Наличие тяжелого прогноза при развитии гломерулонефрита
!Наличие семейно-генетической предрасположенности в развитии заболевания
!Наличие семейно-генетической предрасположенности в развитии заболевания
@MDID{F976FA58-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ХАРАКТЕРЕН
!Коронарит
!+Артрит
!Гломерулонефрит
!Церебральный васкулит
!Церебральный васкулит
@MDID{F976FA59-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА НЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ
!+«Механических» болей в коленных суставах
!«Редискообразной» деформации концевых фаланг
!Энтезопатий
!Одностороннего сакроилеита
!Одностороннего сакроилеита
@MDID{F976FA5A-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ РИЗОМЕЛИЧЕСКОЙ ФОРМЫ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА ХАРАКТЕРНО
!Поражение только позвоночника
!Поражение позвоночника и мелких суставов кистей и стоп
!+Поражение позвоночника и корневых суставов
!Поражение позвоночника и периферических суставов
!Поражение позвоночника и периферических суставов
@MDID{F976FA5B-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НЕХАРАКТЕРНЫМИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА ЯВЛЯЮТСЯ

!Двусторонний сакроилеит
!Остеофиты пяточных костей и костей таза
!+0круглые дефекты костей черепа
!Осификация связок позвоночника
!Осификация связок позвоночника
@MDID{F976FA5C-FD8E-11E6-BA26-50E549E7BDDC}
NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Диагностика заболеваний почек

?ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ ОСТРЫЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ЧЕРЕЗ

!3-4 дня

!7 дней

!+10-12 дней

!30 дней

!30 дней

@MDID{1966683A-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КЛАССИЧЕСКАЯ ТРИАДА СИМПТОМОВ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ВКЛЮЧАЕТ

!отеки, сердцебиение, протеинурию

!+отеки, гипертонию, гематурию

!одышку, сердцебиение, цилиндрию

!отеки, одышку, сердцебиение

!отеки, одышку, сердцебиение

@MDID{1966683B-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ FACIESNEFRITICA ЯВЛЯЮТСЯ

!акроцианоз, набухание шейных вен

!геморрагическая сыпь на лице, отеки

!гиперемия лица, набухание шейных вен

!+отеки лица, бледность кожи

!отеки лица, бледность кожи

@MDID{1966683C-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?БОЛИ В ОБЛАСТИ ПОЯСНИЦЫ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ С

!апостематозными изменениями паренхимы почек

!+нарушениями уродинамики и набуханием почек

!ишемическим инфарктом почек

!наличием конкрементов в мочевыделительной системе

!наличием конкрементов в мочевыделительной системе

@MDID{1966683D-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИЗНАКАМИ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЮТСЯ

!+увеличение плотности мочи, щелочная реакция мочи

!изостенурия

!увеличение нейтрофилов в моче

!увеличение лимфоцитов в моче

!увеличение лимфоцитов в моче

@MDID{1966683E-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К НЕФРОТИЧЕСКОМУ СИНДРОМУ ПРИВОДЯТ

!+хронический гломерулонефрит, амилоидоз

!тромбоз почечных вен, пиелонефрит

!туберкулез легких, тромбоэмболия почечных артерий

!острый пиелонефрит, острый гломерулонефрит

!острый пиелонефрит, острый гломерулонефрит

@MDID{19666840-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?СИСТЕМНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

!дерматомиозит

!болезнь Вегенера

!+системная красная волчанка

!болезнь Шегрена

!болезнь Шегрена

@MDID{19666841-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

!лейкоцитурия

!гематурия

!цилиндрурия

!+протеинурия

!протеинурия

@MDID{19666842-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ВКЛЮЧАЕТ

!гипертонию

!+гипоальбуминемию

!гематурию

!гипоизостенурию

!гипоизостенурию

@MID{19666843-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ РАННИЙ ПРИЗНАК АМИЛОИДОЗА

!гематурия

!лейкоцитурия

!изостенурия

!+протеинурия

!протеинурия

@MID{19666844-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ИЗМЕНЕНИЯ БЕЛКОВОГО СОСТАВА КРОВИ ПРИ АМИЛОИДОЗЕ

!+гипоальбуминемия, липопротеинемия

!гипергаммаглобулинемия, гиполипидемия

!гиперальбуминемия, гиперпротеинемия

!гипогаммаглобулинемия, гиперпротеинемия

!гипогаммаглобулинемия, гиперпротеинемия

@MID{19666845-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЛАБОРАТОРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЮТСЯ

!цилиндрурия, глюкозурия

!+лейкоцитурия, бактериурия

!гематурия, протеинурия

!оксалурия, протеинурия

!оксалурия, протеинурия

@MID{19666846-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНЫЕ ТИПЫ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

!нефротический, гипертонический

!максимально активный нефритический

!активный нефритический

!+нефротический, неактивный нефритический

!нефротический, неактивный нефритический

@MID{19666847-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ РАЗВИВАЕТСЯ КАК ИСХОД ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА В

!80-90%

!+10-20%

!50-60%

!70-80%

!70-80%

@MDID{19666848-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЙСЯ ВАРИАНТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

!Гематурический

!нефротический

!+латентный

!гипертонический

!гипертонический

@MDID{19666849-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИЧИНАМИ АНЕМИИ ПРИ ХБП ЯВЛЯЕТСЯ

!гемолиз эритроцитов

!дефицит железа

!дефицит фолиевой кислоты

!+недостаток эритропоэтина

!недостаток эритропоэтина

@MDID{1966684A-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВАРИАНТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, РЕДКО ПРИВОДЯЩИЙ К РАЗВИТИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

!латентный

!+гематурический

!гипертонический

!нефротический

!нефротический

@MDID{1966684B-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВАРИАНТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА, ЧАСТО ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ОСТРО НЕФРИТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

!+мезангиокапиллярный

!мезангиопролиферативный

!мембранный

!фибропластический

!фибропластический

@MDID{1966684C-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИЗНАК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОТЛИЧИТЬ ХРОНИЧЕСКИЙ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ ОТ ОСТРОГО

!наличие дизурических явлений

!выраженная лейкоцитурия

!+уменьшение размеров почек

!гематурия

!гематурия

@MDID{1966684D-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?УРОВЕНЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ ХБП

!+5мл/мин

!20мл/мин

!40мл/мин

!60мл/мин

!60мл/мин

@MDID{1966684E-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НА РАННИХ СТАДИЯХ АМИЛОИДОЗА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНА БИОПСИЯ

!слизистой десны, печени

!кожи, подкожной клетчатки

!+слизистой прямой кишки и почек

!селезенки, лимфоузлов

!селезенки, лимфоузлов

@MDID{19666850-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?МИКРОБЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ПИЕЛОНЕФРИТА

!стафилококки

!стрептококки

!синегнойная палочка

!+кишечная палочка

!кишечная палочка

@MDID{19666851-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?БАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНФЕКЦИЯ, ИГРАЮЩАЯ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА

!золотистый стафилококк

+!В-гемолитический стрептококк

!зеленящий стрептококк

!энтерококк

!энтерококк

!энтерококк

@MDID{19666852-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?УРОВЕНЬ ПРОТЕИНУРИИ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА, СОСТАВЛЯЕТ

!не более 2 г/сут

!100 мг/сут

!+более 3-3.5 г/сут

!До 1 г/сут

!До 1 г/сут

@MDID{19666853-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

NEW SUBJECT

ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017

Диагностика заболеваний ССС

?ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ В ДИАГНОСТИКЕ НЕКРОЗА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

!Щелочная фосфатаза

!Креатинин

!Аспартатаминотрансфераза

!+Тропонин

!Тропонин

@MDID{260BB7AE-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?УКАЖИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ ПРИ КРУПНООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НИЖНЕЙ СТЕНКИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ.

!+Подъем ST в отведениях II, III, aVF.

!Подъем ST в отведениях I, aVL, V₅-V₆.

!Депрессия ST в отведениях I, aVL, V₃-V₄.

!Подъем ST в отведениях aVL, V₃-V₄.

!Подъем ST в отведениях aVL, V₃-V₄.

@MDID{260BB7AF-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?УКАЖИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ ПРИ ПЕРЕДНЕБОКОВОМ КРУПНООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ.

!Подъем ST в отведениях II, III, aVF.

!+Подъем ST в отведениях I, aVL, V₅-V₆.

!Отрицательный зубец T в отведениях II, III, aVF.

!Депрессия ST в отведениях II, III, aVF.

!Депрессия ST в отведениях II, III, aVF.

@MDID{260BB7B0-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СТЕНОКАРДИИ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

!МРТ

!Мониторирование ЭКГ по Холтеру.

!+Стресс-эхокардиография

!ЭКГ

!ЭКГ

@MDID{260BB7B1-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЛИПИДОВ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ АТЕРОГЕННЫМИ?

!Хиломикроны

!+Липопротеиды высокой плотности

!Липопротеиды низкой плотности

!Триглицериды

!Триглицериды

@MDID{260BB7B2-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫБЕРИТЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА, НЕ ВОЗНИКАЮЩЕЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ

!Тромбоз легочной артерии

!Кардиогенный шок

!+Синдром Дресслера

!Разрыв миокарда

!Разрыв миокарда
@MDID{260BB7B3-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ
!Сдавление коронарных артерий извне
!Острое воспаление коронарных артерий
!+Это любая группа признаков, характеризующих обострение коронарной болезни сердца
!Ранняя постинфарктная стенокардия
!Ранняя постинфарктная стенокардия
@MDID{260BB7B4-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЭКГ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В МИОКАРДЕ?
!Инверсия зубца Т
!+Укорочение интервала PR (PQ) менее 0,12 сек
!Желудочковая экстрасистолия
!Атриовентрикулярная блокада II ст. типа Мобитц I (с периодами Самойлова-Венкебаха)
!Атриовентрикулярная блокада II ст. типа Мобитц I (с периодами Самойлова-Венкебаха)
@MDID{260BB7B5-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ МИОКАРДИТА НЕХАРАКТЕРНА
!+Гиперхолестеринемия
!Гиперфибриногенемия
!Повышенная концентрация С-реактивного белка
!Повышенная концентрация КФК и ее изофермента - КФК-MB
!Повышенная концентрация КФК и ее изофермента - КФК-MB
@MDID{260BB7B6-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ СУХОМ ПЕРИКАРДИТЕ АУСКУЛЬТАТИВНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
!Усиление тонов
!Шум трения плевры
!Крепитация
!+Шум трения перикарда
!Шум трения перикарда
@MDID{260BB7B7-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?АУСКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЗНАК ЭКССУДАТИВНОГО ПЕРИКАРДИТА
!Усиление первого тона на верхушке сердца
!+Ослабление тонов сердца
!Акцент второго тона на аорте
!Акцент второго тона на легочной артерии
!Акцент второго тона на легочной артерии
@MDID{260BB7B8-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ГИПЕРТРОФИЯ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ И ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА С УМЕНЬШЕНИЕМ ЕГО ПОЛОСТИ
НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ КАРДИОМИОПАТИИ
!Ишемической
!Дилатационной
!+Гипертрофической
!Рестриктивной
!Рестриктивной
@MDID{260BB7B9-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ
!+Нарушения ритма сердца
!Инфаркт миокарда
!Застойная сердечная недостаточность
!Отек легких
!Отек легких
@MDID{260BB7BA-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА Эхо-КГ ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
!Гипертрофия стенок правого предсердия
!Гипертрофия межжелудочковой перегородки

!Сужение левого атриовентрикулярного отверстия
!+Диффузное снижение сократительной способности миокарда
!Диффузное снижение сократительной способности миокарда
@MDID{260BB7BB-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН
!Диастолический шум на верхушке
!+Систолический шум относительной митральной недостаточности
!Шум над аортой
!Систолический шум над аортой
!Систолический шум над аортой
@MDID{260BB7BC-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ЗАВИСЯТ ОТ
!+Степени обструкции выносящего тракта левого желудочка
!Наличия аритмий
!Выраженности диастолической дисфункции
!Наличия ишемии миокарда
!Наличия ишемии миокарда
@MDID{260BB7BD-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}
NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Диагностика пороков сердца

?НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СТЕНОЗА УСТЬЯ АОРТЫ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ:
!+Ревматизм
!Инфекционный эндокардит
!Атеросклероз
!Артериальная гипертензия
!Артериальная гипертензия
@MDID{30D9B6AD-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СТЕНОЗА УСТЬЯ АОРТЫ У ЛЮДЕЙ СТАРШЕ 60 ЛЕТ:
!Инфекционный эндокардит
!Ревматизм.
!+Атеросклероз
!Синдром Марфана
!Синдром Марфана
@MDID{30D9B6AE-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ У БОЛЬНЫХ С АОРТАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СВЯЗАНЫ:
!+С неадекватностью коронарного кровообращения
!С нарушениями ритма сердца
!С развитием сердечной недостаточности
!С неадекватностью мозгового кровообращения
!С неадекватностью мозгового кровообращения
@MDID{30D9B6AF-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА СТЕНОЗА УСТЬЯ АОРТЫ:
!С нарушениями ритма сердца
!+С неадекватностью коронарного кровообращения
!С развитием сердечной недостаточности
!С неадекватностью мозгового кровообращения
!С неадекватностью мозгового кровообращения
@MDID{30D9B6B0-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА СТЕНОЗА УСТЬЯ АОРТЫ:
!Хлопающий первый тон на верхушке и диастолический шум.
!+Ослабление тонов на основании сердца и систолический шум с проведением на сосуды шеи.
!Диастолический шум у основания мечевидного отростка.
!Ослабление тонов на основании сердца и диастолический шум.
!Ослабление тонов на основании сердца и диастолический шум.
@MDID{30D9B6B1-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:
!+На основании сердца ослабление тонов и диастолический шум в точке Боткина-Эрба

!На основании сердца ослабление тонов и систолический шум с иррадиацией на сосуды шеи
!На верхушке хлопающий I тон и диастолический шум в точке Боткина-Эрба
!У основания мечевидного отростка ослабление тонов и систолический шум
!У основания мечевидного отростка ослабление тонов и систолический шум
@MDID{30D9B6B2-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА?

!Систолический шум на верхушке сердца, усиливающийся на выдохе
!Акцент и раздвоение II тона над аортой
!Систолический шум на верхушке сердца, усиливающийся на вдохе
!+Хлопающий I тон
!Хлопающий I тон
@MDID{30D9B6B3-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСОБЕННОСТИ АД У БОЛЬНЫХ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ:

!Повышение диастолического АД, снижение систолического АД
!АД не изменяется
!Повышение систолического и диастолического АД
!+Повышение систолического АД, снижение диастолического АД
!Повышение систолического АД, снижение диастолического АД
@MDID{30D9B6B4-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}
NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Лечение заболеваний легких 11

? ?НАЗНАЧЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ И КОНТРОЛЬ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНОГО
БРОНХИТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

! !кофеин, кордиамин
! !кодеин, либексин
! !бекотид, интал
!+ !+амоксциллин, бромгексин
!+амоксциллин, бромгексин

! !+амоксциллин, бромгексин
!+амоксциллин, бромгексин

@MDID{A4332F34-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?К ПРЕПАРАТАМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

! ! недокромил натрия
! ! +тиотропиум бромид
! !фенотерол
! !эуфиллин
!эуфиллин

! !эуфиллин
!эуфиллин

@MDID{A4332F35-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?КАКОЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ОТНОСИТСЯ К ИНГАЛЯЦИОННЫМ СТЕРОИДАМ

! !фликсотид (флютиказона пропионат)
! !бекотид (беклометазона дипропионат)
!+ !+дексаметазон
! !ингакорт (флунизолид)
!ингакорт (флунизолид)

! !ингакорт (флунизолид)
!ингакорт (флунизолид)

@MDID{A4332F36-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ДЛЯ САНАЦИИ БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА У БОЛЬНЫХ С БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВЕН МЕТОД

!+ !+лечебной бронхоскопии
! !дыхательной гимнастики
! !внутримышечной антибиотикотерапии канамицином

!
!ингаляции с тетрациклином
!ингаляции с тетрациклином

!
!ингаляции с тетрациклином
!ингаляции с тетрациклином

@MDID{A4332F37-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
!
!кодеин
!+ !+беротек
!
!либексин
!
!тусупрекс
!тусупрекс

!
!тусупрекс
!тусупрекс

@MDID{A4332F38-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?В МЕЖПРИСТУПНОМ ПЕРИОДЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЮТ
!
!интал
!
!астмопент
!
!теofilлин
!+
!+беротек
!+беротек

!
!+беротек
!+беротек

@MDID{A4332F39-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРОТИВПОКАЗАН
!
!астмопент
!+
!+морфин
!
!беротек
!
!эуфиллин
!эуфиллин

!
!эуфиллин
!эуфиллин

@MDID{A4332F3A-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО СНИЖАЮТ ДАВЛЕНИЕ В ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
!
!нитраты
!
!сердечные гликозиды
!+
!+ингибиторы ФДЗ-5 (силденафил)
!
!ингибиторы АПФ
!ингибиторы АПФ

!
!ингибиторы АПФ
!ингибиторы АПФ

@MDID{A4332F3B-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ
!
!цефалоспорин 3-го поколения
!
!тетрациклин
!
!пенициллин
!+
!+эритромицин
!+эритромицин

!
!+эритромицин
!+эритромицин

@MDID{A4332F3C-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?КАКОЙ АНТИБИОТИК ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ПРИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ?
! !гентамицин
! !ампициллин
!+ !+пенициллин
! !эритромицин
!эритромицин
!
!эритромицин
!эритромицин

@MDID{A4332F3D-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?В КАКИХ СЛУЧАЯХ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ПРОВОДИТСЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДНАЯ ТЕРАПИЯ?
!+ !+при выраженном бронхообструктивном синдроме с явлениями дыхательной !недостаточности
! !при легочной гипертензии
! !при признаках гнойной инфекции
! !не проводится ни в каких случаях
!не проводится ни в каких случаях
!
!не проводится ни в каких случаях
!не проводится ни в каких случаях

@MDID{A4332F3E-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ
! !ацетилцистеина
! !антибиотиков
!+ !+кортикостероидов и цитостатиков
! !витамина Е
!витамина Е
!
!витамина Е
!витамина Е

@MDID{A4332F3F-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГОЧНОГО МУКОВИСЦИДОЗА ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЕНИЕ
! !кортикостероидов
! !генно-инженерных антицитокиновых препаратов
! !цитостатиков
!+ !+пульмозима (альфа-дорназа)
!+пульмозима (альфа-дорназа)
!
!+пульмозима (альфа-дорназа)
!+пульмозима (альфа-дорназа)

@MDID{A4332F40-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ
! !регидратации
!+ !+системных кортикостероидов
! !отхаркивающих препаратов
! !кислородотерапии
!кислородотерапии
!
!кислородотерапии
!кислородотерапии

@MDID{A4332F41-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ПРИ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОМ ЛЕГОЧНОМ СЕРДЦЕ НЕ ОБОСНОВАНО НАЗНАЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА
! !коргликона
! !гепарина
! !фуросемида
!+ !+эуфиллина
!+эуфиллина
!
!+эуфиллина

!+эуфиллина

@MDID{A4332F42-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ АХП
(АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ) ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ?
! !сальметерол
! !ипратропия бромид
!+ !+тиотропия бромид (спирива)
! !фенотерол
! !фенотерол

! !фенотерол
! !фенотерол

@MDID{A4332F43-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОБЛАДАЕТ ОДНОВРЕМЕННО МУКОЛИТИЧЕСКОЙ И
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ?
! !аброксол
!+ !+N-ацетилцистеина
! !лазолван
! !бромгексин
! !бромгексин

! !бромгексин
! !бромгексин

@MDID{A4332F44-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОДЕПРЕССАНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ САРКОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ
!+ !+генерализованная форма саркоидоза, когда гранулематозное поражение, распространилось
на многие органы
! !дыхательная недостаточность
! !средняя степень тяжести
! !длительно протекающий воспалительный процесс
! !длительно протекающий воспалительный процесс

! !длительно протекающий воспалительный процесс
! !длительно протекающий воспалительный процесс

@MDID{A4332F45-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ТИОТРОПИЯ БРОМИДА ЯВЛЯЮТСЯ
! !закрытоугольная глаукома
! !сердечная недостаточность
! !артериальная гипертензия
!+ !+беременность и детский, подростковый возраст до 18 лет
!+ !+беременность и детский, подростковый возраст до 18 лет

! !+беременность и детский, подростковый возраст до 18 лет
! !+беременность и детский, подростковый возраст до 18 лет

@MDID{A4332F46-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?ПРИ КАКОМ ОСЛОЖНЕНИИ ПНЕВМОНИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГКС?
! !абсцедировании
!+ !+инфекционно-токсическом шоке
! !сердечной недостаточности
! !сепсисе
! !сепсисе

! !сепсисе
! !сепсисе

@MDID{A4332F47-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ?КАКИЕ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ КОМБИНИРОВАННЫМИ?

!
!
!
!+
!
!формотерол
!атровент
!сальбутамол
!+беродуал
!+беродуал
@MDID{A4332F48-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?
!
!
!+
!
?
!противотуберкулезные
!бронхолитики
!+ГКС
!витамин Е
!витамин Е
!
!витамин Е
!витамин Е

@MDID{A4332F49-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?
!
!+
!
!
?
!С ЦЕЛЮ ПРОФИЛАКТИКИ ТЭЛА У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА ИСПОЛЬЗУЮТ
!дипиридамол
!+ксарелто
!ацетилсалициловая кислота
!никотиновая кислота
!никотиновая кислота
!
!никотиновая кислота
!никотиновая кислота

@MDID{A4332F4A-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?
!
!
!+
!
?
!ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ ХЛАМИДИЕЙ
!ампициллин
!пенициллин
!+доксациклин, эритромицин
!гентамицин
!гентамицин
!
!гентамицин
!гентамицин

@MDID{A4332F4B-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?
!
!
!
!+
!
?
!ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ ПНЕВМОНИИ МЕНИНГИТОМ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ
!мексидол
!фенобарбитал
!дазепам
!+20% раствор маннитола Лечение заболеваний ЖКТ
!+20% раствор маннитола Лечение заболеваний ЖКТ

@MDID{A4332F4C-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Диагностика заболеваний ЖКТ 11

?ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ СТЕНОЗА ПИЩЕВОДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ С

!+ахалазией пищевода

!грыжей пищеводного отверстия диафрагмы

!дивертикулом пищевода

!туберкулезом пищевода

!туберкулезом пищевода

@MDID{AE582C7D-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА КАРДИАЛГИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ЭЗОФАГИТА И СТЕНОКАРДИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

!Проба с жидкими антацидами

!проба с нитроглицерином

!ЭКГ

!+проба с изменением положения тела

!проба с изменением положения тела

@MDID{AE582C7E-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!гастроскопия

!+гистологическое исследование

!интрагастральная рН-метрия

!рентгеноскопия желудка

!рентгеноскопия желудка

@MDID{AE582C7F-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?СИНДРОМ ПРИВОДЯЩЕЙ ПЕТЛИ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ

!резекции желудка по Бильрот I

!селективной проксимальной ваготомии (СПВ)

!+резекции желудка по Бильрот II

!СПВ и пилоропластики

!СПВ и пилоропластики

@MDID{AE582C80-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ОПУХОЛИ ПИЩЕВОДА ТРЕБУЕТСЯ

!торакокопия

!внутрипищеводная рН-метрия

!рентгеноскопия пищевода

!+эзофагоскопия с биопсией

!эзофагоскопия с биопсией

@MDID{AE582C81-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ РАННЮЮ ДИАГНОСТИКУ РАКА ЖЕЛУДКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ

!выявление синдрома «малых признаков»

!+гастроскопия

!выявление раковой триады по Мельникову

!рентгенография желудка

!рентгенография желудка

@MDID{AE582C82-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И РАКОМ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

!+эндоскопическое исследование с биопсией

!рентгенологическое исследование

!исследование кала на скрытую кровь

!исследование желудочной секреции с гистамином

!исследование желудочной секреции с гистамином

@MDID{AE582C83-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ КОПРОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПОДТВЕРДИТЬ ДИАГНОЗ МАЛЬАБСОРБЦИИ ПОЗВОЛЯЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

!скрытой крови в кале

!+креатореи

!йодофильной флоры

!панкреатической эластазы

!панкреатической эластазы

@MDID{AE582C84-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К ЧИСЛУ СЕРЬЕЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЭРБ ОТНОСИТСЯ

!грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

!недостаточность кардии

!ахалазия пищевода

!+пищевод Барретта

!пищевод Барретта

@MDID{AE582C85-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКОЙ МЕТОД НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ?

!ирригография

!исследование ферментов

!+колоноскопия

!ректороманоскопия

!ректороманоскопия

@MDID{AE582C86-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!увеличение диаметра кишки

!вид "булыжной мостовой"

!+отсутствие гаустрации

!множественная гаустрация

!множественная гаустрация

@MDID{AE582C87-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ РЕНТГЕНОВСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КИШЕЧНИКА ДЛЯ БОЛЕЗНИ КРОНА НЕ ХАРАКТЕРНО

!картина булжной мостовой

!неравномерное сужение просвета кишки с четкими границами поражения

!псевдодивертикулы

!+изменение гаустрации, вплоть до ее исчезновения

!изменение гаустрации, вплоть до ее исчезновения

@MDID{AE582C88-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МЕТОДИК РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЙ СЧИТАЕТСЯ

!стандартная ирригоскопия

!+метод двойного контрастирования толстой кишки

!прием бариевой взвеси рег ос с последующим рентгенологическим контролем за пассажем контраста по толстой кишке

!фистулография

!фистулография

@MDID{AE582C89-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ТОНКОЙ КИШКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СЧИТАЕТСЯ

!энтерография

!+ангиография

!рентгеновская компьютерная томография

!ультразвуковое исследование

!ультразвуковое исследование

@MDID{AE582C8B-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

!отсутствие или расстройство перистальтики на ограниченном участке кишки

!нарушение эвакуаторной функции

!+дефект наполнения или плоская “ ниша” на контуре кишечной стенки

!ригидность кишечной стенки на определенном участке

!ригидность кишечной стенки на определенном участке

@MDID{AE582C8C-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО, ОБРАТИВШЕГОСЯ К ВРАЧУ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИЙ КИШЕЧНИКА, СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

!рентгенологического исследования толстого кишечника (ирригоскопии)

!+ректального пальцевого исследования

!ректороманоскопии

!ультразвукового исследования

!ультразвукового исследования

@MDID{AE582C8D-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ В ЗАБРЮШИННЫЕ ЛИМФОУЗЛЫ

!ультразвуковое исследование органов брюшной полости

!сканирование лимфоузлов

!ангиография

!+КТ брюшной полости

!КТ брюшной полости

@MDID{AE582C8E-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?«ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» В ДИАГНОСТИКЕ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ (ЦЕЛИАКИИ) ЯВЛЯЕТСЯ

!+гистологическое исследование слизистой тонкой кишки

!повышение уровня антиглиадиновых антител

!наличие синдрома мальабсорбции

!эндоскопические данные

!эндоскопические данные

@MDID{AE582C8F-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ОТЛИЧАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

!цитолитического синдрома

!холестатического синдрома

!коагулопатического синдрома

!+порто-кавальных и кава-кавальных анастомозов

!порто-кавальных и кава-кавальных анастомозов

@MDID{AE582C90-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

!стул в виде малинового желе

!+дегтеобразный стул (мелена)

!примесь алой крови в конце дефекации

!кровавый понос

!кровавый понос

@MDID{AE582C91-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫРАБОТКА АНТИТЕЛ К ОБКЛАДОЧНЫМ КЛЕТКАМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРОИСХОДИТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ

!типа В

!типа С

!гипертрофическом

!+типа А

!типа А

@MDID{AE582C92-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЦЕННЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+уровень амилазы крови и мочи

!лейкоцитоз

!уровень аминотрансфераз

!гипергликемия

!гипергликемия

@MDID{AE582C93-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

!УЗИ поджелудочной железы

!+ретроградная холангиопанкреатография

!МРТ брюшной полости

!рентгенография кишечника с барием

!рентгенография кишечника с барием

@MDID{AE582C94-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЧРЕСКОЖНАЯ ХОЛАНГИОГРАФИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ

!хронический гепатит

!цирроз печени

!внутрипеченочный сосудистый блок

!+непроходимость желчных путей с механической желтухой

!непроходимость желчных путей с механической желтухой

@MDID{AE582C95-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ

!+щелочной фосфатазы

!АСТ и АЛТ

!гамма-глобулинов

!липопротеинов

!липопротеинов

@MDID{AE582C96-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ БУДЕТ

!ретроградная холангиопанкреатография

!транспеченочная холангиография

!+ультрасонография

!лапароскопия

!лапароскопия

@MDID{AE582C97-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДЛЯ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ СЛЕДУЮЩЕГО МАРКЕРА

!АнтиHBs

!+HBsAg

!АнтиHBe

!HBsAg

!HBsAg

@MDID{AE582C98-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?РЕШАЮЩИМ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ЛЮБОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

!+гистологическое исследование

!повышения трансфераз

!диспротеинемия

!гипербилирубинемия

!гипербилирубинемия

@MDID{AE582C99-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГАММАГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ

!вирусного гепатита В и С

!+алкогольного гепатита

!гемохроматоза

!хронического панкреатита

!хронического панкреатита

@MDID{AE582C9A-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ТРАНСАМИНАЗ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

!холестаза

!коагулопатии

!печеночно-клеточной недостаточности

!+цитолиза

!цитолиза

@MDID{AE582C9B-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИН ЧАЩЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

!+гепатоцеллюлярной карциноме

!холангиоцеллюлярном раке печени

!раке желудка

!раке поджелудочной

!раке поджелудочной

@MDID{AE582C9C-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

NEW SUBJECT

ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017

Лечение инфаркта миокарда 11

?ПАЦИЕНТ 60 ЛЕТ ЖАЛУЕТСЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЗАГРУДИННЫЕ БОЛИ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА. АД - 165/95 мм рт. ст. ЧСС - 80 в/мин. ИМЕЕТСЯ ДЕПРЕССИЯ ST В ОТВЕДЕНИЯХ II, III, AVF. КАКОЙ ПРЕПАРАТ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

!Дигоксин

!Фуросемид

!Моксонидин

!+Бисопролол

!Бисопролол

@MDID{B96FF624-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?У ПАЦИЕНТА В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЧАСОВ ОТМЕЧАЕТСЯ ИНТЕНСИВНАЯ ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ. АД - 140/90 мм рт. ст. ЧСС - 100 в/мин. НА ЭКГ ПОДЪЕМОВ ST НЕ ВЫЯВЛЕНО. КАКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ ИМЕЕТ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ?

!+Ацетилсалициловая кислота

!Морфин

!Нитраты

!Тромболизис

!Тромболизис

@MDID{B96FF625-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПАЦИЕНТ 75 ЛЕТ ИСПЫТЫВАЕТ СИЛЬНУЮ БОЛЬ В ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ НА ПРОТЯЖЕНИЕ 2-Х ЧАСОВ. АД - 140/90 мм рт. ст. ЧСС - 100 в/мин. НА ЭКГ ПОДЪЕМОВ ST НЕ ВЫЯВЛЕНО. ТРОПОНИН Т НЕ ПОВЫШЕН. ОН ПОЛУЧИЛ АСПИРИН, КЛОПИДОГРЕЛЬ, ЭНОКСАПАРИН, БИСОПРОЛОЛ, НИТРАТ И МОРФИН. ВЫБЕРИТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ.

!Аорто-коронарное шунтирование

!Тромболизис

!Внутриаортальная баллонная контрпульсация

!+Чрескожное вмешательство на коронарных артериях

!Чрескожное вмешательство на коронарных артериях

@MDID{B96FF626-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАРИНОМ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

!МНО
!+АЧТВ
!Фибриногена
!РФМК
!РФМК
@MDID{B96FF627-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ТРОМБОЛИЗИСА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА?

!Высокая артериальная гипертония
!Перенесенный год назад ишемический инсульт
!+Перенесенный несколько лет назад геморрагический инсульт
!Язвенная болезнь в анамнезе
!Язвенная болезнь в анамнезе
@MDID{B96FF628-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВЫБЕРИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИЗИСА

!Эноксапарин
!Аспирин
!+Тканевой активатор плазминогена
!Клопидогрель
!Клопидогрель
@MDID{B96FF629-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКОВА СТАНДАРТНАЯ НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА КЛОПИДОГРЕЛЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА?

!150 мг
!600 мг
!+300 мг
!450 мг
!450 мг
@MDID{B96FF62A-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ДРЕССЛЕРА?

!Статин
!Антибиотик
!Гепарин
!+Аспирин
!Аспирин
@MDID{B96FF62B-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}
NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Лечение кардиомиопатий 11

?ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРИТМИЙ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

!Изоптина
!+Кордарона
!Хинидина
!Новокаиамида
!Новокаиамида
@MDID{C053D1CF-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ В-БЛОКАТОРОВ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ?

!+320-480 мг
!40-80 мг
!120-240 мг
!160-200 мг
!160-200 мг
@MDID{C053D1D0-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ЕСЛИ У БОЛЬНОГО С РЕСТРИКТИВНОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ПОЯВИТСЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ТО СЛЕДУЕТ ПРИМЕНИТЬ

!Оксигенотерапию

!Фуросемид
!+Эуфиллин
!Пропранолол
!Пропранолол
@MDID{C053D1D1-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНЫ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ?

!Ингибиторы АПФ
!+β-блокаторы
!Нитраты
!Сердечные гликозиды
!Сердечные гликозиды
@MDID{C053D1D2-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Лечение сердечной недостаточности 11

?КАКОЙ ПРЕПАРАТ НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАЗОПРЕССОРАМ?

!Дофамин
!Адреналин
!Эфедрин
!+Обзидан
!Обзидан
@MDID{C8C2D1E7-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МОРФИНА У БОЛЬНЫХ С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ:

!Отек легких на фоне порока сердца
!+Отек легких у больных старческого возраста
!Отек легких на фоне гипертонического криза
!Отек легких на фоне инфаркта
!Отек легких на фоне инфаркта
@MDID{C8C2D1E8-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?МАКСИМАЛЬНЫЕ СУТОЧНЫЕ ДОЗЫ ФУРОСЕМИДА У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДОСТИГАЮТ:

!200 мг
!+600 мг и более
!300 мг
!500 мг
!500 мг
@MDID{C8C2D1E9-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД АВ-СОЕДИНЕНИЯ:

!+Увеличивается
!Уменьшается
!Не меняется
!Возможны все варианты
!Возможны все варианты
@MDID{C8C2D1EB-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?К ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ:

!Диуретики
!Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента
!+Блокаторы медленных кальциевых каналов
!Кардиоселективные бетаадреноблокаторы
!Кардиоселективные бетаадреноблокаторы
@MDID{C8C2D1EC-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКОЙ ИЗ ДИУРЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ОКАЗЫВАЕТ МИНИМАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ПРОФИЛЬ?

!Фуросемид
!+Торасемид

!Гипотиазид
!Диакарб
!Диакарб
@MDID{C8C2D1ED-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ НАЗНАЧЕНИЕ ЦИТОСТАТИКОВ КАК ОСНОВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ЭРИТРЕМИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

!Наклонность к тромбозам
!Выраженный плеторический синдром
!+Выраженный миелопролиферативный синдром
!Увеличение показателя гематокрита и вязкости крови
!Увеличение показателя гематокрита и вязкости крови
@MDID{C8C2D1EE-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В КАКОЙ СТАДИИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНСОЛИДАЦИИ?

!+Развернутая стадия
!Рецидив
!Ремиссия
!Терминальная стадия
!Терминальная стадия
@MDID{C8C2D1EF-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ?

!Дезинфицирующие средства местно
!+Все перечисленное
!Введение стимуляторов естественного иммунитета
!Антибиотики
!Антибиотики
@MDID{C8C2D1F0-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}
NEW SUBJECT
ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017
Лечение системных заболеваний соединительной ткани 11

?ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА РЕЙНО ЯВЛЯЕТСЯ

!Дипиридамол
!+Нифедипин
!Папаверин
!Лозартан
!Лозартан
@MDID{CF45EFE4-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ В ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОМИОЗИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!Азатиоприн
!+Преднизолон
!Делагил
!Колхицин
!Колхицин
@MDID{CF45EFE5-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?СТАНДАРТНАЯ ДОЗА ИНФЛИКСИМАБА ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛОАРТРИТЕ СОСТАВЛЯЕТ

!+5 мг на 1 кг массы тела 1 раз в 8 недель
!7 мг на 1 кг массы тела 1 раз в 8 недель
!3 мг на 1 кг массы тела 1 раз в 12 недель
!7 мг на 1 кг массы тела 1 раз в 12 недель
!7 мг на 1 кг массы тела 1 раз в 12 недель
@MDID{CF45EFE6-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ЛЕЧЕНИИ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА ХЛАМИДИЙНОЙ ЭТИОЛОГИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

!Цефазолин
!Гентамицин
!Ампициллин
!+Азитромицин
!Азитромицин
@MDID{CF45EFE7-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА, РЕЗИСТЕНТНОГО К ТЕРАПИИ «СТАНДАРТНЫМИ» БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ДОКАЗАНА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОГО ПРЕПАРАТА

!Абатацепта

!Ритуксимаба

!Тоцилизумаба

!+Инфликсимаба

!Инфликсимаба

@MDID{CF45EFE8-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ ПСОРИАТИЧЕСКОГО АРТРИТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

!Алфлутоп

!Делагил

!+Метотрексат

!Преднизолон

!Преднизолон

@MDID{CF45EFE9-FD8F-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

NEW SUBJECT

ХИРУРГИЧЕСКАЯ_СТОМАТОЛОГИЯ_ОРДИНАТ_ИНТЕРН_2017

Диагностика заболеваний легких

?АУСКУЛЬТАТИВНО ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ

!+сухие и влажные хрипы

!крепитация

!бронхиальное дыхание

!шум трения плевры

!шум трения плевры

@MDID{20AC98C0-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ДИАГНОЗУ ОСТРЫЙ БРОНХИТ СООТВЕТСТВУЕТ АНАЛИЗ МОКРОТЫ

!"ржавая" мокрота вязкой консистенции, лейкоциты 30-40 в поле зрения, эритроциты на одну треть поля зрения,

!мокрота белого цвета, вязкая, стекловидная, без запаха, при микроскопии лейкоцитов 2-4 в поле зрения, эозинофилов 10-15 в поле зрения, спирали Куршмана

!+мокрота желтовато-белого цвета, слизисто-гнойная, при микроскопии лейкоцитов 40-60 в поле зрения, эритроцитов 4-6 в поле зрения, единичные макрофаги.

!слизистая мокрота, вязкая, с прожилками крови, без запаха

!слизистая мокрота, вязкая, с прожилками крови, без запаха

@MDID{20AC98C1-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

!+кашель с мокротой не менее 3 мес в году на протяжении последних двух лет

!наличие бронхиальной обструкции

!изменение газового состава крови

!появление у больного одышки при обычной физической нагрузке.

!появление у больного одышки при обычной физической нагрузке.

@MDID{20AC98C2-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

! исследование мокроты

! рентгенография легких

! + бронхоскопия с биопсией

! спирометрия

! спирометрия

@MDID{20AC98C3-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

! рентгеноскопия грудной клетки

! спирография

! флюорография

! + мультиспиральная томография

! мультиспиральная томография

@MDID{20AC98C4-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ПРИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ МОКРОТА

! «ржавая»

! + гнойная

! розовая

! стекловидная

! стекловидная

@MDID{20AC98C5-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? АУСКУЛЬТАТИВНО ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ

! крепитация

! влажные хрипы

! шум трения плевры

! + сухие свистящие хрипы

! сухие свистящие хрипы

@MDID{20AC98C6-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СО СТОРОНЫ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

! + эозинофилия

! лейкоцитоз

! сдвиг лейкоцитарной формулы влево

! лимфопения

! лимфопения

@MID{20AC98C7-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? В МОКРОТЕ БОЛЬНОГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПОСЛЕ ПРИСТУПА ОБНАРУЖИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ:

! эластические волокна

! пробки Дитриха

! + спирали Куршмана

! клетки Березовского-Штернберга

! клетки Березовского-Штернберга

@MID{20AC98C8-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ПРИ ЭМФИЗЕМЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

! полость с горизонтальным уровнем жидкости

! + повышенная прозрачность легочных полей

! гомогенное затемнение с косой верхней границей

! очаговое затемнение

! очаговое затемнение

@MID{20AC98C9-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

! анализ крови

! анализ мокроты

! плевральная пункция

! + рентгенография органов грудной клетки

! рентгенография органов грудной клетки

@MID{20AC98CA-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ГАНГРЕНЫ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

! легочная конденсация (инфильтрация)

! + диффузное легочное затемнение с очагами деструкции (пчелиные соты)

! синдром легочного растяжения (гиперинфляции)

! четкое жидкостное образование

! четкое жидкостное образование

@MID{20AC98CB-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ АБСЦЕССА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

! спирометрия

! анализ крови

! + рентгенография

!анализ мокроты

!анализ мокроты

@MDID{20AC98CC-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АБСЦЕССА ЛЕГКОГО ПОСЛЕ ПРОРЫВА В БРОНХ ЯВЛЯЕТСЯ

!округлая тень

!+полость с горизонтальным уровнем жидкости

!повышенная прозрачность легочных полей

!тень поджатого легкого

!тень поджатого легкого

@MDID{20AC98CD-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

!бронхография

!спирометрия

!+флюорография

!бронхоскопия

!бронхоскопия

@MDID{20AC98CE-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? АТИПИЧНЫЕ КЛЕТКИ В МОКРОТЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИ

!+раке легкого

!бронхите

!пневмонии

!туберкулезе

!туберкулезе

@MDID{20AC98CF-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СОСТАВА КРОВИ ПРИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

!снижение содержания эритроцитов и гемоглобина

!повышение содержания остаточного азота

!гиперлипидемия

!+гипоксемия и гиперкапния

!гипоксемия и гиперкапния

@MDID{20AC98D0-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ПРИ СУХОМ ПЛЕВРИТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА

!+без особенностей

!возрастание воздушности легочной ткани

!затемнение в соответствующей доле легкого

!пятнистая тень

!пятнистая тень

@MDID{20AC98D1-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?с какой из форм осумкованной эмпиемы плевры болеезатруднен дифференциальный диагноз острого абсцесса легкого?

!верхушечной эмпиемой

!пристеночной эмпиемой

!+междолевой эмпиемой с бронхиальным свищем

!наддиафрагмальной эмпиемой

!наддиафрагмальной эмпиемой

@MDID{20AC98D2-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?аускультативным признаком легочной артериальной гипертензии является

!+акцент II тона на легочной артерии

!акцент II тона на аорте

!"хлопающий" I тон на верхушке

!щелчок открытия митрального клапана

!щелчок открытия митрального клапана

@MDID{20AC98D3-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?наиболее информативными методами диагностики тзла являются

!рентгенологические

!лабораторные

!+ультразвуковые и радионуклидные

!ЭКГ

!ЭКГ

@MDID{20AC98D4-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

?обязательным этапом диагностики хобл является

!исследование анализа мокроты

!+исследование функции внешнего дыхания

!рентгенологическое исследование

!ЭКГ исследование

!ЭКГ исследование

@MDID{20AC98D5-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? КАКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ПОДТВЕРЖДАЮТ ДИАГНОЗ ХОБЛ?

! колебания ПСВ при мониторировании с помощью пикфлоуметра более 20%

! прирост ОФВ1 после применения бронхолитика более чем на 15% (200 мл)

! снижение ЖЗЛ

! + снижение ОФВ1 менее 80% от должного, ОФВ1/ЖЕЛ менее 70% от должного

! снижение ОФВ1 менее 80% от должного, ОФВ1/ЖЕЛ менее 70% от должного

@MDID{20AC98D6-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ КТВР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭКЗОГЕННОГО АЛЬВЕОЛИТА ЯВЛЯЮТСЯ

! изменения по типу «матового стекла»

! + множественные центрилобулярные микроузелки с нечетким контуром

! увеличение лимфоузлов средостения

! обеднение периферического сосудистого рисунка легких

! обеднение периферического сосудистого рисунка легких

@MDID{20AC98D7-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}

? НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЭКЗОГЕННОГО АЛЬВЕОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

! + биопсия

! МС КТ

! рентгенография

! спирография

! спирография

@MDID{20AC98D8-FD90-11E6-BA26-50E549E7BDDC}